



Optimal
Untuk
Negeri



optimal



Bunga Rampai **ASUHAN KEBIDANAN DASAR**

Panduan Praktis Untuk Kehamilan, Persalinan, Nifas, Dan Bayi Baru Lahir

Sulikah • Jumriani • Dwi Ardani Rochmaniah
Sendy Pratiwi Rahmadhani • Veryudha Eka Prameswari
Heni Elmiani Sari • Riska Afriani • Sri Musfiroh

Editor: Umu Qonitun

BUNGA RAMPAI
ASUHAN KEBIDANAN DASAR: PANDUAN PRAKTIS
UNTUK KEHAMILAN, PERSALINAN, NIFAS, DAN BAYI
BARU LAHIR

Penulis:

Sulikah, SST., MKES.
Bdn. Jumriani, S.ST., M.Keb.
Dwi Ardani Rochmaniah, SST., M.Keb.
Sندی Pratiwi Rahmadhani, S.ST., Bdn., M.Keb.
Veryudha Eka Prameswari, SST., M.Kes.
Heni Elmiani Sari, SST., MPH.
Bdn.Riska Afriani, S.Tr.Keb., M.Kes.
Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.

Editor:

Umu Qonitun, S.ST., M.Keb., M.M.



BUNGA RAMPAI ASUHAN KEBIDANAN DASAR: PANDUAN PRAKTIS UNTUK KEHAMILAN, PERSALINAN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR

Penulis:

Sulikah, SST., MKES.

Bdn. Jumriani, S.ST., M.Keb.

Dwi Ardani Rochmaniah, SST., M.Keb.

Sendy Pratiwi Rahmadhani, S.ST., Bdn., M.Keb.

Veryudha Eka Prameswari, SST., M.Kes.

Heni Elmiani Sari, SST., MPH.

Bdn.Riska Afriani, S.Tr.Keb., M.Kes.

Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.

Editor: Umu Qonitun, S.ST., M.Keb., M.M.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7556-54-7

Cetakan Pertama : Februari, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, taufik, dan karunia-Nya, buku berjudul “Bunga Rampai Asuhan Kebidanan Dasar: Panduan Praktis untuk Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini disiapkan sebagai salah satu upaya untuk menghadirkan bacaan yang bermanfaat, aplikatif, dan relevan bagi dunia pendidikan serta praktik kebidanan, khususnya dalam memperkuat pemahaman mengenai asuhan kebidanan dasar yang menjadi fondasi utama pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Asuhan kebidanan merupakan rangkaian pelayanan yang berkesinambungan dan berpusat pada kebutuhan perempuan sepanjang siklus reproduksi. Pelayanan tersebut mencakup masa kehamilan, proses persalinan, masa nifas, hingga perawatan bayi baru lahir fase-fase yang masing-masing memiliki karakteristik, tantangan, dan kebutuhan yang berbeda. Pada setiap tahap, bidan dituntut mampu melakukan pengkajian yang cermat, memberikan edukasi yang tepat, mengenali tanda bahaya secara dini, serta melakukan tindakan yang sesuai standar keselamatan. Sejalan dengan itu, kemampuan komunikasi yang empatik dan efektif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas asuhan, karena keberhasilan pelayanan bukan hanya ditentukan oleh keterampilan klinis, tetapi juga oleh hubungan terapeutik yang terbangun antara bidan, pasien, dan keluarga.

Buku ini disusun dalam bentuk bunga rampai agar materi dapat disajikan secara lebih kaya, variatif, dan mudah diakses oleh pembaca. Penyajian seperti ini memungkinkan pembahasan disampaikan dari berbagai sudut pandang dengan tetap menjaga kesatuan tema, sehingga pembaca memperoleh pemahaman yang menyeluruh sekaligus praktis. Materi dalam buku ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami konsep dasar kebidanan sekaligus menerapkannya dalam situasi nyata di lapangan, baik dalam lingkungan pendidikan, praktik klinik, maupun pelayanan di fasilitas kesehatan. Penekanan pada panduan praktis dimaksudkan agar buku ini tidak hanya menjadi referensi teori, melainkan juga menjadi pegangan yang mampu mendukung ketepatan langkah asuhan dan pengambilan keputusan.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa kebidanan sebagai penguatan materi pembelajaran, bagi dosen sebagai pendamping referensi dalam proses pengajaran, serta bagi bidan dan tenaga kesehatan lain sebagai rujukan ringkas untuk

menyegarkan kembali konsep dasar dan prinsip pelayanan yang aman. Harapannya, buku ini dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kebidanan melalui pemahaman yang baik terhadap prosedur dasar, komunikasi yang efektif, serta sikap profesional yang menjunjung etika, empati, dan penghormatan terhadap nilai budaya pasien.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan, baik dalam kelengkapan maupun kedalaman pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pada kesempatan berikutnya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta kontribusi dalam proses penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berkat bantuan dan kerja sama berbagai pihak, buku ini dapat tersusun dengan baik dan siap digunakan sebagai bahan belajar serta referensi.

Akhir kata, semoga “Bunga Rampai Asuhan Kebidanan Dasar: Panduan Praktis untuk Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir” dapat memberikan manfaat yang luas, menambah wawasan, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kebidanan demi terwujudnya kesehatan ibu dan bayi yang lebih baik. Semoga buku ini juga dapat menjadi kontribusi sederhana dalam penguatan praktik kebidanan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada keselamatan.

Februari, 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 KONSEP DASAR ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN

(CONTINUITY OF CARE) 1

Sulikah, S.ST., M.Kes. 1

A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Definisi Asuhan Kebidanan Berkelanjutan	1
C. Filosofi Continuity of Care	2
D. Prinsip Asuhan Kebidanan Berkelanjutan.....	2
E. Tujuan Asuhan Kebidanan Berkelanjutan.....	3
F. Ruang Lingkup Asuhan Kebidanan Berkelanjutan	4
G. Manfaat Continuity of Care	4
H. Peran dan Tanggung Jawab Bidan dalam Continuity of Care	5
I. Tahapan Pelaksanaan Asuhan Kebidanan Berkelanjutan	6
J. Model Pelayanan CoC	7
K. CoC dalam Sistem Pelayanan kesehatan Primer	9
L. Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Continuity of Care (Coxon et al., 2017).....	9
M.Upaya Peningkatan Mutu Asuhan Kebidanan Berkelanjutan (WHO, 2016).....	11
N. Etika dan Legalitas dalam Continuity of Care	12
O. Simpulan.....	12
P. Referensi.....	13
Q. Glosarium.....	14

CHAPTER 2 PENGKAJIAN KEHAMILAN DASAR TTV, TAKSIRAN

PERSALINAN DAN KELUHAN UMUM.....17

Bdn. Jumriani, S.ST., M.Keb.17

A. Pendahuluan / Prolog.....	17
B. Konsep Dasar Pengkajian Kehamilan.....	18
C. Pemeriksaan Tanda Vital (Ttv) Pada Ibu Hamil.....	23
D. Taksiran Persalinan (Tp)	27
E. Keluhan Umum Pada Ibu Hamil.....	29
F. Simpulan.....	32
G. Referensi.....	33

H. Golosarium	35
CHAPTER 3 EDUKASI SEDERHANA PADA IBU HAMIL: NUTRISI, TANDA BAHAYA, DAN PERSIAPAN PERSALINAN.....	40
Dwi Ardani Rochmaniah, SST., M.Keb.....	40
A. Pendahuluan / Prolog.....	40
B. Edukasi Pada Ibu Hamil	40
C. Hambatan dalam Memberikan edukasi pada ibu hamil.....	50
D. Upaya Mengatasi Hambatan Edukasi.....	51
E. Simpulan.....	51
F. Referensi.....	52
G. Glosarium.....	53
CHAPTER 4 ASUHAN PERSALINAN NORMAL: LANGKAH-LANGKAH DASAR YANG MUDAH DIPAHAMI	54
Sendy Pratiwi Rahmadhani, S.ST., Bdn., M.Keb.	54
A. Pendahuluan / Prolog.....	54
B. Peran Bidan Selama Persalinan	55
C. Asuhan Sayang Ibu	57
D. Pengetahuan dan Keterampilan Klinik Kebidanan dalam Persalinan dan Kelahiran yang Normal dan Kondisi Komplek.....	60
E. Kala III Persalinan: Manajemen Aktif Kala III.....	65
F. Kesimpulan	65
G. Referensi.....	66
H. Glosarium.....	66
CHAPTER 5 MANAGEMEN NYERI PERSALINAN DENGAN TEKNIK NONFARMAKOLOGIS	67
Veryudha Eka Prameswari, SST., M.Kes.....	67
A. Pendahuluan / Prolog.....	67
B. Konsep Dasar Nyeri Persalinan	68
C. Teori Nyeri Persalinan.....	72
D. Manajemen Nyeri Selama Persalinan	73
E. Manajemen Nyeri Non-Farmakologis pada persalinan	74
F. Teknik Nonfarmakologis dalam Manajemen Nyeri Persalinan.....	75
G. Simpulan.....	80
H. Referensi.....	81
I. Glosarium.....	82

CHAPTER 6 ASUHAN IBU NIFAS: PERAWATAN LUKA, LAKTASI, DAN EDUKASI KELUARGA.....	84
Heni Elmiani Sari, S.ST., M.PH.....	84
A. Pendahuluan/Prolog	84
B. Perawatan Luka	85
C. Laktasi.....	88
D. Edukasi Keluarga	92
E. Simpulan.....	96
F. Referensi.....	97
G. Glosarium.....	101
 CHAPTER 7 KOMUNIKASI EFEKTIF BIDAN DENGAN PASIEN DAN KELUARGA	 103
Bdn. Riska Afriani, S.Tr.Keb., M.Kes.....	103
A. Pendahuluan / Prolog.....	103
B. Hakikat Komunikasi dalam Praktik Kebidanan	104
C. Prinsip dan Unsur Komunikasi Efektif.....	104
D. Komunikasi Terapeutik dalam Pelayanan Kebidanan	104
E. Komunikasi pada Ibu Hamil	105
F. Komunikasi pada Masa Nifas dan Menyusui	105
G. Komunikasi dalam Situasi Sulit dan Gawat Darurat	106
H. Komunikasi dengan Keluarga Pasien.....	106
I. Hambatan Komunikasi dan Cara Mengatasinya.....	106
J. Dokumentasi dan Evaluasi Komunikasi.....	106
K. Kesimpulan	107
L. Referensi.....	107
M.Glosarium.....	108
 CHAPTER 8 PERAN BIDAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING PADA 1000 HPK	 109
Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.	109
A. Pendahuluan.....	109
B. Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK)	109
C. Intervensi Gizi Spesifik dalam Pencegahan Stunting pada 1000.....	111
D. Hambatan dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan.....	114
E. Simpulan.....	116
F. Referensi.....	118
G. Glosarium.....	120
 PROFIL PENULIS	 123

CHAPTER 1

KONSEP DASAR ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN (CONTINUITY OF CARE)

Sulikah, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Asuhan kebidanan berkelanjutan (*Continuity of Care*) merupakan pendekatan pelayanan kebidanan yang menekankan kesinambungan asuhan secara komprehensif kepada perempuan, bayi, dan keluarga sepanjang siklus kehidupan reproduksi. Pendekatan ini lahir dari kebutuhan akan pelayanan kebidanan yang tidak terfragmentasi, melainkan terintegrasi dan berfokus pada kebutuhan individu perempuan sebagai pusat asuhan (*woman-centered care*).

Dalam praktik kebidanan, perempuan mengalami berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial sejak masa pra-kehamilan hingga masa nifas dan perawatan bayi. Oleh karena itu, pelayanan kebidanan yang diberikan secara terpisah dan tidak berkesinambungan berpotensi mengurangi mutu pelayanan serta meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan pada ibu dan bayi. Asuhan kebidanan berkelanjutan hadir sebagai solusi untuk memastikan setiap perempuan memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan berkesinambungan.

Melalui *Continuity of Care*, bidan berperan sebagai pendamping utama yang memberikan asuhan secara konsisten, berkesinambungan, dan berbasis bukti. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan ibu dan bayi, tetapi juga untuk memperkuat hubungan saling percaya antara bidan dan klien, meningkatkan kepuasan pelayanan, serta mendukung upaya penurunan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi.

B. Definisi Asuhan Kebidanan Berkelanjutan

Suatu pendekatan pelayanan kebidanan yang diberikan secara berkesinambungan, terpadu, dan berkelanjutan oleh bidan kepada perempuan, bayi, dan keluarga, mulai dari masa pra-kehamilan, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, hingga pelayanan kesehatan reproduksi, dengan menempatkan perempuan sebagai pusat asuhan (*woman-centered care*).

Pendekatan *Continuity of Care* menekankan adanya hubungan yang berkelanjutan antara bidan dan klien, sehingga bidan memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi bio-psiko-sosial-spiritual klien. Melalui asuhan yang

berkesinambungan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan ibu dan bayi, kepuasan klien, serta berkontribusi dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi.

C. Filosofi Continuity of Care

Filosofi *woman-centered care* merupakan landasan utama dalam penerapan *Continuity of Care* pada pelayanan kebidanan. Pendekatan ini menempatkan perempuan sebagai subjek utama dan pusat asuhan, bukan sekadar penerima pelayanan. Setiap perempuan dipandang sebagai individu yang unik, memiliki kebutuhan, nilai, keyakinan, serta pengalaman yang berbeda dalam setiap tahap kehidupan reproduksinya.

Dalam konteks *Continuity of Care*, filosofi *woman-centered care* menekankan pentingnya hubungan yang berkelanjutan dan saling percaya antara bidan dan perempuan. Hubungan ini memungkinkan bidan memahami kondisi perempuan secara menyeluruh, meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Dengan demikian, asuhan yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga memperhatikan pengalaman, kenyamanan, dan pilihan perempuan.

Pendekatan ini juga menghargai hak perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya. Bidan berperan sebagai mitra yang memberikan informasi berbasis bukti, dukungan, dan pendampingan, sehingga perempuan mampu membuat keputusan yang sadar dan bertanggung jawab terhadap kesehatannya sendiri.

D. Prinsip Asuhan Kebidanan Berkelanjutan

1. Kesiambungan Hubungan (*Continuity of Relationship*)

Asuhan diberikan secara berkelanjutan oleh bidan yang sama atau tim kecil bidan, sehingga terjalin hubungan yang konsisten dan berkesinambungan antara bidan dan perempuan. Hubungan ini meningkatkan rasa aman, kepercayaan, dan kenyamanan selama masa kehamilan, persalinan, hingga nifas.

2. Individualisasi Asuhan

Setiap asuhan disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan preferensi perempuan. Bidan menghargai perbedaan latar belakang sosial, budaya, pendidikan, serta pengalaman perempuan dalam merencanakan dan menerima asuhan kebidanan.

3. Penghormatan terhadap Hak dan Pilihan Perempuan

Perempuan memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan mudah dipahami. Bidan wajib menghormati pilihan perempuan, sepanjang tidak

membahayakan keselamatan ibu dan bayi, serta mendukung pengambilan keputusan secara bersama (*shared decision making*).

4. Asuhan Holistik

Continuity of Care berbasis *woman-centered care* memperhatikan perempuan secara utuh, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, bukan hanya mencegah atau menangani masalah kesehatan.

5. Pemberdayaan Perempuan (*Empowerment*)

Bidan berperan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri perempuan agar mampu merawat diri sendiri, bayinya, serta berperan aktif dalam menjaga kesehatannya dan keluarganya.

6. Kemitraan dan Dukungan Keluarga

Asuhan kebidanan dilaksanakan dengan melibatkan keluarga sebagai sistem pendukung utama, tanpa mengurangi kemandirian dan otoritas perempuan sebagai pengambil keputusan utama terkait kesehatannya.

7. Asuhan Aman dan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Care*)

Setiap tindakan kebidanan dilakukan berdasarkan standar profesi, pedoman klinis, dan bukti ilmiah terkini, sehingga menjamin keselamatan ibu dan bayi dalam seluruh rangkaian asuhan berkelanjutan.

E. Tujuan Asuhan Kebidanan Berkelanjutan

1. Menurunkan AKI dan AKB: Asuhan berkelanjutan membantu deteksi dini komplikasi sehingga dapat mencegah kematian ibu dan bayi.
2. Pelayanan sepanjang siklus kehidupan: CoC mencakup prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, hingga lansia
3. Integrasi layanan: Menghubungkan berbagai level pelayanan kesehatan (rawat jalan, klinik, rumah sakit) dan program pencegahan
4. Membangun hubungan berkelanjutan: CoC menekankan kemitraan, dukungan emosional, dan kepercayaan antara bidan dan klien.
5. Meningkatkan kesejahteraan jangka panjang: Dengan pelayanan berkesinambungan, kesejahteraan ibu dan bayi dapat terjaga secara menyeluruh (Kemenkes RI, 2022).

F. Ruang Lingkup Asuhan Kebidanan Berkelanjutan

1. Asuhan Kehamilan (Antenatal Care)

- a. Meliputi pelayanan pemeriksaan rutin ibu hamil untuk memantau kesehatan ibu dan janin.
- b. Fokus pada deteksi dini komplikasi, pemenuhan gizi, imunisasi, konseling tanda bahaya, serta persiapan persalinan.
- c. Tujuannya adalah memastikan kehamilan berlangsung sehat dan aman hingga persalinan.

2. Asuhan Persalinan (Intranatal Care)

- a. Bidan memberikan pelayanan selama proses persalinan dengan prinsip aman, nyaman, dan sesuai standar.
- b. Meliputi pemantauan kemajuan persalinan, dukungan emosional, pencegahan komplikasi, serta tindakan pertolongan persalinan normal.
- c. Bila terjadi komplikasi, bidan bertanggung jawab melakukan rujukan tepat waktu.

3. Asuhan Nifas (Postnatal Care)

- a. Dilakukan sejak selesai persalinan hingga 6 minggu setelahnya.
- b. Fokus pada pemulihan kondisi ibu, pencegahan perdarahan, deteksi infeksi, konseling menyusui, serta dukungan psikologis.
- c. Bidan juga memberikan edukasi tentang kontrasepsi pasca persalinan.

4. Asuhan Bayi Baru Lahir dan Neonatus

- a. Meliputi pemeriksaan fisik bayi, inisiasi menyusui dini (IMD), pemantauan tumbuh kembang, serta imunisasi dasar.
- b. Bidan berperan dalam pencegahan stunting sejak dini melalui edukasi gizi dan ASI eksklusif.
- c. Deteksi dini kelainan bawaan atau gangguan tumbuh kembang juga menjadi bagian penting dari CoC (Viandika & Septiasari, 2020; Kemenkes RI, 2023).

G. Manfaat Continuity of Care

1. Manfaat bagi Ibu dan Bayi

- a. Deteksi dini komplikasi: Pemantauan berkelanjutan memungkinkan masalah kesehatan ibu dan bayi dikenali lebih cepat sehingga penanganan lebih efektif.
- b. Rasa aman dan nyaman: Ibu merasa lebih tenang karena mendapatkan dukungan dari bidan yang sama sepanjang siklus kehamilan, persalinan, nifas, hingga bayi baru lahir.
- c. Peningkatan kualitas kesehatan: CoC membantu menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi.

- d. Dukungan emosional: Hubungan yang terjalin dengan bidan meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam menjalani proses kehamilan dan peran sebagai orang tua.

2. Manfaat bagi Keluarga

- a. Keterlibatan keluarga: CoC mendorong keluarga untuk aktif mendukung ibu dalam setiap tahap, sehingga tercipta lingkungan yang sehat.
- b. Peningkatan pengetahuan: Keluarga mendapatkan informasi yang konsisten tentang perawatan ibu dan bayi, termasuk gizi, pola asuh, dan tanda bahaya.
- c. Penguatan ikatan keluarga: Dengan dukungan berkelanjutan, keluarga lebih siap menghadapi perubahan peran dan tanggung jawab setelah kelahiran bayi.
- d. Efisiensi biaya: Pencegahan komplikasi melalui CoC dapat mengurangi beban biaya pengobatan yang lebih besar.

3. Manfaat bagi Bidan dan Sistem Pelayanan Kesehatan

- a. Kualitas pelayanan meningkat: Bidan dapat memberikan asuhan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan sesuai standar.
- b. Hubungan profesional yang kuat: Bidan membangun kepercayaan dengan klien, sehingga meningkatkan kepuasan pasien.
- c. Efisiensi sistem kesehatan: CoC mengurangi rujukan yang tidak perlu, menekan angka komplikasi, dan meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya kesehatan.
- d. Data dan dokumentasi lebih lengkap: Dengan pendampingan berkelanjutan, bidan memiliki catatan yang konsisten untuk evaluasi dan audit mutu pelayanan.

H. Peran dan Tanggung Jawab Bidan dalam Continuity of Care

Peran dan tanggung jawab bidan dalam Continuity of Care (CoC) mencakup pemberian asuhan utama, edukasi dan konseling, koordinasi rujukan, serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Semua peran ini bertujuan memastikan pelayanan kebidanan yang holistik, berkesinambungan, dan berkualitas.

1. Bidan sebagai pemberi asuhan utama

- a. Bidan menjadi tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kebidanan mulai dari prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, hingga keluarga berencana.
- b. Peran ini menekankan deteksi dini komplikasi, pencegahan masalah kesehatan, serta pemberian dukungan fisik dan emosional kepada ibu dan keluarga.

2. Bidan sebagai pendidik dan konselor

- a. Bidan berperan sebagai pendidik dengan memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, tanda bahaya kehamilan, gizi, perawatan bayi, dan kontrasepsi.
- b. Sebagai konselor, bidan membantu ibu dan keluarga dalam pengambilan keputusan yang tepat terkait kesehatan, serta memberikan dukungan psikologis untuk meningkatkan rasa percaya diri (ICM, 2018; Rohani & Sari, 2019).
- c. Bidan sebagai koordinator rujukan
 - 1) Bidan bertanggung jawab melakukan rujukan tepat waktu bila ditemukan komplikasi atau kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
 - 2) Koordinasi ini memastikan ibu dan bayi mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, sehingga menurunkan risiko kesakitan dan kematian.

3. Kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain

- a. Continuity of Care menuntut bidan untuk bekerja sama dengan dokter, perawat, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya.
- b. Kolaborasi ini memperkuat sistem pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas asuhan, dan memastikan ibu serta bayi mendapatkan pelayanan komprehensif.

I. Tahapan Pelaksanaan Asuhan Kebidanan Berkelanjutan

1. Pengkajian Berkelanjutan

- a. Dilakukan sejak awal kontak dengan ibu, bayi, dan keluarga hingga seluruh siklus asuhan.
- b. Meliputi pengumpulan data subjektif (keluhan, riwayat kesehatan, riwayat obstetri) dan objektif (pemeriksaan fisik, laboratorium, tanda vital) (Varney et al., 2014; Kemenkes RI, 2022).

2. Perencanaan Asuhan Individual

- a. Berdasarkan hasil pengkajian, bidan menyusun rencana asuhan yang spesifik, realistis, dan sesuai kondisi klien.
- b. Rencana mencakup intervensi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- c. Perencanaan harus melibatkan ibu dan keluarga agar tercipta kesepakatan dan rasa memiliki terhadap proses asuhan.

3. Pelaksanaan Asuhan Berkesinambungan

- a. Bidan memberikan pelayanan sesuai rencana, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, hingga bayi baru lahir.

- b. Pelaksanaan dilakukan dengan prinsip holistik, aman, dan sesuai standar praktik kebidanan.
- c. Asuhan berkesinambungan memastikan ibu dan bayi mendapatkan dukungan fisik, psikologis, sosial, dan edukatif secara konsisten.

4. Evaluasi dan Tindak Lanjut

- a. Bidan melakukan evaluasi terhadap hasil asuhan: apakah tujuan tercapai, apakah ada masalah baru, atau apakah intervensi perlu disesuaikan.
- b. Tindak lanjut dapat berupa konseling tambahan, rujukan ke fasilitas kesehatan lain atau penyesuaian rencana asuhan.
- c. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan klien.

5. Dokumentasi Asuhan (SOAP/Varney)

- a. Semua tahapan asuhan harus didokumentasikan dengan format standar, seperti SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan) atau 7 langkah Varney (Varney et al., 2014; Kemenkes RI, 2022).
- b. Dokumentasi berfungsi sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan, bukti hukum, serta dasar untuk evaluasi mutu pelayanan.
- c. Catatan yang lengkap dan akurat membantu kesinambungan asuhan serta memudahkan audit pelayanan kebidanan.

J. Model Pelayanan CoC

1. Midwife-Led Continuity Model (Homer et al., 2014).

- a. Pengertian
Midwife-led continuity model adalah model pelayanan di mana satu bidan (atau bidan utama) bertanggung jawab penuh terhadap asuhan kebidanan seorang perempuan secara berkelanjutan selama periode reproduksi.
- b. Karakteristik
 - 1) Satu bidan utama sebagai *primary caregiver*
 - 2) Hubungan terapeutik yang kuat
 - 3) Pendekatan holistik dan berpusat pada perempuan
 - 4) Rujukan dilakukan bila ditemukan komplikasi
- c. Kelebihan
 - 1) Meningkatkan kepercayaan dan komunikasi
 - 2) Menurunkan intervensi medis yang tidak perlu
 - 3) Meningkatkan kepuasan ibu
- d. Keterbatasan
 - 1) Beban kerja bidan tinggi
 - 2) Kurang fleksibel bila jumlah klien banyak

e. Contoh di Indonesia

- 1) Praktik Mandiri Bidan (PMB)
- 2) Pendampingan ibu hamil risiko rendah secara berkelanjutan

2. *Team Midwifery Model* (Poltekkes Kemenkes Malang, 2017).

a. Pengertian

Team midwifery model adalah pelayanan CoC yang diberikan oleh tim kecil bidan (2–6 orang) yang bekerja secara terkoordinasi untuk melayani kelompok klien tertentu.

b. Karakteristik

- 1) Asuhan tetap berkesinambungan
- 2) Klien mengenal beberapa bidan dalam satu tim
- 3) Sistem shift yang terorganisir

c. Kelebihan

- 1) Beban kerja lebih seimbang
- 2) Kontinuitas tetap terjaga
- 3) Lebih realistis untuk fasilitas besar

d. Keterbatasan

- 1) Hubungan personal tidak sekuat model bidan tunggal
- 2) Membutuhkan koordinasi tim yang baik

e. Contoh Implementasi

- 1) Ruang KIA Puskesmas
- 2) Klinik bersalin dengan beberapa bidan tetap

3. *Shared Care Model*

a. Pengertian

Shared care model adalah model pelayanan CoC yang dilakukan secara kolaboratif antara bidan dengan tenaga kesehatan lain (dokter, perawat, ahli gizi), terutama untuk kasus risiko tinggi.

b. Karakteristik

- 1) Bidan tetap berperan utama pada asuhan normal
- 2) Dokter menangani kasus komplikasi
- 3) Koordinasi dan rujukan berjenjang

c. Kelebihan

- 1) Aman untuk ibu dengan risiko tinggi
- 2) Memaksimalkan kompetensi lintas profesi
- 3) Mengurangi keterlambatan penanganan komplikasi

d. Keterbatasan

- 1) Kontinuitas personal bisa berkurang
- 2) Memerlukan sistem komunikasi yang baik

- e. Contoh
 - 1) ANC terpadu di Puskesmas
 - 2) Kolaborasi bidan–dokter di RS rujukan

K. CoC dalam Sistem Pelayanan kesehatan Primer

1. CoC di Puskesmas

- a. ANC terpadu dan terjadwal
- b. Kunjungan rumah ibu hamil dan nifas
- c. Rujukan berjenjang FKTP–FKTL
- d. Integrasi dengan program KIA dan stunting

2. CoC di Praktik Mandiri Bidan (PMB)

- a. Pendampingan ibu sejak hamil sampai KB
- b. Asuhan individual dan berkesinambungan
- c. Edukasi dan konseling intensif

3. CoC di Posyandu

- a. Pemantauan ibu hamil, nifas, dan bayi
- b. Kolaborasi kader dan bidan
- c. Pencatatan KIA dan deteksi dini risiko

4. Peran CoC dalam Transformasi Layanan Primer

- a. Mendukung pelayanan promotif–preventif
- b. Memperkuat sistem rujukan
- c. Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan KIA

L. Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Continuity of Care (Coxon et al., 2017).

Pelaksanaan asuhan kebidanan berkelanjutan (Continuity of Care) merupakan pendekatan ideal dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan keselamatan ibu serta bayi. Namun, dalam praktiknya, penerapan CoC masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik yang bersumber dari tenaga kesehatan, sistem pelayanan, maupun dari klien dan lingkungan Poltekkes

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan CoC adalah keterbatasan jumlah bidan, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan daerah terpencil. Beban kerja yang tinggi menyebabkan bidan sulit memberikan asuhan secara berkesinambungan kepada klien yang sama sejak masa kehamilan hingga nifas. Kondisi ini berdampak pada terputusnya kesinambungan hubungan antara bidan dan perempuan.

2. Sistem Pelayanan Kesehatan yang Belum Optimal

Sistem pelayanan kesehatan yang masih bersifat terfragmentasi menjadi hambatan dalam penerapan CoC. Pergantian tenaga kesehatan, sistem rujukan yang belum terintegrasi secara optimal, serta keterbatasan koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan dapat mengganggu kesinambungan asuhan kebidanan yang seharusnya diterima oleh perempuan dan keluarganya.

3. Keterbatasan Waktu dan Beban Administratif

Tingginya beban administratif dan tuntutan pelaporan sering kali mengurangi waktu bidan untuk memberikan asuhan yang bersifat holistik dan berkelanjutan. Dokumentasi yang belum terintegrasi secara efektif juga dapat menjadi kendala dalam menjaga kesinambungan informasi asuhan antar kunjungan dan antar tenaga kesehatan.

4. Kompetensi dan Pemahaman Bidan terhadap CoC

Tidak semua bidan memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam menerapkan konsep Continuity of Care secara menyeluruh. Perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman klinik, serta keterbatasan pelatihan berkelanjutan dapat memengaruhi kualitas implementasi CoC dalam praktik kebidanan.

5. Faktor Klien dan Keluarga

Hambatan juga dapat berasal dari klien dan keluarga, seperti rendahnya pengetahuan tentang pentingnya asuhan berkelanjutan, kurangnya kepatuhan terhadap jadwal kunjungan, serta pengaruh budaya dan kepercayaan yang tidak selaras dengan prinsip asuhan kebidanan. Kondisi sosial ekonomi yang rendah juga dapat membatasi akses perempuan terhadap pelayanan kebidanan yang berkesinambungan.

6. Dukungan Kebijakan dan Regulasi

Keterbatasan kebijakan operasional yang secara khusus mendukung model Continuity of Care dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Tanpa dukungan kebijakan, standar pelayanan, serta sistem pembiayaan yang memadai, bidan sering mengalami kesulitan dalam menerapkan CoC secara optimal dan berkelanjutan.

7. Tantangan dalam Kolaborasi dan Rujukan

Pelaksanaan CoC membutuhkan kolaborasi yang baik antar tenaga kesehatan dan sistem rujukan yang efektif. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar profesi dapat menyebabkan terputusnya kesinambungan asuhan, terutama pada kasus yang memerlukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut.

M. Upaya Peningkatan Mutu Asuhan Kebidanan Berkelanjutan (WHO, 2016)

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, diperlukan berbagai upaya strategis guna meningkatkan mutu pelaksanaan Asuhan Kebidanan Berkelanjutan.

1. Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Bidan

Bidan perlu terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan klinis, serta pembaruan praktik berbasis bukti (*evidence-based midwifery*). Peningkatan kompetensi ini mendukung kemampuan bidan dalam memberikan asuhan yang aman, efektif, dan berkesinambungan.

2. Penguatan Penerapan Standar dan Pedoman Pelayanan

Pelaksanaan asuhan kebidanan berkelanjutan harus mengacu pada standar profesi, pedoman nasional, dan kebijakan kesehatan yang berlaku. Standarisasi pelayanan membantu menjaga mutu, keselamatan, dan konsistensi asuhan yang diberikan kepada klien.

3. Optimalisasi Sistem Pelayanan dan Jejaring Rujukan

Penguatan sistem pelayanan kesehatan, termasuk penjadwalan pelayanan, koordinasi antar tenaga kesehatan, serta sistem rujukan yang efektif, sangat diperlukan untuk menjamin kesinambungan asuhan kebidanan.

4. Peningkatan Kualitas Dokumentasi Asuhan

Dokumentasi asuhan kebidanan yang lengkap, akurat, dan berkesinambungan melalui format SOAP atau manajemen kebidanan Varney merupakan bagian penting dalam peningkatan mutu pelayanan. Dokumentasi yang baik mendukung komunikasi antar tenaga kesehatan dan menjadi dasar evaluasi mutu asuhan.

5. Pemberdayaan Klien dan Keluarga

Edukasi dan konseling yang berkelanjutan kepada perempuan dan keluarga perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan pemahaman, partisipasi aktif, dan kepatuhan terhadap asuhan kebidanan berkelanjutan. Keterlibatan keluarga sebagai sistem pendukung memperkuat keberhasilan CoC.

6. Monitoring dan Evaluasi Mutu Pelayanan

Pelaksanaan audit maternal dan perinatal, supervisi klinik, serta evaluasi rutin terhadap pelayanan kebidanan berkelanjutan merupakan upaya penting untuk mengidentifikasi masalah, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menjamin keselamatan ibu dan bayi.

N. Etika dan Legalitas dalam Continuity of Care

Etika dan legalitas merupakan aspek fundamental dalam pelaksanaan Continuity of Care. Dalam praktik kebidanan, bidan wajib menjunjung tinggi prinsip etika, antara lain menghormati otonomi perempuan, berbuat baik (*beneficence*), tidak merugikan (*non-maleficence*), keadilan, dan menjaga kerahasiaan klien. Penerapan CoC menuntut bidan untuk membangun hubungan profesional yang dilandasi kepercayaan, komunikasi yang jujur, serta penghormatan terhadap hak dan pilihan perempuan. Setiap tindakan kebidanan harus dilakukan dengan persetujuan klien (*informed consent*) dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi klien. Dari aspek legalitas, bidan harus menjalankan praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar profesi, dan kewenangan praktik kebidanan. Dokumentasi asuhan yang lengkap dan sistematis menjadi bukti legal atas pelayanan yang diberikan. Dengan memperhatikan aspek etika dan hukum, Continuity of Care dapat dilaksanakan secara aman, profesional, dan memberikan perlindungan hukum bagi bidan maupun klien.

O. Simpulan

Asuhan kebidanan berkelanjutan (*Continuity of Care*) merupakan pendekatan pelayanan kebidanan yang menempatkan perempuan sebagai pusat asuhan dan dilaksanakan secara menyeluruh serta berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan reproduksi. Pendekatan ini didasarkan pada filosofi *woman-centered care*, yang menghargai keunikan, hak, dan pilihan perempuan dalam setiap tahap pelayanan kebidanan.

Pelaksanaan *Continuity of Care* mencakup tahapan pengkajian berkelanjutan, perencanaan asuhan individual, pelaksanaan asuhan berkesinambungan, evaluasi dan tindak lanjut, serta dokumentasi asuhan yang sistematis. Dengan penerapan tahapan tersebut, bidan mampu memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan klien.

Secara keseluruhan, *Continuity of Care* memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan, memperkuat peran bidan sebagai pendamping perempuan, serta berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan ibu dan bayi. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan konsep dasar asuhan kebidanan berkelanjutan menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki oleh setiap bidan dalam praktik profesionalnya.

P. Referensi

- Astuti, et al. (2017). *Konsep dasar continuity of care*. Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar.
- Coxon, K., Sandall, J., & Fulop, N. (2017). How continuity of care is experienced within maternity services: A qualitative study. *Midwifery*, 49, 58–64.
- Gustianingsih, & Arlyn, L. T. (2020). Implementasi asuhan kebidanan berkelanjutan (continuity of care midwifery) di TPMB N Kebon Jeruk Jakarta Barat. *Jurnal Kebidanan Universitas Nasional Jakarta*.
- Homer, C. S. E., Brodie, P. M., & Leap, N. (2008). *Midwifery continuity of care: A practical guide*. Sydney, Australia: Elsevier.
- Homer, C. S. E., et al. (2014). Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (11).
- International Confederation of Midwives. (2014). *Philosophy and model of midwifery care*. The Hague, Netherlands: ICM.
- International Confederation of Midwives. (2018). *ICM global standards for midwifery education*. ICM.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman transformasi layanan primer*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pelayanan kebidanan dalam sistem layanan kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pelayanan kebidanan berkesinambungan (Continuity of Care)*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Petunjuk teknis penyelenggaraan Posyandu dalam transformasi layanan primer*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Ningsih, D. A. (2017). *Continuity of care kebidanan*. Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo.
- Poltekkes Kemenkes Malang. (2017). *Asuhan kebidanan berkelanjutan (continuity of care)*.
- Renfrew, M. J., et al. (2014). Midwifery and quality care: Findings from a new evidence-informed framework. *The Lancet*, 384(9948), 1129–1145.

- Renfrew, M. J., McFadden, A., Bastos, M. H., Campbell, J., Channon, A. A., Cheung, N. F., ... Declercq, E. (2014). Midwifery and quality care: Findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care. *The Lancet*, 384(9948), 1129–1145.
- Rohani, S., & Sari, R. P. (2019). *Asuhan kebidanan berkelanjutan (continuity of care)*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Baru Press.
- Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, C. L. (2004). *Varney's midwifery* (4th ed.). Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers.
- Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, C. L. (2014). *Varney's midwifery* (5th ed.). Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.
- Viandika, R., & Septiasari, R. (2020). *Continuity of care sebagai model pelayanan kebidanan berkesinambungan*. Poltekkes Kemenkes Malang.
- Widyawati, N. P., & Rosyidah, R. (2023). Asuhan kebidanan continuity of care pada kasus fisiologis di klinik dan RB Eva. *Jurnal Medika Usada*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- World Health Organization. (2016). *Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities*. Geneva: WHO.

Q. Glosarium

Asuhan Kebidanan

Pelayanan kesehatan profesional yang diberikan oleh bidan kepada perempuan, bayi, dan keluarga berdasarkan standar praktik kebidanan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan.

Asuhan Kebidanan Berkelanjutan (Continuity of Care/CoC)

Pendekatan asuhan kebidanan yang diberikan secara terus-menerus, terpadu, dan berkesinambungan kepada perempuan dan bayinya sejak masa pra-kehamilan, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, hingga pelayanan kesehatan reproduksi.

Woman-Centered Care

Pendekatan pelayanan kebidanan yang menempatkan perempuan sebagai pusat asuhan, menghargai hak, pilihan, kebutuhan, serta pengalaman perempuan dalam setiap pengambilan keputusan terkait kesehatannya.

Continuity of Relationship

Hubungan yang berkelanjutan dan konsisten antara bidan dan klien selama periode asuhan, yang bertujuan membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Asuhan Holistik

Pendekatan asuhan yang memperhatikan perempuan secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual.

Pengkajian Berkelanjutan

Proses pengumpulan dan analisis data klien yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus untuk memantau perubahan kondisi dan mendeteksi masalah secara dini.

Perencanaan Asuhan Individual

Penyusunan rencana asuhan kebidanan yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan preferensi setiap perempuan berdasarkan hasil pengkajian.

Pelaksanaan Asuhan Berkesinambungan

Pemberian asuhan kebidanan secara konsisten sesuai rencana yang telah disusun, dengan menjaga kesinambungan pelayanan dan hubungan bidan–klien.

Evaluasi Asuhan

Proses penilaian terhadap hasil asuhan kebidanan untuk menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan kebutuhan tindak lanjut.

Tindak Lanjut

Langkah lanjutan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, berupa melanjutkan, memodifikasi, atau merujuk asuhan sesuai kondisi klien.

Dokumentasi Asuhan Kebidanan

Pencatatan seluruh proses asuhan kebidanan secara lengkap, akurat, dan sistematis sebagai alat komunikasi, evaluasi, dan bukti legal.

SOAP

Metode dokumentasi asuhan kebidanan yang terdiri dari Subjective, Objective, Assessment, dan Plan.

Manajemen Kebidanan Varney

Pendekatan sistematis dalam pemberian asuhan kebidanan yang terdiri dari tujuh langkah untuk mengidentifikasi masalah dan merencanakan asuhan secara komprehensif.

Evidence-Based Midwifery

Praktik kebidanan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis bidan, dan nilai serta preferensi klien.

Kolaborasi

Kerja sama antara bidan dengan tenaga kesehatan lain untuk memberikan pelayanan yang aman dan bermutu.

Rujukan

Proses pengalihan penanganan klien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu apabila ditemukan komplikasi atau kondisi di luar kewenangan bidan.

Etika Kebidanan

Nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman bidan dalam memberikan asuhan kebidanan secara profesional dan bertanggung jawab.

Legalitas Praktik Kebidanan

Aspek hukum yang mengatur kewenangan, tanggung jawab, dan perlindungan hukum bagi bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan.

CHAPTER 2

PENGKAJIAN KEHAMILAN DASAR TTV, TAKSIRAN PERSALINAN DAN KELUHAN UMUM

Bdn. Jumriani, S.ST., M.Keb.

A. Pendahuluan / Prolog

Kehamilan merupakan proses fisiologis yang kompleks, ditandai oleh perubahan adaptif pada sistem kardiovaskular, pernapasan, hormonal, metabolik, imunologis, serta anatomi tubuh ibu. Perubahan ini sebagian besar bersifat normal, namun dapat berkembang menjadi kondisi patologis bila tidak dipantau dengan baik. Oleh karena itu, kehamilan membutuhkan pengawasan klinis menyeluruh untuk memastikan kesehatan ibu dan janin tetap optimal. Salah satu bentuk pemantauan tersebut adalah melalui pelayanan antenatal care (ANC), terutama pada kunjungan awal dan kunjungan rutin berikutnya (Green et al., 2020). Pelayanan ANC yang berkualitas menurut pedoman WHO direkomendasikan dimulai sedini mungkin sejak awal kehamilan sebagai upaya preventif dan promotif yang mampu menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi. Pengkajian kehamilan dasar berperan penting dalam proses ini, karena mencakup pemeriksaan tanda-tanda vital (TTV), perhitungan usia kehamilan, taksiran persalinan (TP), serta identifikasi keluhan umum yang mungkin dialami ibu selama hamil. Pemeriksaan tanda vital seperti tekanan darah, suhu, pernapasan, dan nadi sangat penting untuk menilai fungsi fisiologis dasar dan mendeteksi gejala klinis awal, seperti preeklamsia atau infeksi maternall (Loerup et al., 2016). Sementara itu, perhitungan usia kehamilan dan taksiran persalinan membantu tenaga kesehatan menentukan tahapan perkembangan janin, kapan persalinan diperkirakan terjadi, serta mempersiapkan rencana persalinan.

Selain itu, pengkajian keluhan umum kehamilan, seperti mual-muntah, pusing, nyeri punggung, atau gangguan tidur, memberikan pemahaman menyeluruh tentang kondisi ibu (Vousden, Nathan, & Shennan, 2018), baik fisik maupun psikologis. Melalui proses pengkajian tersebut, tenaga kesehatan tidak hanya mengidentifikasi perubahan fisiologis normal, tetapi juga mendeteksi komplikasi sejak dini, misalnya perdarahan kehamilan, hipertensi gestasional, infeksi, anemia, hingga gangguan tumbuh kembang janin (Ryu et al., 2021). Dengan pendekatan yang sistematis, pengkajian kehamilan dasar memungkinkan tenaga kesehatan memberikan intervensi tepat waktu, konseling berbasis masalah, rujukan medis

sesuai indikasi, dan edukasi kesehatan yang komprehensif untuk memastikan pengalaman kehamilan yang aman dan nyaman bagi ibu. Pada akhirnya, proses ini berkontribusi besar dalam menurunkan risiko mortalitas maternal dan neonatal, serta meningkatkan outcome kehamilan secara keseluruhan. Dengan memahami konsep dasar pengkajian kehamilan, mahasiswa kebidanan dan tenaga kesehatan dapat menerapkan keterampilan pemeriksaan klinis yang tepat, akurat, dan sesuai standar praktik kebidanan modern (Bossung et al., 2023).

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip dasar pengkajian kehamilan, sehingga pembaca mampu menjelaskan konsep pemeriksaan antenatal secara sistematis. Melalui bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan cara melakukan pemeriksaan tanda vital ibu hamil dengan prosedur yang benar dan akurat, sesuai standar klinis kebidanan. Selain itu, bab ini menjelaskan metode penghitungan usia kehamilan dan taksiran persalinan menggunakan rumus Naegle serta teknik klinis lainnya yang relevan. Pembaca juga diarahkan untuk memahami identifikasi keluhan umum pada ibu hamil beserta strategi penanganannya. Keseluruhan tujuan tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan klinis tenaga kebidanan dalam melakukan deteksi dini masalah kehamilan, memberikan edukasi tepat sasaran, serta mendukung tercapainya kesehatan ibu dan janin hingga persalinan.

B. Konsep Dasar Pengkajian Kehamilan

1. Definisi Pengkajian Kehamilan

Pengkajian kehamilan merupakan komponen utama dalam pelayanan antenatal care (ANC) yang bertujuan menilai kondisi kesehatan ibu dan janin selama proses kehamilan (Matcho et al., 2018). Pengkajian ini dilakukan melalui serangkaian metode sistematis, mulai dari wawancara untuk memperoleh data subjektif, observasi dan pemeriksaan fisik untuk mendapatkan data objektif, hingga pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan ultrasonografi. Proses ini juga mencakup penilaian tanda bahaya kehamilan, faktor risiko maternal, riwayat obstetrik, gaya hidup, serta status psikologis dan sosial yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan janin.

Dengan demikian, pengkajian kehamilan tidak hanya menilai kondisi ibu pada saat pemeriksaan dilakukan, tetapi juga mengevaluasi dinamika perubahan anatomi dan fisiologi tubuh selama kehamilan yang dapat berpengaruh terhadap outcome persalinan. Pengkajian juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan rencana asuhan kebidanan dan intervensi klinis, baik untuk tujuan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Melalui pengkajian yang komprehensif, tenaga kesehatan dapat mendeteksi dini komplikasi seperti hipertensi

gestasional, anemia, diabetes gestasional, retardasi pertumbuhan intrauterin (IUGR), serta risiko persalinan prematur.

Pada dasarnya, pengkajian kehamilan merupakan fondasi dari seluruh rangkaian asuhan kebidanan (Schink, Wentzell, et al, 2020). Hasil pengkajian menjadi acuan untuk menentukan keputusan klinis, pemberian edukasi, rujukan, serta tindak lanjut yang diperlukan agar kesehatan ibu dan janin tetap terjaga hingga persalinan berlangsung aman (Mcguire, 2023).

2. Prinsip Pengkajian

Prinsip pengkajian kehamilan bertujuan memastikan bahwa proses evaluasi kondisi ibu dan janin dilakukan secara efektif, menyeluruh, konsisten, dan manusiawi (Care, n.d.). Beberapa prinsip berikut menjadi dasar operasional dalam pelaksanaan pengkajian kehamilan secara profesional:

a. Pengkajian Holistik

Pengkajian kehamilan tidak hanya berfokus pada kondisi fisik ibu, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, serta spiritual (Erickson, Gotlieb, Pereira, Myatt, & Mosquera-lopez, n.d.). Kehamilan merupakan peristiwa multidimensional, sehingga setiap faktor eksternal maupun internal yang memengaruhi kondisi ibu harus diperhatikan. Misalnya, kecemasan, stres rumah tangga, tingkat pendidikan, dukungan keluarga, hingga kebiasaan atau pantangan budaya dapat memengaruhi kesehatan kehamilan.

b. Berulang pada Setiap Kunjungan ANC

Tanda, gejala, dan respons ibu terhadap kehamilan berkembang sepanjang trimester. Oleh karena itu, pengkajian harus dilakukan secara berulang pada setiap kunjungan antenatal, dengan pembaruan data dan catatan perkembangan klinis. Pemeriksaan berulang membantu memantau pola perubahan fisiologis sehingga tenaga kesehatan dapat membandingkan hasil sebelumnya dengan kondisi terkini dan mendeteksi perubahan abnormal lebih cepat (S. Y. Id, Utarini, & Trisnantoro, 2024)

c. Berorientasi pada Deteksi Risiko

Prinsip utama dalam pelayanan kebidanan adalah deteksi dini risiko kehamilan. Melalui pengkajian, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi faktor risiko seperti riwayat obstetri buruk, hipertensi, infeksi, usia ibu yang ekstrem, obesitas, malnutrisi, dan kelainan anatomi uterus. Temuan tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis yang tepat waktu, termasuk rujukan bila diperlukan.

d. Berbasis Bukti Klinis (Evidence-Based)

Pengkajian kehamilan harus dilakukan sesuai standar profesi, pedoman klinis, dan bukti ilmiah terbaru. Hal ini mencakup penggunaan protokol pemeriksaan, alat diagnostik, standar pembacaan hasil laboratorium, serta interpretasi yang mengacu pada literatur kedokteran dan kebidanan terkini. Pendekatan berbasis bukti memberikan hasil pengkajian yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Kumar et al., 2017).

e. Komunikatif dan Empatik

Pendekatan komunikatif menjadi kunci dalam pengkajian, karena sebagian besar informasi diperoleh melalui wawancara. Tenaga kesehatan harus mampu membangun hubungan saling percaya, menghargai nilai pribadi ibu, dan memberikan rasa aman selama pemeriksaan. Sikap empatik mendorong ibu untuk terbuka mengenai keluhan, kondisi emosional, atau pengalaman traumatis, sehingga pengkajian menjadi lebih lengkap dan mendalam.

3. Komponen Pengkajian Kehamilan

Pengkajian kehamilan terdiri dari delapan komponen utama yang saling berhubungan dan dilakukan secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai status kesehatan ibu dan janin (Umar, Id, Id, & Mathai, 2019). Setiap komponen berfungsi sebagai dasar untuk penegakan diagnosis kebidanan, penentuan intervensi, serta pemantauan perkembangan kehamilan sampai proses persalinan.

a. Riwayat Kesehatan (Anamnesis)

Anamnesis merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menggali informasi subjektif mengenai kondisi ibu. Informasi ini mencakup riwayat kesehatan umum (misalnya hipertensi, asma, DM, gangguan tiroid), riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya, riwayat menstruasi, riwayat penggunaan kontrasepsi, riwayat alergi, riwayat operasi, riwayat penyakit keturunan, serta riwayat penggunaan obat atau suplemen. Riwayat sosial, psikologis, pekerjaan, pola makan, aktivitas fisik, serta kebiasaan merokok atau konsumsi alkohol juga perlu dinilai karena memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan kehamilan. Pemahaman mendalam dari anamnesis membantu mengidentifikasi area risiko dan membangun rencana pemeriksaan fisik yang relevan (Wu et al., 2022).

b. Pemeriksaan Tanda Vital (TTV)

Pemeriksaan tanda vital merupakan indikator awal stabilitas fisiologis ibu selama kehamilan. Parameter yang diperiksa mencakup tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi napas, suhu tubuh, serta dalam beberapa pedoman termasuk indeks massa tubuh (IMT). Tanda vital sangat penting untuk

mendeteksi kemungkinan komplikasi seperti preeklamsia, infeksi, anemia berat, atau gangguan respirasi. Tekanan darah khususnya dipantau secara berkala untuk mendeteksi hipertensi gestasional, preeklamsia, atau hipotensi yang dapat mempengaruhi perfusi uteroplasenta (B, C, , Shaun Brennecke d e, F, & Phyllis Lau b, 2020).

c. Pemeriksaan Fisik Umum

Pemeriksaan fisik umum dilakukan untuk menilai kondisi kesehatan ibu secara menyeluruh. Pemeriksaan meliputi inspeksi keadaan umum ibu, status hidrasi, konjungtiva untuk menilai anemia, sklera untuk melihat ikterus, pemeriksaan ekstremitas untuk edema, pemeriksaan payudara untuk kesiapan laktasi, dan pemeriksaan status kulit termasuk hiperpigmentasi atau striae gravidarum. Pemeriksaan fisik juga dapat mencakup evaluasi reflek tendon, tanda nyeri tekan, kesimetrisan tubuh, dan kondisi abdomen secara umum sebelum pemeriksaan obstetrik terfokus. Pemeriksaan ini membantu mengidentifikasi masalah kesehatan yang tidak spesifik kehamilan namun relevan terhadap kondisi ibu.

d. Pemeriksaan Obstetrik

Pemeriksaan obstetrik dilakukan untuk menilai perkembangan kehamilan dan kondisi janin. Pemeriksaan Leopold menjadi metode utama yang digunakan untuk menentukan letak janin, presentasi, posisi, dan penurunan bagian terendah janin ke panggul. Selain itu, dilakukan pengukuran tinggi fundus uteri (TFU) untuk menilai usia kehamilan dan pertumbuhan janin, serta auskultasi denyut jantung janin (DJJ) untuk memastikan viabilitasnya. Pemeriksaan obstetrik juga dapat dilakukan dengan palpasi abdomen untuk mendeteksi kontraksi, nyeri tekan, atau kelainan perut. Bila diperlukan, pemeriksaan serviks dan panggul dilakukan untuk menilai kesiapan persalinan, terutama pada trimester akhir.

e. Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk memastikan fungsi fisiologis ibu berada dalam batas normal dan mendeteksi komplikasi kehamilan secara dini. Pemeriksaan rutin meliputi hemoglobin/hematokrit untuk menilai anemia, protein urin untuk skrining preeklamsia, golongan darah dan rhesus, glukosa darah untuk mendeteksi diabetes gestasional, serta pemeriksaan infeksi seperti VDRL, HIV, hepatitis B, dan TORCH (pada indikasi tertentu). Pemeriksaan urin lengkap membantu mengevaluasi infeksi saluran kemih, sedangkan pemeriksaan kultur dilakukan bila dicurigai adanya infeksi bakteri. Hasil pemeriksaan laboratorium berfungsi sebagai dasar klinis untuk perencanaan intervensi medis (Baten, Biswas, Kendal, & Bhowmik, 2025).

f. Taksiran Persalinan

Perhitungan taksiran persalinan (TP) merupakan bagian penting dalam pengkajian kehamilan. TP dihitung menggunakan rumus Naegele berdasarkan HPHT atau melalui ultrasonografi pada trimester pertama dengan akurasi yang lebih tinggi. Perhitungan usia kehamilan membantu menentukan jadwal ANC, memantau pertumbuhan janin, mendeteksi kehamilan post-term atau preterm, serta menyusun rencana persalinan. Dokumentasi TP juga menjadi dasar untuk memberikan edukasi pada ibu mengenai tanda-tanda persalinan, kapan harus ke fasilitas kesehatan, serta persiapan psikososial dan finansial menjelang kelahiran (S. W. Id, Emilia, Wahyuni, Afdal, & Haier, 2024).

g. Keluhan Umum

Keluhan umum kehamilan muncul akibat perubahan fisiologis dan psikologis selama kehamilan. Keluhan dapat berbeda pada tiap trimester, seperti mual muntah, pusing, nyeri punggung, kram kaki, konstipasi, insomnia, atau sesak napas ringan. Pengkajian keluhan mencakup intensitas, durasi, faktor penyebab, pola perbaikan atau perburukan, serta dampak keluhan terhadap aktivitas ibu. Identifikasi keluhan umum sangat penting untuk membedakan gejala fisiologis normal dari tanda bahaya kehamilan, misalnya nyeri kepala berat, perdarahan, edema ekstrem, atau penurunan gerakan janin. Tenaga kesehatan juga harus memberikan penjelasan bahwa sebagian besar keluhan adalah normal, sekaligus menyarankan strategi penanganan yang aman (Trostian, Mccloughen, Shaban, & Curtis, 2025).

h. Edukasi dan Tindak Lanjut

Edukasi merupakan komponen akhir yang tidak terpisahkan dari proses pengkajian. Setelah hasil pemeriksaan diperoleh, tenaga kesehatan perlu memberikan penjelasan kepada ibu mengenai status kesehatannya, potensi risiko, interpretasi hasil laboratorium, serta apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Edukasi meliputi pemantauan gerakan janin, nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen, tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, rencana rujukan bila risiko tinggi, serta perawatan diri sehari-hari.

Tindak lanjut ditentukan berdasarkan temuan pengkajian misalnya pemantauan ketat tekanan darah pada ibu dengan hipertensi, rujukan ke spesialis obstetri, pengulangan pemeriksaan laboratorium, atau konseling psikologis. Dokumentasi setiap tindak lanjut menjadi bagian penting untuk pemantauan perkembangan pada kunjungan berikutnya.

C. Pemeriksaan Tanda Vital (Ttv) Pada Ibu Hamil

1. Definisi Tanda Vital

Tanda vital adalah parameter fisiologis utama yang menggambarkan fungsi dasar organ tubuh, meliputi:

- a. tekanan darah,
- b. nadi,
- c. respirasi, dan
- d. suhu tubuh.

2. Tujuan Pemeriksaan TTV pada Kehamilan

Pemeriksaan tanda vital (TTV) merupakan aspek dasar yang sangat penting dalam pengkajian kehamilan. Pemeriksaan ini memberikan informasi objektif mengenai kondisi fisiologis ibu selama proses kehamilan (Prihadianto¹, Astiah², & Romiana³, 2025). Perubahan pada tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu tubuh dapat menjadi indikator awal adanya gangguan kesehatan, bahkan sebelum gejala klinis muncul. Oleh karena itu, TTV harus dinilai secara rutin pada setiap kunjungan antenatal sebagai langkah awal deteksi dini komplikasi maternal maupun fetal. Adapun tujuan pemeriksaan TTV pada kehamilan antara lain sebagai berikut:

a. Mendeteksi Risiko Preeklampsia dan Gangguan Tekanan Darah

Pengukuran tekanan darah menjadi kunci dalam mendeteksi hipertensi kehamilan, preeklampsia, dan eklampsia. Preeklampsia merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas maternal. Kenaikan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg setelah usia kehamilan 20 minggu perlu dicurigai sebagai tanda awal gangguan hipertensi gestasional, terutama bila disertai proteinuria atau edema. Dengan pemantauan tekanan darah yang teratur, tenaga kesehatan dapat melakukan diagnosis dan intervensi sedini mungkin sehingga dapat mencegah komplikasi berat, termasuk kejang, edema paru, solusio plasenta, hingga kematian ibu dan janin.

b. Menilai Status Hidrasi dan Kondisi Sirkulasi

Frekuensi nadi yang terlalu cepat atau terlalu lambat selama kehamilan dapat mengindikasikan ketidakseimbangan perfusi darah, dehidrasi, anemia, atau tanda adanya infeksi sistemik. Kehamilan menyebabkan peningkatan volume plasma sehingga jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Oleh karena itu, penilaian nadi secara berkala membantu tenaga kesehatan menilai apakah sirkulasi dan hidrasi tubuh ibu berada dalam batas normal, terutama pada kondisi hiperemesis gravidarum, perdarahan, atau hipertermia.

c. Memantau Suhu Tubuh untuk Deteksi Infeksi

Suhu tubuh merupakan indikator awal terjadinya infeksi. Demam pada ibu hamil dapat menjadi tanda infeksi obstetrik, penyakit sistemik, infeksi saluran napas, infeksi saluran kemih, atau komplikasi lain seperti ketuban pecah dini dengan infeksi intrauterin. Kondisi ini berpotensi membahayakan janin karena hipertermia maternal yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko kelainan perkembangan janin dan persalinan prematur. Oleh karena itu, pemeriksaan suhu tubuh harus dilakukan pada setiap kunjungan, terutama pada ibu dengan keluhan lemah, pusing, menggigil, atau perdarahan.

d. Menilai Fungsi Perfusi dan Sistem Pernapasan Selama Kehamilan

Pemeriksaan frekuensi napas bertujuan menilai kondisi oksigenasi tubuh dan fungsi paru. Pada kehamilan normal, frekuensi napas dapat sedikit meningkat sebagai penyesuaian terhadap kebutuhan oksigen ibu dan janin. Namun, peningkatan frekuensi napas yang signifikan dapat menjadi tanda asidosis metabolik, infeksi paru, emboli, anemia berat, atau gangguan fungsi jantung. Pemantauan frekuensi napas sangat penting pada ibu dengan faktor risiko seperti obesitas, asma, dan hipertensi.

e. Menentukan Keputusan Klinis Secara Cepat dan Akurat

Hasil pemeriksaan TTV membantu tenaga kesehatan menetapkan diagnosis awal, menentukan rencana tindakan, memberikan edukasi yang tepat, merumuskan keputusan rujukan, serta menetapkan prioritas kegawatdaruratan. Sebagai contoh, kombinasi tekanan darah tinggi, edema, dan nadi cepat dapat mengarah pada preeklampsia berat yang membutuhkan penanganan segera. Sementara itu, tekanan darah rendah dan nadi cepat dapat menunjukkan syok atau dehidrasi. Dengan demikian, tanda vital berperan sebagai dasar pengambilan keputusan klinis yang rasional dan berbasis bukti, baik pada kondisi rutin maupun darurat.

3. Tekanan Darah (TD)

Tekanan darah merupakan indikator penting dalam menilai risiko hipertensi kehamilan dan preeklampsia. Pada trimester awal, tekanan darah umumnya menurun akibat vasodilatasi sistemik, kemudian kembali mendekati nilai normal pada trimester akhir.

Cara Pemeriksaan

- menggunakan sphygmomanometer terkalibrasi
- manset sesuai ukuran lengan
- ibu dalam posisi duduk rileks
- lengan setinggi jantung
- lakukan pengukuran 2 kali, ambil rata-rata

Interpretasi Klinis

- a. TD $\geq$ 140/90 mmHg → curiga hipertensi gestasional
- b. penurunan TD drastis → tanda hipotensi & perfusi rendah
- c. perubahan >30 mmHg dari baseline → tanda bahaya

4. Nadi

Frekuensi nadi meningkat secara fisiologis akibat peningkatan curah jantung selama kehamilan. Nadi menggambarkan status hidrasi, perfusi perifer, fungsi jantung, serta respons terhadap stres fisik.

Cara Pemeriksaan

- a. palpasi arteri radialis selama 60 detik
- b. nilai irama, kekuatan, dan regularitas

Interpretasi Klinis

- a. nadi tinggi anemia, dehidrasi, demam, infeksi
- b. nadi rendah efek obat, gangguan perfusi jantung

5. Respirasi

Kehamilan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen sehingga frekuensi napas dapat sedikit meningkat. Namun perubahan ekstrem dapat menunjukkan gangguan respirasi atau metabolik.

Cara Pemeriksaan

- a. hitung frekuensi napas selama 60 detik
- b. amati pola pernapasan dan penggunaan otot bantu

Interpretasi Klinis

- c. RR meningkat infeksi paru, emboli, anemia berat
- d. RR menurun depresi sistem saraf pusat

6. Suhu Tubuh

Suhu tubuh berkaitan dengan metabolisme, infeksi, dan keseimbangan termoregulasi. Demam pada kehamilan harus diwaspadai karena berisiko memengaruhi janin.

Cara Pemeriksaan

- a. termometer digital
- b. aksila, oral, atau timpani

Interpretasi Klinis

- a. suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ → curiga infeksi maternal
- b. suhu $<36,5^{\circ}\text{C}$ → hipotermia, syok, gangguan perfusi

Tabel 2.1 Rentang Normal Tanda Vital pada Ibu Hamil

Parameter	Nilai Normal	Makna Klinis	Indikasi Abnormal
Tekanan Darah	110–140/70–90 mmHg	menunjukkan stabilitas perfusi	≥140/90 mmHg: curiga hipertensi / preeklampsia
Nadi	60–100 x/menit	meningkat ringan pada trimester akhir	>100: anemia, dehidrasi, infeksi
Respirasi	16–24 x/menit	meningkat karena kebutuhan oksigen	>24: gangguan respirasi / emboli
Suhu Tubuh	36,5°–37,5°C	menunjukkan stabilitas metabolik	>37,5°: infeksi maternal

Table 2.2 Perubahan Fisiologis TTV Berdasarkan Trimester

Trimester	Perubahan Normal	Penyebab Fisiologis	Catatan Klinis
I	tekanan darah menurun	vasodilatasi akibat progesteron	TD rendah tidak selalu patologis
II	nadi meningkat	peningkatan curah jantung	pantau tanda anemia
III	respirasi meningkat	elevasi diafragma & kebutuhan oksigen	pantau risiko sesak patologis

Table 2.3 Interpretasi Klinis Kombinasi TTV Abnormal

Kombinasi Temuan	Kemungkinan Diagnosa	Tindakan
TD tinggi + proteinuria + edema	Preeklampsia	rujuk segera
Nadi tinggi + suhu tinggi + RR meningkat	Infeksi sistemik	pemeriksaan lab + antibiotik sesuai indikasi
TD rendah + nadi tinggi + RR meningkat	Syok / dehidrasi	resusitasi cairan
Suhu normal + nadi rendah + napas lambat	gangguan SSP	rujukan spesialis

D. Taksiran Persalinan (Tp)

1. Definisi

Taksiran persalinan (TP) adalah perkiraan tanggal kelahiran janin yang dihitung berdasarkan usia kehamilan. TP digunakan untuk menentukan perkiraan waktu persalinan, memantau pertumbuhan dan perkembangan janin, menyusun rencana persalinan, serta mendeteksi risiko kelahiran prematur atau post-matur. TP tidak bersifat absolut, melainkan estimasi klinis. Karena proses persalinan dipengaruhi oleh faktor fisiologis, hormonal, dan mekanisme pembukaan serviks, maka persalinan normal dapat terjadi dalam rentang ± 2 minggu dari tanggal taksiran.

2. Tujuan TP

Perhitungan TP memiliki beberapa tujuan klinis penting, antara lain:

a. Menentukan Usia Kehamilan Secara Tepat

Mengetahui usia kehamilan secara akurat penting untuk memantau perkembangan janin sesuai usia gestasi. Usia kehamilan menjadi dasar interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium, ultrasonografi, ukuran fundus uteri, serta denyut jantung janin.

b. Menyusun Rencana Persalinan

TP digunakan untuk mengatur kesiapan fisik, mental, administratif, dan finansial ibu menjelang persalinan, termasuk persiapan rujukan fasilitas kesehatan dan pendamping persalinan.

c. Mendeteksi Persalinan Prematur dan Post-term

Usia kehamilan menentukan kategori kelahiran:

- 1) <37 minggu → prematur
- 2) 37–42 minggu → cukup bulan
- 3) 42 minggu → post-term

Identifikasi dini membantu mencegah komplikasi seperti gangguan napas neonatal atau insufisiensi plasenta.

d. Memantau Gerak Janin dan Pertumbuhan

TP membantu tenaga kesehatan membandingkan hasil pengukuran tinggi fundus, estimasi berat badan janin, dan ukuran biometrik USG agar sesuai usia gestasi.

3. Metode Perhitungan Taksiran Persalinan

a. Rumus Naegele (Metode Kalender)

Rumus Naegele merupakan metode standar yang paling banyak digunakan.

Rumus:

HPHT + 7 hari – 3 bulan + 1 tahun

Contoh:

HPHT = 12 Februari 2025

TP = 19 November 2025

Kelebihan: sederhana, cepat, tanpa alat tambahan

Keterbatasan: hanya akurat pada siklus menstruasi teratur dan tidak akurat jika ibu lupa HPHT

b. Ultrasonografi (USG Trimester 1–3)

USG merupakan metode paling akurat untuk menentukan usia kehamilan, terutama pada trimester pertama.

Trimester 1:

- Crown Rump Length (CRL)
akurasi $\pm 5-7$ hari

Trimester 2:

- Biparietal Diameter (BPD)
- Femur Length (FL)
akurasi $\pm 10-14$ hari

Trimester 3:

akurasi menurun karena variasi pertumbuhan janin meningkat

Kelebihan: akurasi tinggi, dapat digunakan walau HPHT tidak diketahui, dapat mendeteksi kelainan janin

Keterbatasan: tergantung operator, tidak selalu tersedia di fasilitas dasar

c. Metode Tinggi Fundus Uteri (TFU)

Pengukuran tinggi fundus dilakukan mulai trimester kedua untuk memperkirakan usia kehamilan.

Contoh pola TFU:

- 1) 16 minggu $\rightarrow \frac{1}{2}$ simpisis–pusar
- 2) 24 minggu $\rightarrow$ setinggi pusar
- 3) 36 minggu $\rightarrow$ setinggi xifoideus

Kelebihan: sederhana, praktis, tanpa alat khusus

Keterbatasan: akurasi rendah bila disertai obesitas, mioma, kehamilan kembar

d. Metode Gerak Janin Pertama (Quickening)

Gerak janin pertama muncul pada usia:

- 1) primigravida: 18–20 minggu
- 2) multigravida: 16–18 minggu

Quickening berguna sebagai indikator tambahan, bukan perhitungan utama

Tabel 2.4 Perbandingan Metode Perhitungan TP

Metode	Akurasi	Waktu terbaik	Kelebihan	Keterbatasan
Naegele	Sedang	awal kehamilan	mudah diterapkan	tidak akurat jika HPHT tidak diketahui
USG trimester 1	sangat tinggi	<14 minggu	hasil objektif	tergantung alat & operator
USG trimester 2	Sedang	14–28 minggu	memperkuat usia kehamilan	akurasi menurun
TFU	Rendah	>20 minggu	sederhana	variasi anatomi ibu
Quickening	Rendah	16–20 minggu	tanpa alat	Subjektif

4. Faktor yang Mempengaruhi Akurasi TP

- a. ketidakpastian HPHT
- b. siklus menstruasi tidak teratur
- c. kontrasepsi hormonal sebelum hamil
- d. perbedaan laju pertumbuhan janin
- e. obesitas maternal
- f. kesalahan pengukuran TFU/USG

E. Keluhan Umum Pada Ibu Hamil

1. Definisi

Keluhan umum kehamilan adalah perubahan fisiologis yang dialami ibu selama proses kehamilan sebagai bentuk adaptasi tubuh terhadap perubahan hormonal, mekanis, metabolik, dan psikologis. Keluhan ini umumnya tidak bersifat patologis dan merupakan bagian dari perkembangan kehamilan yang normal. Namun demikian, keluhan tubuh yang tampak ringan dapat menjadi indikator awal komplikasi serius sehingga memerlukan pengkajian secara sistematis. Keluhan umum biasanya bervariasi berdasarkan usia kehamilan dan tingkat toleransi individu. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memahami mekanisme dasar terjadinya keluhan, membedakan kondisi normal dan abnormal, serta memberikan penatalaksanaan dan edukasi yang tepat untuk menjaga kenyamanan ibu hamil selama masa antenatal.

2. Prinsip Pengkajian Keluhan Umum

Pengkajian keluhan umum harus mempertimbangkan aspek berikut:

- a. Intensitas dan frekuensi apakah keluhan semakin memburuk atau mengganggu aktivitas.
- b. Lokasi dan durasi waktu mulai keluhan dan perubahan yang terjadi.
- c. Pencetus dan peredanya hubungan keluhan dengan aktivitas atau pola makan.
- d. Dampak fungsional apakah keluhan menyebabkan penurunan kualitas hidup.
- e. Hubungan dengan usia kehamilan sesuai trimester atau tidak.

Tujuan pengkajian adalah untuk membedakan kondisi fisiologis dan patologis guna menentukan apakah keluhan memerlukan rujukan segera.

3. Keluhan Kehamilan Berdasarkan Trimester

a. Trimester I (0–12 Minggu)

Keluhan umum trimester I sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan hormonal, terutama peningkatan kadar progesteron, estrogen, dan hCG.

1) Mual Muntah

Disebabkan oleh stimulasi pusat muntah di otak akibat hormon hCG.
Penanganan: makan sedikit tapi sering, hindari bau menyengat, konsumsi vitamin B6.

2) Kelelahan

Dipengaruhi oleh peningkatan metabolisme dan perubahan tidur.
Penanganan: istirahat cukup, aktivitas ringan seperti jalan kaki.

3) Pusing atau Lemas

Akibat vasodilatasi dan perubahan tekanan darah.
Penanganan: hidrasi cukup, perubahan posisi perlahan, makan teratur.

4) Sering BAK

Karena uterus menekan kandung kemih
Penanganan: jangan menahan BAK, kurangi kafein.

5) Nyeri Payudara

Karena peningkatan estrogen menyebabkan pembengkakan jaringan payudara.
Penanganan: gunakan bra yang nyaman dan sesuai ukuran.

b. Trimester II (13–28 Minggu)

Pada masa ini, keluhan umumnya lebih dipengaruhi oleh faktor mekanis akibat pembesaran uterus.

1) Nyeri Punggung Bawah

Disebabkan oleh perubahan postur dan relaksasi ligamen.
Penanganan: senam hamil, kompres hangat, hindari mengangkat beban berat.

2) Konstipasi

Akibat perlambatan motilitas usus oleh progesteron.

- Penanganan: konsumsi serat, cairan, dan aktivitas fisik.
- 3) Varises dan Hemoroid
 Karena peningkatan tekanan intraabdominal.
 Penanganan: hindari berdiri lama, elevasi kaki, konsumsi serat.
- 4) Kram Kaki
 Terjadi akibat perubahan elektrolit dan aliran darah.
 Penanganan: peregangan otot betis, konsumsi kalsium dan magnesium.
- c. Trimester III (29–40 Minggu)
 Keluhan meningkat akibat tekanan mekanis yang lebih besar dan persiapan tubuh untuk persalinan.
- 1) Sesak Nafas
 Karena elevasi diafragma oleh uterus.
 Penanganan: posisi semi-Fowler, latihan pernapasan.
- 2) Nyeri Panggul atau Pinggul
 Akibat peregangan ligamentum dan persiapan panggul.
 Penanganan: istirahat, pemanasan, latihan ringan.
- 3) Sakit Punggung dan Pinggang
 Karena perubahan postur, peningkatan berat badan.
 Penanganan: kompres hangat, senam kehamilan.
- 4) Kontraksi Braxton Hicks
 Merupakan kontraksi palsu, tidak teratur dan tidak nyeri.
 Penanganan: istirahat dan hidrasi.
- 5) Tanda Bahaya Terkait Keluhan Kehamilan
 Tidak semua keluhan dapat dikategorikan sebagai fisiologis. Tanda bahaya berikut membutuhkan rujukan segera:

Tabel 2.5 Tanda Bahaya Terkait Keluhan Kehamilan

Gejala	Kemungkinan Diagnosa	Tindakan Awal
Sakit kepala berat tak hilang dengan istirahat	Preeklampsia	Rujuk spesialis
Nyeri ulu hati hebat	Preeklampsia berat	Evaluasi laboratorium
Perdarahan pervaginam	Plasenta previa/solusio	Rujuk emergensi
Sesak napas berat	Emboli paru/penyakit jantung	Stabilisasi + rujuk
Tidak ada gerak janin	IUFD	Evaluasi USG segera
Demam tinggi	Infeksi obstetrik	Antibiotik sesuai indikasi
Nyeri perut hebat	Apendisitis/torsi ovarium	Penilaian bedah

4. Penatalaksanaan Keluhan Kehamilan – Tabel Klinis

Tabel 2.6 Keluhan Umum dan Penatalaksanaan

Keluhan	Penyebab	Penatalaksanaan
Mual muntah	hCG tinggi	makan sedikit sering, B6
Kelelahan	perubahan metabolik	tidur teratur, relaksasi
Nyeri punggung	tekanan uterus	senam hamil, kompres hangat
Konstipasi	motilitas usus menurun	serat tinggi, cairan
Kram kaki	aliran darah	peregangan, magnesium
Insomnia	cemas, nyeri	relaksasi, tidur higienis
Sering BAK	tekanan uterus	kurangi kafein, jangan tahan pipis

F. Simpulan

Asuhan kehamilan dasar merupakan fondasi pelayanan antenatal care (ANC) yang berperan penting dalam menjaga kesehatan maternal dan janin selama masa kehamilan. Hasil kajian dari seluruh bab menunjukkan bahwa pemeriksaan kehamilan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berbasis bukti ilmiah, dimulai dari proses pengkajian fisik dan psikologis hingga evaluasi faktor risiko kehamilan.

Pemeriksaan tanda vital menjadi bagian utama dalam pengkajian karena memberikan gambaran objektif mengenai kondisi fisiologis ibu (Hilma Triana¹, 2* & Yamani¹, 2023). Perubahan kecil pada tekanan darah, nadi, respirasi, atau suhu tubuh dapat menandakan adanya risiko preeklampsia, infeksi, anemia, gangguan perfusi, atau tanda bahaya obstetrik lainnya. Pemantauan tanda vital secara berkala terbukti efektif untuk mencegah komplikasi serius dan mendukung deteksi dini kondisi medis yang membahayakan kehamilan (Smith, 2021).

Perhitungan taksiran persalinan (TP) memainkan peran penting dalam menentukan usia kehamilan, mempersiapkan proses persalinan, serta mengidentifikasi risiko kelahiran prematur maupun post-term. Metode USG trimester pertama merupakan standar akurasi tertinggi, sementara rumus Naegele, tinggi fundus uteri, dan quickening berfungsi sebagai metode pendukung. Pemahaman akurat mengenai usia kehamilan membantu tenaga kesehatan membuat keputusan klinis yang tepat, terutama terkait pemantauan pertumbuhan janin dan kesiapan persalinan (Hasnah & Tahir, 2022).

Keluhan umum kehamilan yang dialami ibu merupakan bagian fisiologis dari adaptasi hormonal dan mekanis selama kehamilan. Meskipun demikian, pengkajian tetap diperlukan untuk membedakan keluhan normal dan keluhan patologis yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Edukasi berkelanjutan diberikan kepada ibu

mengenai pola makan, hidrasi, istirahat, aktivitas fisik, serta tanda bahaya kehamilan agar mampu meningkatkan kualitas hidup dan mencegah kecemasan.

Secara keseluruhan, pemahaman mendalam mengenai pengkajian kehamilan dasar, pemeriksaan tanda vital, taksiran persalinan, dan keluhan umum merupakan inti dari asuhan kebidanan yang berkualitas. Penerapan pemeriksaan yang tepat—disertai komunikasi empatik dan edukasi komprehensif—akan mendukung terwujudnya kehamilan yang sehat, persalinan aman, serta outcome maternal dan neonatal yang optimal.

Dengan demikian, isi buku ini diharapkan menjadi landasan ilmiah dan praktis bagi mahasiswa kebidanan, bidan, dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan antenatal yang efektif, holistik, dan profesional sesuai standar praktik kebidanan modern.

G. Referensi

- B, F. M. E. a, C, O. E., , Shaun Brennecke d e, J. G. b, F, S. L., & Phyllis Lau b. (2020). Opportunities for improving hypertensive disorders of pregnancy (HDP) management in primary care settings: A review of international published guidelines in the context of pregnancy care in Indonesia. *Pregnancy Hypertension*, 19, 195–204. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210778920300131?via%3Dihub>
- Baten, A., Biswas, R. K., Kendal, E., & Bhowmik, J. (2025). Utilization of maternal healthcare services in low - and middle - income countries : a systematic review and meta - analysis. *Systematic Reviews*. <https://doi.org/10.1186/s13643-025-02832-0>
- Bossung, V., Singer, A., Ratz, T., Rothenbühler, M., Leeners, B., & Kimmich, N. (2023). *Changes in Heart Rate , Heart Rate Variability , Breathing Rate , and Skin Temperature throughout Pregnancy and the Impact of Emotions — A Longitudinal Evaluation Using a Sensor Bracelet*.
- Care, P. (n.d.). *Common symptoms in pregnancy - where to manage them ? Common symptoms in pregnancy - where to manage them ? Primary Care*.
- Erickson, E. N., Gotlieb, N., Pereira, L. M., Myatt, L., & Mosquera-lopez, C. (n.d.). *Predicting labor onset relative to the estimated date of delivery using smart ring physiological data. 2*. <https://doi.org/10.1038/s41746-023-00902-y>
- Green, L. J., Mackillop, L. H., Salvi, D., Pullon, R., Loerup, L., Tarassenko, L., ...

- Watkinson, P. J. (2020). *Gestation-Specific Vital Sign Reference Ranges in Pregnancy*. 135(3), 653–664. <https://doi.org/10.1097/AOG.00000000000003721>
- Hasnah, A., & Tahir, S. (2022). *Hubungan Kunjungan Anc Dengan Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III Tentang Persiapan Persalinan Dan Kegawatdaruratan Di Puskesmas Tarakan , Kecamatan Prodi D III Kebidanan FKIK , Universitas Muhammadiyah Makassar*. 2(1), 21–30.
- Hilma Triana¹, ^{2*} S., & Yamani¹, J. and Y. (2023). *Standard Operating Procedures of antenatal care and its relation with pregnant women ' s satisfaction during pregnancy examination* : 6(1).
- Id, S. W., Emilia, O., Wahyuni, A., Afdal, A., & Haier, J. (2024). *Obstetrics care in Indonesia: Determinants of maternal mortality and stillbirth rates*. 1–16. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0303590>
- Id, S. Y., Utarini, A., & Trisnantoro, L. (2024). *A mixed-method analysis of provider adherence to integrated antenatal care guideline in BEmONC and Non BEmONC primary health center: An Indonesian case*. 1–21. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0309454>
- Kumar, F., Kemp, J., Edwards, C., Pullon, R. M., Loerup, L., Triantafyllidis, A., ... Watkinson, P. J. (2017). *Pregnancy physiology pattern prediction study (4P study) : protocol of an observational cohort study collecting vital sign information to inform the development of an accurate centile- based obstetric early warning score*. 1–7. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-016034>
- Loerup, L., Pullon, R. M., Birks, J., Fleming, S., Mackillop, L. H., & Watkinson, P. J. (2016). *Trends of vital signs with gestational age in normal pregnancies: a systematic review protocol*. 1–5. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-008769>
- Matcho, A., Ryan, P., Fife, D., Gifkins, D., Knoll, C., & Friedman, A. (2018). *Inferring pregnancy episodes and outcomes within a network of observational databases*. 1–20.
- Mcguire, B. (2023). *Up d a t e s o n E v a l u a t i o n a n d T r e a t m e n t o f C o m m o n C o m p l a i n t s i n P r e g n a n c y*. 50, 87131.
- Prihadianto¹, D. G., Astiah², ; Andi Asda, & Romiana³, ; Dwi. (2025). *Improving Maternal Health Literacy Through Educational Intervention On Pregnancy Danger Signs: A Pre-Post Study In Batam, Indonesia*.

- Ryu, D., Hyun, D., Price, J. T., Yoon, J., Uk, H., & Allen, E. (2021). *Comprehensive pregnancy monitoring with a network of wireless, soft, and flexible sensors in high- and low-resource health settings*. 118(20), 1–11. <https://doi.org/10.1073/pnas.2100466118>
- Schink, T., Wentzell, N., Dathe, K., Onken, M., & Haug, U. (2020). *Estimating the Beginning of Pregnancy in German Claims Data : Development of an Algorithm With a Focus on the Expected Delivery Date*. 8(August), 1–10. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00350>
- Smith, G. C. (2021). *Universal late pregnancy ultrasound screening to predict adverse outcomes in nulliparous women : a systematic review and cost-effectiveness analysis*. 25(15). <https://doi.org/10.3310/hta25150>
- Trostian, B., Mccloughen, A., Shaban, R. Z., & Curtis, K. (2025). *Australasian Emergency Care What assessment , intervention and diagnostics should women with early pregnancy bleeding receive in the emergency department and when ? A scoping review and synthesis of evidence*. 28(March 2024), 1–11.
- Umar, A., Id, C. A. A., Id, F. M., & Mathai, M. (2019). *Early warning systems in obstetrics : A systematic literature review*. 1–15.
- Vousden, N., Nathan, H. L., & Shennan, A. H. (2018). *Innovations in vital signs measurement for the detection of hypertension and shock in pregnancy*. 15(Suppl 1), 1–5.
- Wu, Y., Zhang, Y., Zou, X., Yuan, Z., Hu, W., & Lu, S. (2022). Estimated date of delivery with electronic medical records by a hybrid GBDT - GRU model. *Scientific Reports*, 1–11. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-08664-5>

H. Golosarium

Anemia

Kondisi berkurangnya kadar hemoglobin dalam darah yang dapat menurunkan kapasitas tubuh membawa oksigen; umum terjadi pada kehamilan.

ANC (Antenatal Care)

Pelayanan kesehatan selama kehamilan untuk memantau kondisi ibu dan janin secara berkala guna mencegah komplikasi.

Aus-kultasi

Teknik pemeriksaan dengan mendengarkan bunyi tubuh menggunakan alat seperti stetoskop; digunakan untuk memeriksa DJJ.

BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)

Berat badan bayi kurang dari 2.500 gram saat lahir.

Braxton Hicks

Kontraksi palsu pada akhir kehamilan yang tidak teratur, tidak nyeri, dan tidak menyebabkan pembukaan serviks.

CRL (Crown Rump Length)

Pengukuran panjang janin dari kepala hingga bokong pada USG trimester pertama untuk menentukan usia kehamilan.

Deteksi dini

Upaya menemukan perubahan atau kondisi abnormal pada tahap awal sebelum menjadi komplikasi.

Dehidrasi

Kekurangan cairan tubuh yang memengaruhi sirkulasi darah dan metabolisme; dapat memperburuk kondisi mual muntah pada kehamilan.

DJJ (Denyut Jantung Janin)

Detak jantung janin yang diperiksa melalui doppler atau CTG untuk menilai kesejahteraan janin.

Edema

Pembengkakan jaringan akibat penumpukan cairan; normal pada kehamilan ringan, patologis bila menyeluruh.

Eklampsia

Komplikasi berat kehamilan yang ditandai kejang pada ibu dengan preeklampsia.

Fundus uteri

Bagian atas rahim yang menjadi acuan dalam pemeriksaan TFU untuk menilai usia kehamilan.

Gestasi

Masa perkembangan janin dalam kandungan sejak konsepsi hingga kelahiran.

HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir)

Tanggal awal menstruasi terakhir digunakan dalam rumus Naegele untuk menghitung usia kehamilan dan TP.

Hiperemesis gravidarum

Mual muntah berlebihan pada kehamilan yang menyebabkan dehidrasi, gangguan elektrolit, dan penurunan berat badan.

Hipertensi Gestasional

Tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg setelah usia kehamilan 20 minggu tanpa proteinuria.

IUGR (Intrauterine Growth Restriction)

Kondisi pertumbuhan janin terhambat, berat janin lebih rendah dari usia gestasi.

IUFD (Intrauterine Fetal Death)

Kematian janin dalam kandungan setelah usia kehamilan 20 minggu.

Insufisiensi plasenta

Gangguan perfusi plasenta yang menyebabkan penurunan suplai nutrisi dan oksigen ke janin.

Kontraksi

Gerakan otot rahim mengencang dan mengendur; menjadi mekanisme persalinan.

Leopold

Metode palpasi abdomen untuk menilai posisi, letak, presentasi, dan penurunan bagian terbawah janin.

Mual montah gravidarum

Keluhan mual muntah pada kehamilan karena perubahan hormonal dan metabolik.

Multipara

Perempuan yang pernah menjalani persalinan lebih dari satu kali.

Naegele (Rumus Naegele)

Rumus standar untuk menghitung TP menggunakan HPHT + 7 hari – 3 bulan + 1 tahun.

Nadi

Detak pembuluh arteri yang menunjukkan denyut jantung per menit.

Obstetri

Cabang ilmu kedokteran yang mempelajari kehamilan, persalinan, dan masa nifas.

Palpasi

Pemeriksaan menggunakan perabaan untuk menilai ukuran, bentuk, gerakan, atau nyeri organ tubuh.

Partus

Proses melahirkan janin dari dalam rahim melalui jalan lahir.

Perfusi

Aliran darah ke jaringan tubuh untuk membawa oksigen dan nutrisi.

Plasenta previa

Kondisi plasenta yang menutupi sebagian atau seluruh mulut rahim; menyebabkan perdarahan kehamilan.

Post-term

Kehamilan ≥ 42 minggu yang meningkatkan risiko komplikasi janin dan persalinan.

Preterm

Persalinan < 37 minggu usia kehamilan.

Preeklampsia

Gangguan kehamilan ditandai hipertensi dan proteinuria setelah usia kehamilan 20 minggu.

Quickening

Gerakan janin pertama kali dirasakan ibu; digunakan sebagai acuan usia kehamilan.

Respirasi

Frekuensi napas per menit yang menunjukkan fungsi sistem pernapasan.

Rujukan

Tindakan mengirim pasien ke fasilitas atau tenaga kesehatan yang lebih kompeten untuk penanganan lebih lanjut.

Suhu tubuh

Derajat panas tubuh normal 36,5–37,5°C; peningkatan dapat mengindikasikan infeksi.

Takikardia

Frekuensi nadi lebih dari 100 kali per menit.

Tanda Vital (TTV)

Parameter fisiologis tubuh yang meliputi tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu tubuh.

TFU (Tinggi Fundus Uteri)

Jarak antara simfisis pubis ke puncak fundus uteri, digunakan untuk menilai pertumbuhan janin.

Trimester

Pembagian masa kehamilan menjadi tiga tahap: I (0–12 minggu), II (13–28 minggu), III (29–40 minggu).

Uterus

Organ reproduksi tempat perkembangan janin selama kehamilan.

USG (Ultrasonografi)

Metode pencitraan untuk menilai janin, plasenta, dan organ reproduksi melalui gelombang suara berfrekuensi tinggi.

TP (Taksiran Persalinan)

Perkiraan tanggal kelahiran berdasarkan usia kehamilan.

CHAPTER 3

EDUKASI SEDERHANA PADA IBU HAMIL: NUTRISI, TANDA BAHAYA, DAN PERSIAPAN PERSALINAN.

Dwi Ardani Rochmaniah, SST., M.Keb.

A. Pendahuluan / Prolog

Kehamilan merupakan proses fisiologis yang dialami oleh wanita, namun dalam beberapa kejadian dapat berkembang menjadi kondisi patologis apabila tidak dilakukan pemantauan dengan baik. Hal tersebut menyumbangkan peningkatan angka kematian ibu (AKI), yaitu keterlambatan dalam mengenali tanda bahaya kehamilan. Oleh sebab itu, edukasi memberikan peranan penting dalam pelayanan antenatal care (ANC) serta keterlambatan dalam melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan (Kemenkes RI, 2020). WHO menyatakan bahwa sebagian besar kematian ibu dapat dicegah dengan melakukan deteksi dini dan penanganan yang tepat pada komplikasi kehamilan (WHO, 2019). Harapannya, dalam proses ANC, dapat diberikan edukasi tentang fisiologi kehamilan, maupun tanda bahaya kehamilan.

B. Edukasi Pada Ibu Hamil

Edukasi adalah suatu kegiatan yang mendorong terjadinya penambahan pengetahuan dan perubahan pada perilaku pada seseorang atau kelompok secara wajar. Tujuan edukasi adalah untuk mengembangkan potensi diri pada peserta dan mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik. Selain itu edukasi juga bertujuan mengembangkan kepribadian, kecerdasan dan mendidik peserta untuk memiliki akhlak mulia, mampu mengendalikan diri serta memiliki keterampilan (Subriah dkk, 2025).

Edukasi kesehatan adalah usaha terencana untuk menciptakan peluang pada individu maupun kelompok untuk meningkatkan kesedaran (literasi) serta memperbaiki keterampilan (life skills) dan pengetahuan terhadap kepentingan kesehatannya (Nursalam, 2015). Berdasarkan pengertian dari WHO, Edukasi kesehatan merupakan Kombinasi dari pengalaman belajar yang dirancang dalam membantu baik individu maupun komunitas dalam meningkatkan kesehatan mereka dengan meningkatkan kesadaran, teknik motivasi, membangun keterampilan (HOU, 2014)

1. Edukasi tentang Nutrisi Ibu Hamil

Edukasi tentang nutrisi pada kehamilan merupakan hal yang penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan kesejahteraan janin. Kesehatan ibu hamil sangat dipengaruhi oleh kecukupan gizi selama hamil. Pengetahuan yang cukup tentang nutrisi selama kehamilan dapat membantu ibu menentukan pilihan makanan yang tepat, sehat dan bergizi seimbang. Menurut Smith L. J & Essed G. G. (2020), selama kehamilan ibu hamil mengalami beberapa perubahan fisiologis dalam mendukung pertumbuhan janin, meliputi:

a. Perubahan Metabolisme

Metabolisme basal yang mengalami peningkatan sekitar 15-20%. Peningkatan berat badan selama hamil bertambah sekitar 12-14 kg (Manuaba, 2007). Saat hamil, wanita membutuhkan asupan makanan bergizi, terutama protein untuk mendukung perkembangan janin, organ reproduksi, payudara serta kesehatan ibu hamil (Herliani, 2024).

b. Perubahan sistem Sirkulasi

Pada kehamilan Trimester I, II dan III terdapat perubahan pada sistem sirkulasi. Sirkulasi darah pada kehamilan meliputi Plasenta dan Uterus yang semakin membesar bersama dengan pembuluh darah yang juga akan semakin membesar (Herliani, 2024). Sistem sirkulasi erat kaitannya dengan sistem kardiovaskuler dan sistem limfatik dalam proses mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, keseimbangan cairan dan suhu tubuh serta proses ekskresi tubuh. Perubahan yang terjadi ditandai dengan adanya peningkatan curah jantung, volume darah, denyut jantung, isi sekuncup serta penurunan resistensi vaskuler (Putri, 2022).

Saat awal kehamilan, perubahan dipicu oleh hormon estrogen dan progesteron selama kehamilan, dimulai pada awal usia kehamilan 4-5 minggu. Pada Usia kehamilan 10 minggu terjadi peningkatan volume darah (berupa plasma dan eritrosit) dan akan semakin meningkat hingga usia kehamilan 30-34 minggu. Memasuki Trimester II, pada usia kehamilan 16 minggu, mulai terlihat terjadi proses Hemodilusi, dan penurunan haemoglobin yaitu dari 15gr/dL menjadi 12,5 gr/dL akibat terjadinya defisiensi zat besi (Herliani, 2024). Pada Kehamilan Trimester III, terjadi penekanan pada aorta yang diakibatkan oleh pembesaran uterus dan akan mengurangi aliran darah uteroplasenta ke ginjal (Herliani, 2024). Selain itu peningkatan denyut jantung meningkat 10 – 20 kali/ menit, terjadi peningkatan stroke sebesar 25% sehingga mengakibatkan peningkatan curah jantung sebesar 50% secara keseluruhan. Peningkatan curah jantung merupakan mekanisme pemulihan yang terjadi akibat peningkatan denyut jantung, peningkatan volume sekuncup dan

penurunan resistensi pembuluh darah yang terjadi hingga aterm karena hormon progesteron. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya relaksasi otot polos sehingga mengakibatkan vasodilatasi pada pembuluh darah (Putri, 2022).

c. Perubahan sistem endokrin

Perubahan yang terjadi pada kelenjar endokrin selama kehamilan meliputi peningkatan produksi hormon dan dapat mengakibatkan terjadinya pembesaran. Perubahan yang terjadi pada kelenjar endokrin meliputi:

- 1) Hipofisis
- 2) Growth Hormone
- 3) Prolaktin
- 4) Tiroid
- 5) Paratiroid
- 6) Adrenal
- 7) Kortisol
- 8) ACTH
- 9) Aldosteron
- 10) Deoksikortikosteron
- 11) Androstenedion/ Testosteron

Perubahan sistem endokrin terjadi pada trimester I pada trimester II. Kelenjar endokrin menghasilkan hormone yang dialirkan melalui aliran darah menuju sel target (Lestari, 2023).

d. Perubahan saluran pencernaan

Pada trimester I, peningkatan hormon estrogen menyebabkan heartburn (peningkatan produksi asam lambung), sehingga mengakibatkan terjadinya hipersalivasi (air liur yang berlebihan), sensasi panas di lambung, serta mual dan pusing (trimester II dan III). Selain itu terjadi peningkatan hormon progesteron yang dapat berpengaruh pada berkurangnya gerakan usus sehingga menyebabkan makanan lebih lama berada di dalam lambung (Herliani, 2024). Pada awal kehamilan, meningkat hormon HCG yang dapat memunculkan rasa mual muntah dan perubahan peristaltik seperti perasaan ingin makan terus (ngidam), sering lapar, kembung, konstipasi, dan peningkatan asam lambung (Sukini, 2023). Penatalaksanaan pada gangguan atau perubahan adaptasi pada saluran cerna antara lain: penanganan farmakologis dan penanganan secara komplementer, meliputi: akupuntur, akupresur, aromaterapi, herbal, yoga dan meditasi, serta hipnoterapi (Fatmawati, 2025).

2. Edukasi tentang Tanda Bahaya Kehamilan

a. Pengertian Tanda bahaya kehamilan

Tanda bahaya kehamilan merupakan suatu kondisi abnormal selama kehamilan yang menunjukkan adanya komplikasi sehingga membutuhkan penanganan segera oleh tenaga kesehatan (Kemenkes RI, 2019). Tanda bahaya tersebut memiliki indikasi yang dapat mengarah pada kemungkinan bahaya dalam kehamilan dan apabila tidak segera diketahui dapat menyebabkan kematian pada ibu (Suhartati, 2025).

b. Pentingnya edukasi tanda bahaya kehamilan

Dalam memberikan pelayanan edukasi, diharapkan dapat memberikan perubahan pengetahuan pada ibu hamil. Penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil dengan tingkat pengetahuan yang baik tentang tanda bahaya kehamilan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mencari pertolongan medis lebih awal (Notoatmodjo, 2014). Pemberian edukasi tanda bahaya kehamilan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu hamil agar mampu:

- 1) Mengenali dan mengetahui tanda bahaya sedini mungkin
- 2) Mengambil keputusan cepat jika mengalami tanda bahaya kehamilan
- 3) Tidak terlambat dalam mengakses pelayanan kesehatan secara tepat waktu

c. Macam-macam Tanda Bahaya Kehamilan

1) Mual muntah berlebihan

Mual muntah berlebihan pada ibu hamil trimester I merupakan tanda gejala dari hyperemesis gravidarum (HEG). Menurut suhartati (2025), Tanda gejala HEG meliputi:

- a) Mual muntah lebih dari 10 kali dalam 24 jam
- b) Mual muntah tidak dapat dikontrol dengan pengobatan morning sickness
- c) Nafsu makan menurun hingga anoreksia
- d) Ketidakseimbangan elektrolit
- e) Asidosis akibat kelaparan
- f) Hipokalemia
- g) Muntah pernisiiosa

HEG disebabkan oleh peningkatan hormon chorionic gonadotropin (HCG) sehingga mengakibatkan mual dan muntah, serta peningkatan hormone progesterone menyebabkan relaksasi otot polos pada lambung hingga motilitas dan mengakibatkan lambung menjadi kosong. Faktor predisposisi HEG meliputi:

- a) Faktor Usia

Usia seseorang dapat berpengaruh pada angka kejadian HEG. Pada Usia kurang dari 20 tahun dan usia diatas 35 tahun dapat mengakibatkan kejadian HEG. Hal tersebut terjadi karena usia < 20 tahun secara biologis memiliki ketidakstabilan emosi, dan masih labil, mental yang belum matang, mudah mengalami penolakan dalam pemenuhan nutrisi selama kehamilan. Pada usia > 35 tahun, berhubungan dengan penurunan imunias, sehingga berbagai penyakit sering dialami oleh usia tersebut.

b) Faktor Jarak Kehamilan

Jarak kehamilan memberikan pengaruh pada kejadian HEG. Pada jarak kehamilan yang terlalu dekat, tubuh belum sepenuhnya pulih dan sudah harus dipaksa untuk memproduksi kembali hormon-hormon kehamilan dan lainnya, sehingga dapat memicu kejadian HEG dan juga komplikasi-komplikasi lainnya.

c) Paritas

Kejadian HEG pada primigravida lebih banyak terjadi HEG dibandingkan pada multigravida. Hal tersebut terjadi oleh karena ibu primigravida belum bisa beradaptasi dengan perubahan hormon pada awal kehamilan.

d) Pendidikan

Pendidikan dapat mempengaruhi perilaku dan polaaktifitas sehingga berhubungan dengan perubahan kesehatan seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mudah menerima informasi dan memanfaatkan pelayanan kesehatan, sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan seseorang makan sedikit pula keinginan untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan.

2) Nyeri perut hebat

Nyeri perut hebat dan menetap bukan termasuk keluhan yang normal dalam kehamilan. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan kehamilan ektopik terganggu (KET), infeksi intrauterine, maupun komplikasi lainnya (Cunningham, 2018). Nyeri perut hebat pada kehamilan biasanya disebabkan oleh kondisi patologis, antara lain:

a) Abortus

Tanda bahaya kehamilan yang muncul dengan gejala nyeri perut hebat adalah abortus. Abortus yang paling sering muncul disertai nyeri hebat dan perdarahan yang diakibatkan oleh kontraksi uterus adalah abortus inkomplit dan abortus imminens (Prawirohardjo, 2016).

b) Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)

KET merupakan kehamilan dengan hasil konsepsi yang berimplantasi di luar cavum uteri, dan paling sering berada di tuba falopii. Menurut

Cunningham (2018), KET terjadi pada kehamilan trimester I, dengan tanda dan gejala sebagai berikut:

- Nyeri perut hebat
- Perdarahan pervaginam
- Tanda syok (pada kejadian rupture)

c) Solusio Plasenta

Solusio plasenta merupakan kegawatdaruratan obstetric yang dapat mengancam nyawa ibu dan janin (WHO, 2019). Solusio plasenta adalah keadaan dimana terjadi pelepasan sebagian atau seluruh plasenta sebelum bayi lahir. Tanda dan gejala solusio plasenta:

- Nyeri perut hebat
- Uterus tegang
- Perdarahan baik terlihat maupun tersembunyi

d) Ruptur Uterus

Ruptur uterus merupakan kondisi robeknya dinding uterus pada kehamilan lanjut atau pada saat persalinan, terutama pada ibu dengan riwayat persalinan Sectio Caesarea (SC). Prawiroharjo (2016) menyebutkan, Tanda dan gejala Ruptur uteri meliputi:

- Nyeri perut hebat mendadak
- Perdarahan
- Gawat janin

e) Infeksi intra uterin

Infeksi intrauterine seperti korioamnionitis dapat menyebabkan risiko sepsis maternal dan kematian janin (Cunningham, 2018). Tanda gejala korioamnionitis sebagai berikut:

- Nyeri perut hebat
- Demam
- Takikardia
- Nyeri tekan uterus

3) Perdarahan dari jalan lahir/ Perdarahan Antepartum

Perdarahan selama kehamilan merupakan tanda bahaya yang terjadi pada trimester I, trimester II dan trimester III. Penyebab perdarahan selama kehamilan meliputi: abortus, kehamilan ektopik terganggu, plasenta previa dan solusio plasenta. Perdarahan dapat menyebabkan anemia berat, syok, sampai kematian ibu dan bayi jika tidak segera mendapatkan penanganan (Prawirohardjo, 2016).

4) Ketuban pecah dini

Ketuban yang pecah sebelum waktunya dapat meningkatkan risiko infeksi dan persalinan premature (WHO, 2019).

5) Gerakan janin berkurang

Penurunan intensitas dan frekuensi gerakan janin dapat menjadi tanda kegawatan pada janin hingga kematian janin intrauterin (Prawiroharjo, 2016).

6) Demam tinggi

Menurut Kemenkes RI (2020), demam tinggi pada masa kehamilan dapat mengindikasikan infeksi saluran kemih, malaria, atau korioamnionitis yang berbahaya bagi ibu dan janin.

7) Gangguan penglihatan

Menurut Prawiroharjo (2016), gangguan penglihatan seperti pandangan mata kabur, atau merasakan seperti melihat kilatan cahaya merupakan tanda peningkatan tekanan darah dan gangguan system syaraf pusat.

8) Oedema pada wajah, ekstremitas disertai sakit kepala

Oedema pada wajah, tangan, kaki dengan disertai sakit kepala hebat dapat mengarah pada kasus pre eklamsia. Preeklamsia adalah penyebab utama kematian maternal neonatal di dunia (WHO, 2019). Tanda gejala preeklamsia antara lain:

- a) Oedema disertai sakit kepala hebat
- b) Pandangan mata kabur
- c) Nyeri ulu hati

3. Edukasi tentang persiapan persalinan

a. Persiapan persalinan

Persalinan merupakan hal fisiologis yang menunjukkan telaha berakhirnya satu masa kehamilan dan berubah menjadi permulaan kehidupan bayi diluar kandungan. Sebagaimana besar persalinan berlangsung secara normal, namun bermacam-macam komplikasi dapat saja terjadi secara tiba-tiba sehingga dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi jika tidak dipersiapkan dari awal dengan baik. WHO (2019) memaparkan bahwa sebagian besar kematian ibu dapat dicegah melalui persiapan persalinan yang matang dan akses pelayanan kesehatan yang memadai. Persiapan persalinan adalah upaya yang dilakukan ibu hamil dan keluarga untuk mempersiapkan kondisi fisik, mental, social dan logistic dalam menghadapi persalinan dan kemungkinan komplikasi yang dapat dapat terjadi (Prawirohardjo, 2016).

Kurangnya edukasi tentang persiapan persalinan dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan, keterlambatan dalam mencapai

fasilitas kesehatan, serta tak jarang terlambat dalam mendapatkan pelayanan dan penanganan yang adekuat. Oleh karena itu, edukasi persiapan persalinan diharapkan menjadi bagian penting dalam pelayanan antenatal care yang komprehensif (Kemenked RI, 2020).

b. Prinsip edukasi

Menurut Notoatmojo (2014), pendekatan edukasi yang tepat dapat meningkatkan kepatuhan ibu terhadap rencana persalinan. Prinsip edukasi persiapan persalinan harus bersifat:

- 1) Berkesinambungan
- 2) Berbasis kebutuhan ibu
- 3) Mudah dipahami
- 4) Melibatkan keluarga

c. Komponen Edukasi persiapan persalinan

Dalam menghadapi proses persalinan, kondisi fisik yang optimal dan stamina yang baik dapat membantu menurunkan risiko komplikasi. Berikut adalah komponen edukasi persiapan persalinan, meliputi:

1) Persiapan Fisik

Komponen persiapan fisik dalam persiapan persalinan meliputi:

- a) Pemeriksaan kehamilan rutin
- b) Latihan fisik ringan
- c) Cukup Istirahat
- d) Pemenuhan nutrisi selama kehamilan
- e) Persiapan laktasi dan Perineum

2) Persiapan psikologis

Kesiapan psikologis yang baik dapat memberikan peran dalam kelancaran persalinan dan pengalaman melahirkan yang positif (WHO, 2019). Persiapan psikologis dapat membantu ibu untuk:

- a) Membantu kepercayaan diri
- b) Mengurangi kecemasan
- c) Menguasai teknik relaksasi dan pernafasan

3) Persiapan Sosial dan Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga terutama suami, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan ibu hamil dalam menghadapi persalinan. Keterlibatan keluarga membantu mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan kepatuhan ibu terhadap rencana persalinan (Kemenkes RI, 2020).

4) Persiapan tempat dan penolong persalinan

Perencanaan dalam persiapan dan penolong persalinan adalah hal yang sudah diputuskan bersama keluarga. Perencanaan ini merupakan bagian dari *Birth Preparedness And Complication Readiness* (BPCR) yang direkomendasikan oleh WHO (WHO, 2019). Persiapan yang perlu dilakukan oleh ibu meliputi:

- Menentukan tempat persalinan yang aman
- Tenaga kesehatan yang kompeten
- Jalur rujukan bila terjadi komplikasi

Tabel 3.1 *Birth Preparedness And Complication Readiness* (BPCR)

Komponen BPCR	Uraian	Tujuan
Penentuan Tempat Persalinan	Ibu hamil dan keluarga menentukan fasilitas kesehatan yang aman dan sesuai standar, seperti puskesmas PONEK atau rumah sakit PONEK.	Menjamin persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan yang mampu menangani komplikasi.
Penentuan Penolong Persalinan	Menetapkan tenaga kesehatan terlatih (bidan atau dokter) sebagai penolong persalinan.	Mengurangi risiko persalinan tidak aman dan komplikasi obstetri.
Persiapan Transportasi	Menentukan moda transportasi yang akan digunakan untuk menuju fasilitas kesehatan, termasuk alternatif jika terjadi kegawatdaruratan.	Mencegah keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan.
Persiapan Dana Persalinan	Menyiapkan dana cadangan untuk biaya persalinan, rujukan, dan kebutuhan tambahan.	Menghindari keterlambatan pelayanan akibat kendala finansial.
Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Memastikan ibu terdaftar dalam program jaminan kesehatan (misalnya JKN).	Menjamin akses pelayanan kesehatan tanpa hambatan administrasi.
Pendamping Persalinan	Menentukan orang yang akan mendampingi ibu selama persalinan (suami atau anggota keluarga).	Memberikan dukungan emosional dan membantu pengambilan keputusan.
Identifikasi Tanda Bahaya	Edukasi mengenai tanda bahaya kehamilan dan persalinan (perdarahan, nyeri hebat, ketuban pecah dini, penurunan gerak janin).	Mempercepat pengenalan kondisi gawat darurat.
Rencana Rujukan	Mengetahui fasilitas rujukan dan jalur rujukan apabila terjadi komplikasi.	Mengurangi keterlambatan penanganan kegawatdaruratan obstetri.
Persiapan Donor Darah	Mengidentifikasi calon donor darah yang sesuai golongan darah ibu.	Mengantisipasi perdarahan obstetri.
Persiapan Logistik Persalinan	Menyiapkan perlengkapan ibu dan bayi (pakaian, perlengkapan pribadi, dokumen).	Memastikan kebutuhan ibu dan bayi terpenuhi saat persalinan.

(sumber: WHO, 2019; Kemenkes RI, 2020; Prawirohardjo, 2016)

BPCR merupakan strategi penting dalam pelayanan kebidanan Antenatal Care untuk meningkatkan kesiap siagaan ibu hamil dalam menghadapi persalinan serta komplikasi yang mungkin terjadi. Implementasi BPCR secara optimal dapat mencegah keterlambatan mendapatkan penanganan medis.

5) Persiapan finansial dan administrasi

Persiapan finansial dan administrasi sangat penting untuk mencegah keterlambatan pelayanan yang disebabkan oleh kendala biaya dan administrasi (Kemenkes RO, 2020). Persiapan finansial dan administrasi meliputi:

- Dana cadangan persalinan
- Kepesertaan jaminan kesehatan

- c) Kelengkapan dokumen administrasi
- 6) Persiapan menghadapi Tanda bahaya persalinan

Pemahaman tanda bahaya dapat mempercepat pencarian pertolongan medis (Prawirohardjo, 2016). Ibu dan keluarga diharapkan dapat mempersiapkan dan memahami jika terjadi tanda bahaya persalinan, seperti:

 - a) Ketuban pecah dini
 - b) Perdarahan hebat
 - c) Nyeri perut hebat
 - d) Penurunan gerakan janin
- d. Metode edukasi

Pemilihan metode edukasi harus disesuaikan dengan karakteristik sasaran (Notoatmodjo, 2014). Edukasi persiapan persalinan dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu:

 - 1) Konseling individu pada saat ANC
 - 2) Kelas ibu hamil
 - 3) Edukasi kelompok
 - 4) Media cetak (Buku saku, leaflet)
 - 5) Media Audiovisual dan digital
- e. Peran tenaga kesehatan

Peran ini penting untuk memastikan ibu dan keluarga siap menghadapi persalinan secara aman (Kemenkes RI, 2020). Tenaga kesehatan, dalam hal ini Bidan berperan sebagai:

 - 1) Edukator
 - 2) Konselor
 - 3) Motivator
 - 4) Fasilitator rujukan
- f. Dampak edukasi persiapan persalinan

Edukasi persiapan persalinan yang diberikan kepada ibu hamil dan keluarga dapat memberikan dampak yang positif bagi persalinan. Menurut WHO (2019), dampak edukasi persalinan adalah sebagai berikut:

 - 1) Dampak jangka pendek
 - a) Meningkatkan kesiapan ibu
 - b) Mengurangi kecemasan
 - c) Meningkatkan kepatuhan ANC
 - 2) Dampak jangka panjang
 - a) Meningkatkan keselamatan ibu dan bayi
 - b) Menurunkan risiko komplikasi persalinan

- c) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kebidanan

C. Hambatan dalam Memberikan edukasi pada ibu hamil

Dalam memberikan edukasi terdapat hambatan, meliputi:

1. Kendala dari Faktor ibu

- a. Rendahnya tingkat pendidikan dan literasi kesehatan

Tingkat pendidikan dan literasi kesehatan pada ibu mempengaruhi ibu hamil sulit memahami informasi medis yang disampaikan. Hal tersebut dapat memberikan dampak pada rendahnya pemahaman pesan edukasi dan penerapan perilaku kesehatan yang dianjurkan (Notoatmodjo, 2019).

- b. Psikologis ibu

WHO (2019) menyebutkan, kecemasan, ketakutan, dan stress selama kehamilan dapat menghambat proses penerimaan informasi. Pada ibu hamil yang mengalami tekanan psikologis cenderung akan kurang fokus terhadap edukasi dan kurang mampu menyerap materi edukasi secara optimal.

- c. Kepercayaan dan budaya lokal

Kepercayaan tradisional dan mitos yang berkembang di masyarakat sering kali bertentangan dengan prinsip kesehatan modern. Prawirohardjo (2016), menyebutkan bahwa kepercayaan tradisional dan mitos dapat mengakibatkan ibu hamil lebih mudah mempercayai praktik tradisional dibandingkan anjuran tenaga kesehatan.

2. Kendala dari faktor media dan metode edukasi

- a. Keterbatasan media edukasi

Media edukasi yang terbatas, tidak menarik bahkan tidak sesuai dengan pemahaman ibu hamil sehingga menghambat proses pembelajaran. Media yang tidak kontekstual juga dapat menurunkan minat ibu untuk memahami materi edukasi (Kemenkes RI, 2020).

- b. Metode edukasi yang kurang variatif

WHO (2019) menjelaskan bahwa metode ceramah satu arah tanpa melibatkan ibu hamil secara aktif cenderung kurang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan perubahan perilaku.

3. Kendala dari system pelayanan kesehatan

- a. Akses pelayanan kesehatan yang terbatas

Jarak fasilitas kesehatan, keterbatasan transportasi, dan kendala biaya masih menjadi hambatan bagi ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan edukasi secara optimal (WHO, 2019).

- b. Kontinuitas edukasi yang tidak berkelanjutan

Pemberian edukasi yang tidak berkesinambungan dan tidak dilakukan evaluasi secara berkala dapat menyebabkan pesan kesehatan tidak terserap secara maksimal (Kemenkes RI, 2020)

4. Kendala dari faktor keluarga

a. Kurangnya dukungan keluarga

Dukungan keluarga, terutama suami dapat mempengaruhi keberhasilan edukasi pada ibu hamil. Kurangnya keterlibatan keluarga dapat menghambat pengambilan keputusan dan penerapan hasil edukasi dalam kehidupan sehari-hari (Kemenkes RI, 2020).

b. Dominasi pengambilan keputusan oleh keluarga

Keputusan terkait kesehatan ibu hamil masih didominasi oleh anggota keluarga tertentu, sehingga edukasi yang diberikan kepada ibu tidak semua dapat diimplementasikan secara mandiri (WHO, 2019).

D. Upaya Mengatasi Hambatan Edukasi

Untuk mengatasihambatan edukasi pada ibu hamil, maka diperlukan:

1. Keterlibatan keluarga dalam setiap sesi edukasi
2. Pendekatan edukasi yang sesuai yang sesuai tingkat literasi ibu
3. Peningkatan kapasitas komunikasi dengan tenaga kesehatan
4. Penggunaan media edukasi yang menarik dan kontekstual
5. Penguatan system pelayanan ANC yang berkesinambungan

E. Simpulan

Pemberian edukasi tanda bahaya kehamilan merupakan strategi penting dalam pencegahan komplikasi kehamilan. Peningkatan pengetahuan diikuti dengan peran keluarga dalam memberikan dukungan dapat menurunkan risiko kematian maternal dan neonatal. Ketepatan pengambilan keputusan dan kesiapan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan menjadi salah satu upaya dari edukasi dalam mencegah kematian maternal neonatal khususnya dalam keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan.

Selain itu, edukasi tentang persiapan juga merupakan komponen yang penting dalam pelayanan kesehatan maternal. Edukasi terstruktur dan berbasis kebutuhan ibu hamil dapat meningkatkan kesiapan fisik, psikologis dan social serta mencegah keterlambatan dalam penanganan kasus kegawatan obsterti. Pemberian edukasi yang optimal dapat berkontribusi dalam penurunan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi.

Kendala edukasi pada ibu hamil bersifat multidimensional, meliputi faktor individu, keluarga, tenaga kesehatan, media, dan system pelayanan kesehatan.

Upaya komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut agar edukasi kesehatan pada ibu hamil dapat berjalan efektif dan berkontribusi pada peningkatan keselamatan maternal neonatal.

F. Referensi

- Cunningham, FG., et al. 2018. *Williams Obstetrics* (25th ed.). Mc Graw: Hill Education
- Fatmawati Elis, dkk. 2025. *Terapi Komplementer sepanjang siklus kehidupan manusia*. Jakarta: PT. Nuansa Fajar Cemerlang
- Herliani Yulia, dkk. 2024. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan*. Jakarta: PT. Nuansa Fajar Cemerlang.
- Hou, Su I. (2014). *Health Education: Theoretical Concepts, Effective Strategies and Core Competencies*. Vol.15. WHO Library Cataloguing in Publication Data
- Kementrian Kesehatan RI. 2020. *Buku Kesehatan Ibu dan anak (KIA)*. Jakarta: Kemenkes RI
- Lestari A D, dkk. 2023. *Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Banten: Sada Kurnia Pustaka
- Notoatmodjo S., 2014. *Promosi Kesehatan dan Perilaku kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nursalam. (2015). *Metodologi Ilmu Keperawatan*, Edisi 4, Jakarta: Salemba Medika
- Prawirohardjo, S. (2016). *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo
- Putri Yessi, dkk. *Buku Ajar Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management
- Subriah, Muthia G., Endarwati S., Puji Angesti H., Anuhgera D.E., Sumini G.T., Suratmi, Yesti H. (2025). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Pranikah dan Prakonsepsi*. Jakarta: PT. Nuansa Fajar Cemerlang
- Suhartati, dkk. 2025. *Buku Tanda Bahaya dan Deteksi dini terhadap komplikasi dan penyulit ibu dan janin*. Jakarta: Mahakarya Citra Utama
- Sukini, Tuti. 2023. *Ketidaknyamanan masa kehamilan*. Magelang: Pusaka Rumah C1nta
- World Health Organization. 2019. *WHO Recommendation On Antenatal Care for a positive Pregnancy Experience*. Geneva: WHO

G. Glosarium

ACTH	= Adrenocorticotrophic hormone
ANC	= Antenatal Care
AKI	= Angka Kematian Ibu
BPCR	= <i>Birth Preparedness And Complication Readiness</i>
HCG	= Human Corionic Gonadotropin
HEG	= Hyperemesis Emesis Gravidarum
KET	= Kehamilan Ektopik Terganggu
SC	= Sectio Caesarea
WHO	= World Health Organisation
WUS	= Wanita Usia Subur

CHAPTER 4

ASUHAN PERSALINAN NORMAL: LANGKAH-LANGKAH DASAR YANG MUDAH DIPAHAMI

Sendy Pratiwi Rahmadhani, S.ST., Bdn., M.Keb.

A. Pendahuluan / Prolog

Pada saat mendapatkan pelayanan intranatal, berdasarkan hasil penelitian yang tertera pada buku panduan *intranatal care* oleh *World Health Organization* (WHO) tahun 2018 dengan prioritas pertanyaan "apa yang sebenarnya terjadi dan diinginkan pada perempuan?" didapatkan bahwa perempuan menginginkan pengalaman melahirkan yang positif (*positive experience*) yang memenuhi atau melebihi keyakinan serta harapan pribadi dan sosiokultural mereka sebelumnya. Beberapa pandangan wanita tentang *positive experience* adalah (1) persalinan normal tanpa intervensi; (2) ibu dan bayi sehat; (3) dukungan dari pendamping persalinan; (4) keinginan untuk dikontrol; dan (5) staff/tenaga kesehatan yang sensitif, peduli, baik, dan *respectful* (penuh rasa hormat).

Area pelayanan seorang bidan adalah pada kehamilan dan persalinan Normal. Bidan sangat berperan dalam persalinan dan kelahiran normal. Meningkatkan persalinan normal berarti menurunkan angka *sectio caesarea* (SC) yang tidak sesuai indikasi. Fokus pelayanan bidan adalah memberi informasi, pendidikan dan dukungan terlebih pada primigravida dan bahkan kepada ibu post SC. Bidan memfasilitasi persalinan sesuai dengan konsep kebidanan dan memberikan asuhan persalinan fisiologis yang berkualitas.

Tenaga kesehatan dalam hal ini bidan, perlu memahami dan menerima pengetahuan terkini yang aman dan efektif terkait dengan pelaksanaan asuhan kepada perempuan. Proses persalinan yang dilakukan secara fisiologis menghasilkan beberapa manfaat, seperti durasi persalinan lebih singkat, penurunan angka kasus gawat janin, perdarahan post partum, kejadian ruptur perineum dan persalinan SC. Perubahan praktik asuhan persalinan menitikberatkan pada kebutuhan dasar ibu dan bayi, serta konsep fisiologis asuhan kebidanan. Tugas utama bidan adalah melindungi perempuan terhadap pengaruh yang menghalangi proses fisiologis persalinan.

B. Peran Bidan Selama Persalinan

1. Menegakkan Diagnosis

Menentukan apakah pasien in partu atau belum merupakan suatu diagnosis penting dalam obstetrik. Bila persalinan tidak terdiagnosis, maka janin kemungkinan akan berdampak akibat komplikasi-komplikasi yang tidak diharapkan. Bila telah didiagnosis in partu, padahal pasien belum inpartu, maka besar kemungkinan pasien mendapat intervensi yang sebetulnya tidak perlu. Namun, bila suatu saat Bidan kesulitan untuk membedakan in partu atau tidak, maka sebaiknya tinjau sifat-sifat dasar kontraksi.

Tabel 4.1 Sifat-Sifat Kontraksi

His Persalinan	Kontraksi belum In Partu
Kontraksi bersifat reguler/teratur	Interval tidak teratur dan tetap panjang
Interval memendek secara peralihan	Interval tetap
Intensitas bertambah	Intensitas tidak berubah
Nyeri pada area belakang abdomen	Nyeri terutama pada perut bagian bawah
Serviks mendatar/membuka	Tidak ada perubahan pada serviks
Nyeri tidak berhenti	Sakit hilang dan timbul

Pimpinan kala I dimulai dengan langkah-langkah berikut ini:

- Memeriksa pasien dengan teliti
- Melakukan observasi yang cermat apakah berlangsung dengan baik
- Mempertahankan kekuatan pasien dan moril pasien

Meskipun kala I tidak menyenyeri kala II, akan tetapi kala ini durasinya paling lama. Pasien cenderung bersifat pasif hingga pasien bisa saja putus asa.

2. Memberikan Dukungan Selama Proses Kelahiran

a. Komunikasi

- Jelaskan semua prosedur, minta persetujuan, dan diskusikan hasil pemeriksaan (temuan) kepada ibu dan pendamping.
- Terus beritahu ibu tentang kemajuan persalinan.
- Beri pujian, support, dan yakinkan ibu bahwa semuanya berjalan dengan baik.
- Pastikan dan hormati privasi selama pemeriksaan dan proses diskusi/Konseling Informasi Edukasi (KIE).
- Jika diketahui terinfeksi HIV, cari tahu apa yang telah dia katakan kepada pendampingnya. Hormati keinginannya.*

b. Kebersihan

- Dorong wanita untuk mandi atau mandi atau mencuci diri dan alat kelamin pada awal persalinan.
- Bersihkan area vulva dan perineal sebelum setiap pemeriksaan.

- 3) Cuci tangan anda dengan sabun sebelum dan sesudah setiap pemeriksaan. Gunakan sarung tangan steril untuk pemeriksaan vagina.
 - 4) Memastikan kebersihan dan area persalinan.
 - 5) Bersihkan tumpahan segera.
 - 6) Jangan melakukan tindakan enema (tindakan memasukkan cairan rektal yang digunakan untuk membersihkan dan merangsang pengosongan usus).
- c. Mobilitas
- 1) Dorong wanita itu untuk berjalan-jalan dengan bebas selama persalinan tahap pertama.
 - 2) Mendukung pilihan posisi wanita (lateral kiri, jongkok, berlutut, berdiri didukung oleh untuk setiap tahap persalinan dan pengiriman).
- d. Urinasi/Berkemih
- Anjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemih. Ingatkan ibu setiap 2 jam.
- e. Makan dan Minum
- 1) Anjurkan ibu untuk makan dan minum sesuai keinginannya sepanjang proses persalinan.
 - 2) Minuman cair bergizi penting, bahkan pada persalinan akhir.
 - 3) Jika ibu terlihat letih berat selama persalinan, pastikan dia makan dan minum.
- f. Teknik Pernapasan
- 1) Ajari ibu untuk memperhatikan pernapasan normalnya.
 - 2) Anjurkan ibu untuk bernapas perlahan, dan bersantai dengan setiap napas.
 - 3) Jika ibu merasa pusing, tidak sehat, adalah merasa kesemutan di wajah, tangan dan kakinya, anjurkan ibu untuk bernapas perlahan.
 - 4) Untuk mencegah dorongan mendedan pada akhir kala I persalinan, ajari ibu untuk bernapas dengan mulut, untuk mengambil napas dalam (2 napas pendek) diikuti dengan hembusan napas panjang.
 - 5) Selama kelahiran kepala, minta ibu untuk tidak mendedan tetapi bernapas terus.
- g. Pain and Discomfort Relief
- 1) Sarankan perubahan posisi ibu.
 - 2) Anjurkan untuk mobilisasi, senyaman ibu.
 - 3) Anjurkan pendamping untuk:
 - a) Massage punggung ibu
 - b) Genggam tangan ibu dan usap wajah ibu diantara kontraksi
 - 4) Anjurkan ibu untuk menggunakan teknik pernapasan.
 - 5) Anjurkan ibu mandi air hangat, jika tersedia

h. Pendamping Persalinan

- 1) Anjurkan dukungan dari pendamping kelahiran yang dipilih ibu untuk menemaninya sepanjang persalinan.
- 2) Jelaskan kepada pendamping kelahiran apa yang harus dia lakukan:
 - a) Selalu bersama ibu.
 - b) Support ibu.
 - c) Membantu ibu untuk bernapas dan rileks.
 - d) Usap punggung ibu, bersihkan keningnya dengan kain basah, lakukan tindakan suportif lainnya.
 - e) Berikan support dengan menggunakan praktik lokal (budaya) yang tidak mengganggu proses kelahiran dan persalinan
 - f) Rangkul/tuntun ibu untuk bergerak bebas sesuai keinginannya dan mencari posisi (nyaman) sesuai pilihannya.
 - g) Berilah ibu minum dan makan sesuai keinginannya.
 - h) Bantu ibu ke toilet ketika diperlukan.

C. Asuhan Sayang Ibu

Asuhan sayang ibu adalah asuhan dengan prinsip saling menghargai budaya, kepercayaan dan keinginan sang ibu. Asuhan dengan prinsip saling menghargai budaya, kepercayaan dan keinginan sang ibu, tujuannya untuk membantu ibu merasakan kenyamanan dan keamanan dalam menghadapi proses persalinan. Salah satu hal yang dapat membantu proses kelancaran persalinan adalah hadirnya seorang pendamping saat proses persalinan ini berlangsung.

1. Asuhan sayang ibu dapat diberikan pada persalinan setiap kala persalinan

- a. Ibu tetap di perbolehkan makan dan minum
- b. Ibu diperbolehkan untuk memilih siapa pendamping persalinannya
- c. Pengaturan posisi persalinan pada persalinan kala II
- d. Tindakan episiotomy harus berdasarkan indikasi
- e. Proses penjahitan luka jalan lahir harus menggunakan anestesi terlebih dahulu
- f. Pendamping pada Proses Persalinan
- g. Pendamping persalinan dapat memberikan dukungan baik secara emosional maupun fisik kepada ibu selama proses persalinan.
- h. Kehadiran suami juga merupakan dukungan moral karena pada saat ini ibu sedang mengalami stress yang sangat berat tapi dengan kehadiran suami ibu dapat merasa sedikit rileks karena merasa ia tidak perlu menghadapi ini semua seorang diri.
- i. Pendamping persalinan juga dapat ikut terlibat langsung dalam memberikan asuhan misalnya ikut membantu ibu dalam mengubah posisi sesuai dengan

tingkat kenyamanannya masing – masing, membantu memberikan makan dan minum.

- j. Pendamping persalinan juga dapat menjadi sumber pemberi semangat dan dorongan kepada ibu selama proses persalinan sampai dengan kelahiran bayi.
- k. Dengan adanya pendamping persalinan ibu merasa lebih aman dan nyaman karena merasa lebih diperhatikan oleh orang yang mereka sayangi.
- l. Ibu yang memperoleh dukungan emosional selama persalinan akan mengalami waktu persalinan yang lebih singkat, intervensi yang lebih sedikit, sehingga hasil persalinan akan lebih baik.

2. Pengaturan posisi persalinan pada persalinan kala II

Pada saat proses persalinan akan berlangsung, ibu biasanya di anjurkan untuk mulai mengatur posisi telentang/litotomi. Evidence:

- a. Bahwa posisi telentang pada proses persalinan dapat mengakibatkan berkurangnya aliran darah ibu ke janin.
- b. Posisi telentang dapat berbahaya bagi ibu dan janin, selain itu posisi telentang juga mengalami kontraksi lebih nyeri, lebih lama, trauma perineum yang lebih besar.
- c. Posisi telentang/litotomi juga dapat menyebabkan kesulitan penurunan bagian bawah janin.
- d. Posisi telentang bisa menyebabkan hipotensi karena bobot uterus dan isinya akan menekan aorta, vena kava inferior serta pembuluh-pembuluh lain dalam vena tersebut.
- e. Hipotensi ini bisa menyebabkan ibu pingsan dan seterusnya bisa mengarah ke anoreksia janin.
- f. Posisi litotomi bisa menyebabkan kerusakan pada saraf di kaki dan di punggung dan akan timbul rasa sakit yang lebih banyak di daerah punggung pada masa post partum.

3. Asuhan Sayang Ibu pada Kala I

- a. Memberikan dukungan emosional.
- b. Pendampingan anggota keluarga selama proses persalinan sampai kelahiran bayinya
- c. Menghargai keinginan ibu untuk memilih pendamping selama persalinan.
- d. Memberikan cairan nutrisi dan hidrasi. Memberikan kecukupan energi dan mencegah dehidrasi. Oleh karena dehidrasi menyebabkan kontraksi tidak teratur dan kurang efektif.
- e. Peran aktif anggota keluarga selama persalinan dengan cara:
 - 1) Mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati dan memuji ibu.
 - 2) Membantu ibu bernafas dengan benar saat kontraksi.

- 3) Melakukan massage pada tubuh ibu dengan lembut.
 - 4) Menyeeka wajah ibu dengan lembut menggunakan kain.
 - 5) Menciptakan suasana kekeluargaan dan rasa aman.
- f. Memberikan keleluasaan untuk menggunakan kamar mandi secara teratur dan spontan
- 1) Kandung kemih penuh menyebabkan gangguan kemajuan persalinan dan menghambat turunnya kepala
 - 2) Menyebabkan ibu tidak nyaman
 - 3) Meningkatkan resiko perdarahan pasca persalinan; mengganggu penatalaksanaan distosia bahu
 - 4) Meningkatkan resiko infeksi saluran kemih pasca persalinan.
- g. Pencegahan infeksi
- Tujuan dari pencegahan infeksi adalah untuk mewujudkan persalinan yang bersih dan aman bagi ibu dan bayi; menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi baru lahir.

4. Asuhan Sayang Ibu pada Kala II

- a. Pendampingan ibu selama proses persalinan sampai kelahiran bayinya oleh suami dan anggota keluarga yang lain.
- b. Keterlibatan anggota keluarga dalam memberikan asuhan antara lain:
 - 1) Membantu ibu untuk berganti posisi.
 - 2) Melakukan rangsangan taktil.
 - 3) Memberikan makanandan minuman.
 - 4) Menjadi teman bicara/pendengar yang baik.
 - 5) Memberikan dukungan dan semangat selama persalinan sampai kelahiran bayinya
- c. Keterlibatan penolong persalinan selama proses persalinan & kelahiran – dengan:
 - 1) Memberikan dukungan dan semangat kepada ibu dan keluarga.
 - 2) Menjelaskan tahapan dan kemajuan persalinan.
 - 3) Melakukan pendampingan selama proses persalinan dan kelahiran.
- d. Membuat hati ibu merasa tenteram selama kala II persalinan dengan cara memberikan bimbingan dan menawarkan bantuan kepada ibu.
- e. Menganjurkan ibu meneran bila ada dorongan kuat dan spontan untuk meneran dengan cara memberikan kesempatan istirahat sewaktu tidak ada his.
- f. Mencukupi asupan makan dan minum selama kala II.
- g. Pencegahan infeksi pada kala II dengan membersihkan vulva dan perineum ibu.
- h. Membantu ibu mengosongkan kandung kemih secara spontan.

- i. Memberikan rasa aman dan nyaman dengan cara:
 - 1) Mengurangi perasaan tegang.
 - 2) Membantu kelancaran proses persalinan dan kelahiran bayi.
 - 3) Memberikan penjelasan tentang cara dan tujuan setiap tindakan penolong.
 - 4) Menjawab pertanyaan ibu.
 - 5) Menjelaskan apa yang dialami ibu dan bayinya.
 - 6) Memberitahu hasil pemeriksaan.

5. Asuhan Sayang Ibu pada Kala III

- a. Memberikan kesempatan kepada ibu untuk memeluk bayinya dan menyusui segera.
- b. Memberitahu setiap tindakan yang akan dilakukan.
- c. Pencegahan infeksi pada kala III.
- d. Memantau keadaan ibu (tanda vital, kontraksi, perdarahan).
- e. Melakukan kolaborasi/rujukan bila terjadi kegawatdaruratan.
- f. Pemenuhan kebutuhan nutrisi dan hidrasi.
- g. Memberikan motivasi dan pendampingan selama kala III.

6. Asuhan Sayang Ibu pada Kala IV

- a. Memastikan tanda vital, kontraksi uterus, perdarahan dalam keadaan normal.
- b. Membantu ibu untuk berkemih.
- c. Mengajarkan ibu dan keluarganya tentang cara menilai kontraksi dan melakukan massase uterus.
- d. Menyelesaikan asuhan awal bagi bayi baru lahir.
- e. Mengajarkan ibu dan keluarganya tentang tanda-tanda bahaya post partum seperti perdarahan, demam, bau busuk dari vagina, pusing, lemas, penyulit dalam menyusui bayinya dan terjadi kontraksi hebat.
- f. Pemenuhan kebutuhan nutrisi dan hidrasi.
- g. Pendampingan pada ibu selama kala IV.
- h. Nutrisi dan dukungan emosional.

D. Pengetahuan dan Keterampilan Klinik Kebidanan dalam Persalinan dan Kelahiran yang Normal dan Kondisi Komplek

1. Kala I Persalinan : Fase Laten

Asuhan intranatal pada ibu dalam fase laten dengan pembukaan serviks 0-3 cm dan kontraksi masih lemah (2x dalam 10 menit).

- a. Monitor setiap Jam
 - 1) Tanda-tanda emergensi
 - 2) Frekuensi, intensitas, dan durasi kontraksi.
 - 3) Denyut jantung janin.

- 4) Suasana hati dan perilaku ibu (tertekan, cemas).
- b. Monitor setiap 4 jam
 - 1) Dilatasi serviks
 - 2) Kecuali diindikasikan, jangan lakukan pemeriksaan vagina lebih sering daripada setiap 4 jam
 - 3) Suhu
 - 4) Tekanan darah
 - 5) Catat temuan secara berkala pada catatan persalinan
 - 6) Catat waktu membran pecah dan warna cairan amnion
 - 7) Berikan dukungan
 - 8) Jangan pernah meninggalkan ibu sendirian
- c. Kemajuan persalinan

Tabel 4.2 Penilaian Kemajuan Persalinan

Nilai Kemajuan Persalinan	Tindakan
Setelah 8 jam, jika: Kontraksi semakin kuat dan sering, tetapi tidak ada kemajuan dilatasi serviks dengan dan tanpa ruptur membran.	Rujuk ibu ke rumah sakit
Setelah 8 jam, jika: 1) Tidak ada peningkatan kontraksi 2) Ruptur membran 3) Tidak ada kemajuan dalam dilatasi serviks	Pulangkan ibu dan sarankan ibu untuk kembali, jika: 1) Ada peningkatan intensitas nyeri atau ketidaknyamanan 2) Perdarahan per-vaginam 3) Ruptur membran
Dilatasi serviks 4 cm atau lebih	Memulai partograf dan kelola ibu persalinan aktif

2. Kala I Persalinan : Fase Aktif

Asuhan Intranatal dengan dilatasi serviks ≥ 4 cm

- a. Monitor setiap 30 menit:
 - 1) Tanda-tanda emergensi
 - 2) Frekuensi, intensitas, dan durasi kontraksi
 - 3) Denyut jantung janin
 - 4) Mood dan tingkah laku ibu (distress, cemas)
- b. Monitor setiap 4 jam:
 - 1) Dilatasi serviks
 - 2) Kecuali diindikasikan, jangan lakukan pemeriksaan vagina lebih sering daripada setiap 4 jam
 - 3) Suhu
 - 4) Tekanan darah

c. Nilai kemajuan persalinan

Tabel 4.3 Penilaian dan Intervensi Selama Kala I

Parameter	Frekuensi Kala I Fase Laten	Frekuensi Kala I Fase Aktif
Tekanan darah	4 jam	4 jam
Suhu (tiap 4 jam)	2 jam	
Nadi	30-60 menit	30-60 menit
Denyut jantung janin	1 jam	30 menit
Kontraksi	30 menit	
Pembukaan serviks	4 jam*	4 jam*
Penurunan kepala	4 jam*	4 jam*
Warna cairan ketuban	4 jam*	4 jam*
Penyusupan	4 jam*	4 jam*

*Dinilai pada setiap pemeriksaan dalam

1) Jika partograf melewati garis waspada:

- Menilai kembali ibu dan mempertimbangkan kriteria untuk rujukan.
- Hubungi senior jika tersedia. Siagakan layanan transportasi darurat.
- Anjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemih.
- Pastikan hidrasi yang memadai tetapi tidak dibenarkan untuk makanan padat.
- Posisikan ibu dalam posisi tegak dan berjalan jika wanita menginginkannya.
- Pantau secara intensif. Menilai kembali dalam 2 jam dan rujuk jika tidak ada kemajuan. Jika rujukan membutuhkan waktu lama, rujuk segera (JANGAN menunggu untuk melewati garis tindakan)

2) Jika partograf melewati garis BERTINDAK:

Rujuk ke rumah sakit

3) Dilatasi serviks 10 cm

Manage kala II persalinan

3. Kala II Persalinan : Melahirkan Bayi dan Asuhan Segera Bayi Baru Lahir (BBL)

Dilatasi servis 10 cm, perineum menonjol & tipis, dan kepala crowning.

a. Monitor setiap 5 menit:

- Tanda-tanda darurat.
- Frekuensi, intensitas, dan durasi kontraksi.
- Detak jantung janin.
- Perineum menipis dan menonjol.
- Terlihat turunnya kepala janin atau selama kontraksi.
- Suasana hati dan perilaku (tertekan, cemas)

- 7) Catat temuan secara teratur dalam catatan persalinan dan Partograf
- 8) Beri dukungan (support) kepada ibu
- 9) Jangan pernah meninggalkan ibu sendirian

b. Melahirkan Bayi:

- 1) Pastikan semua peralatan pertolongan persalinan dan persediaan, termasuk peralatan resusitasi BBL, tersedia, dan tempat persalinan bersih dan hangat (25 derajat celcius).
- 2) Pastikan bladder/kandung kemih ibu kosong
- 3) Bantu ibu mencapai posisi nyaman sesuai pilihannya
- 4) Tetapi bersama ibu dan berikan dukungan emosional dan fisik (*emotional & physical support*)
- 5) Jika tidak bisa berkemih dan kandung kemih penuh, kosongkan kandung kemih.
- 6) Jangan biarkan ibu berbaik datar (horizontal) pada punggungnya.
- 7) Jika ibu stress, bantu meredakan nyeri dan ketidaknyamanan
- 8) Biarkan ibu meneran seperti yang ia inginkan dengan kontraksi

Tindakan :

- 1) Jangan mendesak ibu untuk meneran
- 2) Jika, dalam 30 menit usaha mengedan spontan, perineum tidak menjadi tipis dan meregang dengan kontraksi, lakukan VT untuk memastikan dilatasi serviks
- 3) Jika serviks tidak berdilatasi maximum, tunggu kala II. Posisikan ibu miring kiri dan hentikan usaha meneran.
- 4) Dorong ibu untuk teknik pernapasan.
- 5) Tunggu sampai kepala terlihat dan perineum tertekan.
- 6) Cuci tangan dengan air bersih dan sabun.
- 7) Kenakan sarung tangan steril sebelum persalinan.
- 8) Lihat tindakan pencegahan infeksi universal selama persalinan dan pengiriman

Tindakan:

- 1) Jika kala II berlangsung selama 2 jam atau lebih tanpa terlihat turunnya kepala yang stabil, segera rujuk ke rumah sakit.
- 2) JANGAN melakukan episiotomi tanpa ada indikasi.
- 3) Di hadapan obstruksi fisik karena lesi atau jaringan parut di perineum, keputusan untuk melakukan episiotomi dapat diambil.
- 4) Pastikan kelahiran kepala yang terkontrol:

- a) Lakukan perasat ritgen, yaitu tangan kanan & kain steril memegang dagu janin pada perineum posterior (antara anus dan os koksigidis). Tangan kiri menahan kepala utk mengatur kepala. dengan kontraksi.
- b) Support perineum dengan tangan lain dan menutupi anus dengan alas yang dipegang di posisi berdampingan selama kelahiran.
- c) Anjurkan ibu untuk kontrol pernapasan selama kelahiran kepala.
- 5) Jika meneran berpotensi merusak (perineum), berikan lebih banyak tekanan pada perineum.
- 6) Buang sanggahan kotor untuk mencegah infeksi
- 7) Raba leher janin untuk mengidentifikasi lilitan tali pusat
- 8) Cek jika wajah bersih dari mukus dan membran

Tindakan:

- 1) Jika tali pusat lahir dan longgar, lahirkan bayi melalui lilitan talipusat atau selipkan tali pusat di atas kepala bayi; jika kabel ketat, jepit dan potong tali pusat, lalu lepaskan.
- 2) Bersihkan wajah dengan lembut dengan kain kasa atau kain, jika perlu.
- 3) Penyedotan/suction atau aspirasi rutin tidak dianjurkan. Itu hanya harus dilakukan jika ada zat padat yang menghalangi hidung dan mulut bayi.
- 4) Tunggu bayi melakukan putaran paksi luar (spontan) dan lahirkan (dalam 1-2 menit)
- 5) Lakukan gerakan kebawah (dengan tekanan lembut) untuk melahirkan bahu depan.
- 6) Arahkan bayi ke atas, menuju abdomen ibu untuk melahirkan bahu belakang
- 7) Letakkan bayi di atas abdomen ibu atau dilengan ibu
- 8) Catat waktu kelahiran bayi

Tindakan:

- 1) Jika terjadi keterlambatan dalam melahirkan bahu:
 - a) JANGAN PANIK, segera minta bantuan dan meminta pendamping untuk membantu
 - b) Manajemen distosia bahu.
- 2) Jika menempatkan bayi di atas perut ibu tidak dapat dilakukan, atau ibu tidak dapat menggendong bayi, tempatkan bayi di tempat yang bersih, hangat, aman, dan dekat dengan ibu

E. Kala III Persalinan: Manajemen Aktif Kala III

1. Uterotonika untuk pencegahan perdarahan post partum

- a. Penggunaan uterotonika sebagai pencegahan perdarahan post partum selama kala III persalinan direkomendasikan untuk semua kelahiran.
- b. Oksitosin (10 IU) merupakan uterotonika yang direkomendasikan untuk pencegahan perdarahan post partum dan dapat diberikan secara intramuskular.

2. Waktu yang penjepitan tali pusat

- a. Penundaan penjepitan tali pusat (minimal 1 menit setelah kelahiran) direkomendasikan oleh WHO untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, serta luaran nutrisi, seperti salah satu pencegahan fisiologis anemia dan menurunkan insiden transfusi darah pada bayi baru lahir baik cukup bulan maupun preterm.
- b. Pada langkah ke-30 Asuhan Persalinan Normal, penjepitan dan pemotongan tali pusat dilakukan dalam 2 menit setelah kelahiran.
- c. Peregangan Tali Pusat Terkendali (PTT): PTT direkomendasikan untuk persalinan pervaginam.

3. Massase Uterus

Massase uterus berkelanjutan tidak dianjurkan sebagai intervensi untuk mencegah perdarahan post partum pada ibu yang telah menerima oksitosin profilaksis.

F. Kesimpulan

Memberikan informasi yang jujur dan akurat serta dukungan pada ibu bersalin secara kontinu dan memastikan ia mempunyai otonomi untuk membuat pilihan atas asuhan yang akan diterima. Monitoring denyut jantung janin dapat dilakukan setiap 5 menit atau setiap setelah kontraksi untuk mendeteksi abnormalitas pada denyut jantung janin. Tanda-tanda vital ibu dipantau secara rutin dan frekuensinya harus lebih sering apabila ada hipertensi, pre eklamsia, anemia, atau penyakit jantung. Hadirkan pendamping persalinan, secara terus menerus selama proses persalinan. Manajemen rasa nyeri berikan dengan teknik non farmakologis sesuai keinginan ibu. Bidan harus menerima dan memiliki rasa empati serta rasa hormat atas sikap dan perilaku ibu yang mungkin saja merasakan keletihan, berteriak, dan kurang kooperatif. Pemenuhan kebutuhan cairan dan nutrisi, anjurkan keluarga untuk menawarkan makan dan minum di antara kontraksi. Pastikan kandung kemih tidak penuh dan beri kebebasan ibu untuk memilih posisi persalinan.

G. Referensi

- ACOG. (2017). *Committee Opinion No 814: Delayed Umbilical Cord Clamping After Birth*. The American College of Obstetricians and Gynecologists. Vol. 136, Issue 6, pp. e100-e106)
- Cunningham FG. Williams Obstetrics, Edisi ke-23 atau ke-25. Jakarta: EGC atau McGraw-Hill Education
- JNPK-KR. 2017. Buku Acuan Persalinan Normal. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Krisnadi, SR. Pribadi, A. 2019. *Obstetri Fisiologi Ilmu Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Sagung Seto
- World Health Organization. 2018. WHO recommendations Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience. Tersedia di <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/272447/WHO-RHR-18.12-eng.pdf>

H. Glosarium

APN	= Asuhan Persalinan Normal
BBL	= Bayi Baru Lahir
HIV	= <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
KIE	= Konseling Informasi Edukasi
PTT	= Peregangan Tali Pusat Terkendali
WHO	= <i>World Health Organization</i>

CHAPTER 5

MANAGEMEN NYERI PERSALINAN DENGAN TEKNIK NONFARMAKOLOGIS

Veryudha Eka Prameswari, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan / Prolog

Persalinan adalah suatu proses fisiologis yang alami namun sering diiringi oleh nyeri hebat yang dirasakan oleh ibu. Nyeri persalinan merupakan sensasi sensorik dan emosional yang kompleks serta dipengaruhi oleh aspek biologis, psikologis, sosial, dan budaya World Health Organization, 2018, sebagaimana dikutip dalam (Kusfaningrum, A., Rejeki, S., & Astuti, R., 2024). Nyeri yang tidak tertangani dapat memicu kecemasan, ketegangan otot, dan perubahan fisiologis yang berdampak negatif pada ibu dan janin.

Manajemen nyeri persalinan penting dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan ibu serta mendukung proses persalinan yang aman dan positif. Sementara pendekatan farmakologis seperti epidural efektif dalam mengurangi nyeri, pendekatan nonfarmakologis menjadi alternatif yang aman, tanpa efek samping sistemik, kost-efektif dan berfokus pada dukungan fisiologis serta psikologis ibu (Prabandari, F., Sofiana, J., & Rosmawati, 2023).

Teknik nonfarmakologis semakin direkomendasikan dalam praktik kebidanan modern sebagai bagian dari pendekatan holistik terhadap persalinan. Manajemen nyeri persalinan dengan teknik nonfarmakologis menekankan pendekatan holistik yang melibatkan aspek fisik, emosional, dan psikologis ibu. Pendekatan ini sejalan dengan konsep woman-centered care, yang menempatkan ibu sebagai subjek aktif dalam proses persalinan dan pengambilan keputusan terkait kenyamanan serta kesehatannya (Prabandari, F., Sofiana, J., & Rosmawati, 2023).

Berbagai metode pengelolaan nyeri, baik farmakologis maupun non-farmakologis, tersedia dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta preferensi individu ibu bersalin. Pemahaman mendalam tentang fisiologi nyeri, serta teknik manajemen yang ada, menjadi esensial bagi tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan yang komprehensif dan sesuai. (Nur Hidayah, S., & Prasodjo, I., 2024)

Dalam praktik kebidanan modern, manajemen nyeri persalinan menjadi bagian penting dari asuhan yang berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan ibu. Pendekatan farmakologis memang efektif dalam menurunkan nyeri, namun penggunaannya dapat disertai efek samping tertentu dan membutuhkan fasilitas

khusus. Oleh karena itu, teknik nonfarmakologis semakin direkomendasikan sebagai alternatif atau pelengkap yang aman, murah, dan mudah diterapkan (World Health Organization (World Health Organization, 2018)

Berdasarkan Penelitian dari (Karlina, N. E., 2016) Pengelolaan nyeri persalinan membutuhkan asuhan sayang ibu. Diperlukan suatu manajemen nyeri dalam persalinan dengan metode non farmakologi, salah satunya akupresur dan Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation(TENS)dengan tujuan meningkatkan rasa aman dan nyaman pada ibu bersalin. Tujuan penelitian ini adalah menentukan pengaruh tehnik akupresur dan TENS terhadap intensitas nyeri persalinan kala I fase aktif. Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kampar Kiri Tengah dan Puskesmas Perhentian Raja. Jenis penelitian eksperimental dengan post test only control group desain dengan pengambilan sampel secara consecutive sampling. Jumlah sampel 20 responden setiap kelompok total sampel 60 responden. Data dianalisis univariat dan bivariat menggunakan uji chi-square. Proporsi intensitas nyeri dengan kategori sedang pada kelompok intervensi akupresur lebih besar dari pada kelompok kontrol pada pembukaan serviks 4 cm. Berdasarkan uji statistik terdapat pengaruh bermakna dimana nilai $p=0,011(<0,05)$. Terdapat pengaruh yang bermakna antara kelompok intervensi TENS dan kontrol pada pembukaan serviks 8 cm dengan nilai $p=0,011(<0,05)$. Kesimpulan pengaruh akupresur lebih baik digunakan pada pembukaan 4 cm, sedangkan pengaruh TENS lebih baik digunakan pada pembukaan 8 cm. Kata kunci: intensitas nyeri, akupresur, TENS

B. Konsep Dasar Nyeri Persalinan

1. Definisi Nyeri

Nyeri persalinan merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat rangsangan fisiologis selama proses persalinan. Pada kala I persalinan, nyeri terutama disebabkan oleh kontraksi uterus dan dilatasi serviks, sedangkan pada kala II nyeri muncul akibat peregangan jaringan vagina, perineum, dan tekanan janin pada struktur panggul (Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, K. R., 2020).

Intensitas nyeri persalinan bersifat subjektif dan sangat bervariasi pada setiap ibu. Faktor-faktor yang memengaruhi nyeri persalinan antara lain usia, paritas, durasi persalinan, kondisi psikologis, tingkat kecemasan, budaya, serta dukungan sosial yang diterima selama persalinan (Simkin, P., & Bolding, A., 2018). Ibu dengan tingkat kecemasan tinggi cenderung merasakan nyeri yang lebih intens dibandingkan ibu yang merasa tenang dan mendapatkan dukungan emosional yang baik.

Teori *gate control* menjelaskan bahwa persepsi nyeri dapat dimodulasi melalui stimulasi sensorik non-nyeri. Stimulasi tersebut dapat “menutup gerbang” impuls nyeri pada sistem saraf pusat sehingga intensitas nyeri yang dirasakan menjadi berkurang. Prinsip ini menjadi dasar penggunaan berbagai teknik nonfarmakologis dalam manajemen nyeri persalinan.

Nyeri merupakan sensasi yang bersifat sangat subyektif. Association for the study of pain mendefinisikan bahwa nyeri merupakan pengalaman emosional dan sensorik yang tidak menyenangkan yang muncul dari kerusakan jaringan secara aktual atau potensial atau menunjukkan adanya kerusakan. Nyeri merupakan pengalaman mekanisme protektif bagi tubuh dan menyebabkan individu bereaksi untuk menghilangkan rangsang nyeri (Sri, 2020)

2. Persepsi Nyeri

Persepsi nyeri merupakan proses dimana stimulus nyeri disalurkan dari tempat terjadinya stimulus menuju sistem saraf pusat. Proses tersebut biasanya dimulai dari sebagai berikut:

- a. Kontak dengan stimulus yang dapat berupa rasa tekan, rasa tusuk, teriris, kimia dan luka bakar.
- b. Penerima rangsang (*Resepsi*) dimana ujung saraf menerima stimulus.
- c. Proses transmisi (*Transmission*) dimana saraf akan menghantarkan sinyal nyeri menuju susunan saraf pusat. Penghantar informasi selalu melibatkan beberapa neuron pada susunan saraf pusat, kemudian penerimaan rangsang nyeri pada pusat nyeri susunan saraf pusat, selanjutnya otak menerima informasi (sinyal) dan memerintahkan organ untuk bereaksi.

Nyeri yang dialami oleh perempuan dalam persalinan diakibatkan oleh kontraksi uterus, dilatasi serviks; dan pada akhir kala I dan pada kala II oleh peregangan vagina dan dasar pelvis untuk menampung bagian presentasi. Rasa tidak nyaman (nyeri) selama persalinan kala I disebabkan oleh dilatasi dan penipisan serviks serta iskemia uterus hal ini dikarenakan penurunan aliran darah sehingga oksigen lokal mengalami defisit akibat kontraksi arteri miometrium, nyeri ini disebut nyeri visceral. Sedangkan pada akhir kala I dan kala II, nyeri yang dirasakan pada daerah perineum yang terjadi akibat peregangan perineum, tarikan peritonium dan daerah uteroservikal saat kontraksi, penekanan vesika urinaria, usus dan struktur sensitif panggul oleh bagian terendah janin, nyeri ini disebut nyeri somatic. (Rachmawati & Nurliyani, 2024)

Rasa nyeri pada alat-alat tubuh di daerah pelvis, terutama pada daerah traktus genitalia interna disalurkan melalui susunan saraf simpatik menyebabkan kontraksi dan vasokonstriksi. Sebaliknya saraf parasimpatik mencegah kontraksi dan menyebabkan vasodilatasi. Oleh karena itu efeknya terhadap uterus yaitu

bahwa simpatik menjaga tonus uterus, sedangkan saraf parasimpatik mencegah kontraksi uterus, jadi menghambat tonus uterus. Pengaruh dari kedua jenis persarafan ini menyebabkan terjadinya kontraksi uterus yang intermiten. Rangkaian susunan saraf simpatik daerah pelvik terdiri dari tiga rangkaian, yaitu rantai sakralis, plexus haemorrhoidalis superior, dan plexus hipogastrika superior.

3. Fisiologis Nyeri Persalinan

Fisiologis nyeri persalinan terbagi sesuai tahap persalinan, yaitu:

a. Persalinan Kala I

Nyeri pada kala I ditimbulkan oleh stimulus yang dihantarkan melalui saraf pada leher rahim (serviks) dan rahim/uterus bagian bawah. Nyeri ini timbul dari uterus dan adnexa saat berkontraksi, hal ini adakah nyeri visceral yang dialami. Intensitas nyeri berhubungan dengan kekuatan kontraksi dan tekanan yang ditimbulkan. Nyeri akan bertambah dengan adanya kontraksi isometrik pada uterus yang melawan hambatan oleh leher rahim/uterus dan perineum. Selama persalinan bilamana serviks uteri/leher rahim dilatasi sangat lambat atau bilamana posisi fetus (janin) abnormal menimbulkan distorsi mekanik, kontraksi kuat disertai nyeri hebat. Hal ini karena uterus berkontraksi isometrik melawan obstruksi. Kontraksi uterus yang kuat merupakan sumber nyeri yang kuat.

b. Persalinan Kala II

Selama persalinan kala II, pada saat serviks uteri/leher rahim dilatasi penuh, stimulasi nyeri berlangsung terus dari kontraksi badan rahim (corpus uteri) dan distensi segmen bawah rahim. Terjadi peningkatan secara progresif tekanan oleh fetus terhadap struktur di pelvis, dan menimbulkan peningkatan nyeri somatic, dengan regangan dan robekan fascia (jaringan pembungkus otot) dan jaringan subkutan jalan lahir bagian bawah, distensi perineum, dan tekanan pada otot lurik perineum.

Impuls rasa nyeri pada tahap pertama (Kala I) persalinan ditransmisikan melalui segmen saraf spinalis T11-12 dan saraf-saraf asesori torakal bawah serta saraf simpatik lumbar atas. Saraf-saraf ini berasal dari korpus uterus dan serviks. Rasa tidak nyaman akibat perubahan serviks dan iskemia rahim disebut nyeri visceral. Nyeri ini berasal dari bagian bawah abdomen dan menyebar ke daerah lumbar punggung dan menurun ke femur. Impuls nyeri yang berasal dari serviks dan korpus uteri ditransmisikan oleh serabut saraf aferen melalui plexus uterus, plexus pelviks, plexus hipogastrik inferior, middle, posterior dan masuk ke lumbar yang kemudian masuk ke spinal melalui L1, T12, T11 dan

T10. Biasanya ibu mengalami rasa nyeri ini hanya selama kontraksi dan bebas dari rasa nyeri pada interval antar kontraksi.

Tahap kedua persalinan (Kala II) yakni tahap pengeluaran bayi, ibu mengalami nyeri somatik atau nyeri pada perineum. Rasa tidak nyaman pada perineum ini timbul akibat peregangan jaringan perineum akibat tekanan bagian terendah janin, kandung kemih, usus atau struktur sensitif panggul yang lain. Impuls nyeri pada tahap kedua persalinan (kala II) dihantar melalui saraf pudendal menuju S1-4 dan sistem parasimpatis jaringan perineum. Nyeri yang dirasakan terutama pada daerah vulva dan sekitarnya serta pinggang. Nyeri tahap ketiga (kala III) adalah nyeri lokal yang disertai kram dan sensasi robekan akibat distensi dan laserasi serviks, vagina atau jaringan perineum. (Rachmawati & Nurliyani, 2024)

Pada dasarnya Rasa nyeri pada proses persalinan berbeda dengan rasa nyeri yang dialami individu pada umumnya. Perbedaan tersebut terletak pada:

- a. Proses fisiologis: Nyeri persalinan adalah proses fisiologis, dimana ini terjadi karena adanya kontraksi akibat proses hormonal dalam persalinan seperti naiknya kadar oksitoksin, naiknya kadar prostaglandin dan turunnya kadar progesteron.
- b. Perempuan dapat mengetahui bahwa ia akan mengalami nyeri saat bersalin apalagi bila seseorang telah mengalami atau berpengalaman sebelumnya, sehingga hal tersebut dapat diantisipasi,
- c. Pengetahuan yang cukup tentang proses persalinan akan membantu perempuan untuk mengatasi nyeri persalinan yang bersifat intermiten (sementara), Konsentrasi perempuan pada bayi yang akan dilahirkan akan membuat lebih toleran terhadap nyeri yang dirasakan saat persalinan, karena ia lebih berfokus pada harapan kelahiran bayinya.

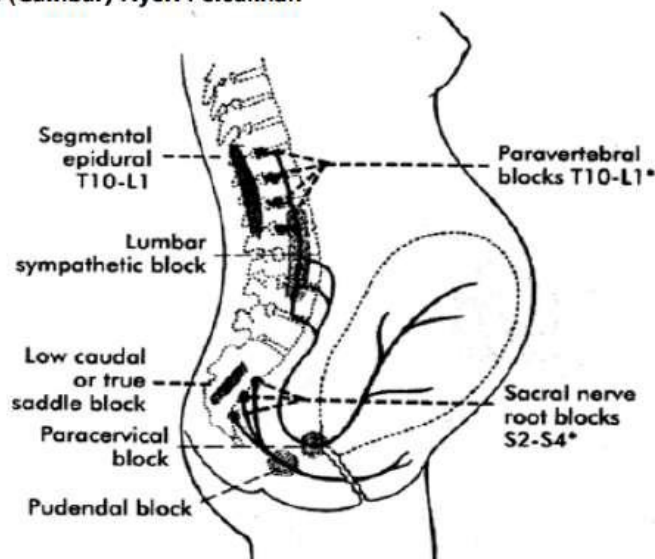
Nyeri yang dialami oleh perempuan dalam persalinan diakibatkan oleh kontraksi uterus, dilatasi serviks; dan pada akhir kala I dan pada kala II oleh peregangan vagina dan dasar pelvis untuk menampung bagian presentasi. Rasa tidak nyaman (nyeri) selama persalinan kala I disebabkan oleh dilatasi dan penipisan serviks serta iskemia uterus hal ini dikarenakan penurunan aliran darah sehingga oksigen lokal mengalami defisit akibat kontraksi arteri miometrium, nyeri ini disebut nyeri viseral. Sedangkan pada akhir kala I dan kala II, nyeri yang dirasakan pada daerah perineum yang terjadi akibat peregangan perineum, tarikan peritonium dan daerah uteroservikal saat kontraksi, penekanan vesika urinaria, usus dan struktur sensitif panggul oleh bagian terendah janin, nyeri ini disebut nyeri somatic. (Sri, 2020)

C. Teori Nyeri Persalinan

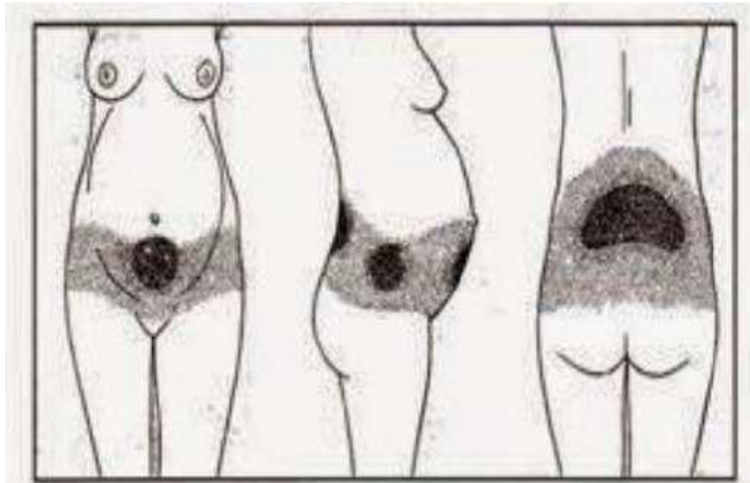
Dengan banyaknya teori yang muncul terkait nyeri maka pengalaman nyeri manusia secara universal, bahwa teori hanyalah teori. Peran teori yaitu memfasilitasi suatu pemahaman yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih, teori yang ada tidak bersifat kekal atau menetap, maka pemahaman kita tentang nyeri haruslah bersifat dinamis karena setiap saat bisa saja muncul teori-teori yang baru yang dikemukakan oleh para ilmuwan atau peneliti. Saat ini teori yang paling banyak diterima oleh masyarakat adalah teori Melzack dan Wall yang telah dikenal baik yaitu rangsangan halus yang menghambat sensasi nyeri.

Teori menurut Endorfin, Pada tahun 1975 telah ditemukan substansi seperti opiate yang terbentuk secara alami di dalam tubuh. Substansi tersebut disebut endorfin. Peran endorfin dalam menyebabkan dan meredakan nyeri belum dapat diklarifikasi. Endorfin mempengaruhi transmisi impuls yang diinterpretasikan sebagai rasa nyeri. Endorfin berupa neurotransmiter yang menghambat transmisi atau pengiriman pesan nyeri seperti morfin. Morfin bekerja dalam cara yang sama seperti endorfin dengan menghambat transmisi pada pesan nyeri dan menempel pada bagian saraf otak serta sumsum tulang belakang.

Lokasi (Gambar) Nyeri Persalinan



Gambar 1.1 Jalur visceral dan somatic berhubungan dengan kelahiran dan blok saraf yang menghentikan transmisi impuls nyeri



Gambar 5.2 Distribusi nyeri persalinan selama kala I

D. Manajemen Nyeri Selama Persalinan

1. Pendekatan Holistik dalam Manajemen Nyeri Persalinan

Manajemen nyeri persalinan merupakan komponen penting dalam pelayanan kebidanan, dengan pendekatan holistik sebagai metode yang semakin banyak dianjurkan dalam praktik klinik. Pendekatan holistik memandang nyeri persalinan bukan hanya sebagai fenomena fisik semata, tetapi juga melibatkan aspek emosional, psikologis, spiritual, dan sosial dari ibu yang bersalin. Pendekatan ini dapat meningkatkan rasa nyaman, mengurangi kecemasan, dan menciptakan pengalaman persalinan yang lebih positif bagi ibu. (Yulianti & Devitasari, dkk, 2025).

Pendekatan holistik mencakup berbagai teknik seperti dukungan emosional kontinu, edukasi prenatal yang menyeluruh, intervensi Non-Farmakologis seperti pijat, aromaterapi, teknik pernapasan, meditasi mindfulness, hingga teknik-teknik spiritual sesuai budaya lokal. Kelebihan utama pendekatan ini adalah membantu ibu bersalin merasa lebih mampu mengendalikan persalinannya, sehingga persepsi nyeri menjadi lebih terkelola dan dampak negatif nyeri terhadap kondisi psikologis ibu berkurang secara signifikan.

2. Kombinasi Teknik Farmakologis dan Non-Farmakologis yang dapat dilakukan oleh bidan

Dalam Praktik Kebidanan, Kombinasi antara teknik farmakologis dan Non-Farmakologis dianggap sebagai strategi optimal dalam manajemen nyeri persalinan. Teknik farmakologis seperti analgesia inhalasi, penggunaan analgesik opioid ringan, atau analgesia regional seperti blok pudendal seringkali dapat dikombinasikan secara efektif dengan teknik Non-Farmakologis

seperti Hidroterapi, perubahan posisi, mobilisasi, dan penggunaan bola persalinan (Birthing Ball).

3. Strategi Edukasi Bidan untuk Menyiapkan Mental Ibu dalam Menghadapi persalinan

Edukasi prenatal yang komprehensif merupakan bagian integral dari manajemen nyeri selama persalinan, dengan tujuan utama membantu ibu secara mental siap menghadapi proses persalinan yang akan dialami. Ibu yang mendapatkan edukasi prenatal yang tepat cenderung memiliki tingkat ketakutan dan kecemasan yang lebih rendah serta mampu menghadapi nyeri persalinan secara lebih baik.

Strategi edukasi bidan mencakup beberapa elemen penting, antara lain pemberian informasi realistis mengenai proses fisiologis persalinan, diskusi terbuka tentang opsi manajemen nyeri yang tersedia, latihan teknik relaksasi dan pernapasan, serta pemberian dukungan emosional melalui konseling yang berkelanjutan. Selain itu, bidan juga berperan penting dalam membantu ibu mengembangkan mindset positif terhadap proses persalinan, meningkatkan rasa percaya diri ibu terhadap kemampuan tubuhnya sendiri, serta membangun ekspektasi realistis mengenai nyeri dan mekanisme adaptasi terhadap nyeri persalinan tersebut.

Implementasi edukasi prenatal yang baik oleh bidan akan membantu ibu memiliki keterampilan coping yang efektif, yang pada akhirnya mampu meningkatkan pengalaman persalinan, mengurangi stres, serta meminimalisir kebutuhan intervensi medis yang tidak diperlukan.

E. Manajemen Nyeri Non-Farmakologis pada persalinan

Nyeri persalinan merupakan suatu perasaan tidak nyaman yang berkaitan dengan adanya kontraksi uterus, dilatasi dan effacement serviks, peregangan vagina dan perineum yang berakhir di kala 4 persalinan. Nyeri persalinan mulai timbul pada fase laten dan fase aktif. Pada fase laten terjadi pembukaan serviks sampai 3 cm selama 8 jam. Manajemen nyeri non farmakologis terbukti efektif memberikan pengurangan rasa nyeri persalinan dan sangat dianjurkan untuk tenaga kesehatan atau bidan sebagai penolong persalinan dapat memberikan deep back massage pada ibu bersalin. Teknik massage efektif mengurangi rasa nyeri dari hasil ditemukan rerata skala nyeri persalinan sebelum diberikan massage 8,4 dan menurun setelah diberikan massage menjadi 2,8. Tindakan massage pada ibu bersalin efektif menurunkan nyeri persalinan (Prawira & Ismuntania, dkk, 2025)

Manajemen nyeri nonfarmakologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi persepsi nyeri tanpa menggunakan obat-obatan. Pendekatan ini menitikberatkan pada peningkatan kenyamanan, relaksasi, dan rasa percaya diri ibu dalam menghadapi persalinan.

Prinsip utama manajemen nyeri nonfarmakologis meliputi:

1. Pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, emosional, dan psikologis
2. Pemberdayaan ibu agar berperan aktif dalam proses persalinan
3. Penciptaan lingkungan persalinan yang aman dan nyaman
4. Individualisasi asuhan sesuai kebutuhan dan preferensi ibu

Dalam manajemen nyeri Non-Farmakologis terdapat keuntungan dan keterbatasan dalam pengelolaan nyeri persalinan menggunakan cara non-farmakologis, berikut keuntungan dalam manajemen nyeri dalam persalinan yaitu

1. Proses tidak menghambat proses persalinan ibu
2. Tidak memiliki efek negatif terhadap kesehatan ibu maupun janin
3. Bersifat mudah dilakukan ibu.
4. Cara yang digunakan sangat mudah dan efektif.
5. Dinilai lebih kecil
6. Sebagai suatu cara alternatif dan menjadi suatu pelengkap pengelolaan nyeri persalinan dan dukungan terhadap obat-obatan.

Keterbatasan dalam pengelolaan nyeri persalinan dengan cara non-farmakologi ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

1. Dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada motivasi ibu.
2. Keberhasilan metode ini sangat berkaitan dengan kemampuan ibu, dukungan dari tenaga kesehatan maupun dukungan lingkungan sekitar (seperti dukungan suami, dukungan keluarga)
3. Tidak semua ibu bersalin yang melakukan beberapa teknik non-farmakologi ini memperoleh penurunan tingkat nyeri yang diinginkan.

F. Teknik Nonfarmakologis dalam Manajemen Nyeri Persalinan

Saat ini dikenal beberapa teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri persalinan yang dapat dilakukan oleh ibu bersalin, antara lain:

1. Teknik Pernafasan Dalam

Teknik pernapasan terkontrol merupakan salah satu metode nonfarmakologis yang paling sering digunakan. Pernapasan dalam dan ritmis membantu menurunkan ketegangan otot, meningkatkan oksigenasi, serta membantu ibu memusatkan perhatian sehingga mengurangi fokus pada nyeri kontraksi (Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, K. R., 2020).

Penurunan nyeri oleh teknik relaksasi nafas dalam disebabkan ketika seseorang melakukan relaksasi nafas dalam untuk mengendalikan nyeri yang dirasakan, maka tubuh akan meningkatkan komponen saraf parasimpatik secara stimulan, maka ini menyebabkan terjadinya penurunan kadar hormon kortisol dan adrenalin dalam tubuh yang mempengaruhi tingkat stress seseorang sehingga dapat meningkatkan konsentrasi dan membuat klien merasa tenang untuk mengatur ritme pernafasan menjadi teratur.



Gambar 5.3 Teknik Pernafasan Dalam

2. Teknik Relaksasi

Relaksasi progresif dilakukan dengan cara mengencangkan dan melepaskan otot secara bertahap. Teknik ini membantu ibu mengenali area tubuh yang tegang dan secara sadar melepaskannya, sehingga mengurangi sensasi nyeri selama persalinan (Simkin, P., & Bolding, A., 2018).

Relaksasi merupakan suatu proses mengistirahatkan tubuh, pikiran dari semua beban baik fisik maupun kejiwaan sehingga membuat ibu lebih tenang dalam menghadapi proses persalinan. Dengan cara seperti ini, seluruh sistem syaraf, organ pada tubuh serta pancaindra ibu beristirahat dan ibu mampu melepaskan segala ketegangan dalam keadaan ibu tetap sadar. Teknik relaksasi ini mengajarkan pada ibu untuk meminimalkan aktivitas saraf simpatis dan system saraf otonom sehingga ibu lebih merasa rileks saat terjadinya kontraksi. (Dian Pratiwi, Selasih putri, dkk, 2021).

Teknik relaksasi ini teruji dapat menurunkan nyeri selama proses persalinan dengan merileksasikan ketegangan otot penyebab nyeri. Periode relaksasi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mengalami nyeri kronis. Teknik ini sangat membantu melawan rasa lelah dan mengurangi ketegangan otot yang terjadi. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh wirya dan duma menyebutkan bahwa teknik relaksasi nafas dalam sangat signifikan dalam menurunkan rasa nyeri pada pasien post Appendiktomi. Hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh sunarsih dan ernawati yang menyebutkan terapi relaksasi dalam dapat mengurangi nyeri persalinan.

Teknik ini dapat dilakukan saat kontraksi persalinan sedang berlangsung, dengan cara menghirup udara secara maksimal, dengan begitu mengakibatkan suplai oksigen yang ada di uterus tercukupi dan akhirnya mengurangi ketegangan otot yang dapat menyebabkan nyeri ibu timbul saat persalinan.

Adapun beberapa langkah dalam pelaksanaan relaksasi yaitu:

- a. Ibu dapat memilih tempat persalinan yang nyaman dan tenang sehingga dapat menumbuhkan rasa rileks
- b. Selama proses persalinan, ibu biasanya mengalami ketegangan yang dapat menimbulkan stress, maka dari itu perlu diajarkan untuk tarik nafas dalam, saat menghembuskan nafas diminta untuk melemaskan otot sehingga menjadi kendur, lunak dan kaku
- c. Komunikasi yang jelas. Menjelang proses persalinan, biasanya ibu mengalami kecemasan yang tinggi maka tugas penolong persalinan yaitu dapat melakukan komunikasi yang baik dan jelas kepada ibu untuk mengarahkan melakukan teknik relaksasi. Dengan begitu ibu akan merasa nyaman, tenang sehingga rasa cemas akan pelan-pelan berkurang.

3. Terapi Bola-Bola Persalinan Atau Bhirthing Ball

Saat ini dikenal terapi menggunakan bola persalinan atau Bhirthing ball yakni teknik mengurangi rasa nyeri menggunakan sebuah bola fisioterapi sebagai media dan mengharuskan postur tubuh yang bagus untuk mempertahankan keseimbangan di atas bola.

Hal ini memungkinkan seorang ibu untuk mengambil posisi tegak kemudian memutar panggulnya dalam pola lingkaran atau pola angka delapan. Kedua pola ini sangat membantu untuk mengurangi nyeri punggung yang terjadi selama proses persalinan serta membantu mendorong penurunan janin. Dan posisi ini juga dapat membantu meluruskan sumbu panjang uterus dan janin dengan panggul ibu dan memfasilitasi posisi ini juga dapat membantu meluruskan sumbu panjang uterus dan janin dengan panggul ibu dan memfasilitasi posisi ubun-ubun kecil depan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh kurniawati, dasuki dan kartini tahun 2016 yang menyebutkan hasilnya tingkat nyeri kala I fase aktif ibu bersalin yang mendapat latihan dengan birthball lebih rendah dibandingkan tingkat nyeri ibu bersalin yang tidak mendapatkan latihan birthball (Sri Astuti dkk, 2022).



Gambar 5.4 Teknik Bhirthing Ball

4. Teknik Kompres Hangat

Kompres hangat bekerja dengan meningkatkan aliran darah dan mengurangi ketegangan otot, sedangkan kompres dingin membantu menurunkan impuls nyeri dan inflamasi. Penggunaan kompres pada punggung bawah atau perut bawah terbukti dapat meningkatkan kenyamanan ibu selama persalinan (Nur Hidayah, S., & Prasodjo, I., 2024).

Teknik Kompres hangat adalah salah satu teknik yang sering dijumpai di masyarakat untuk mengurangi rasa nyeri. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penurunan nyeri yang signifikan pada ibu yang sedang mengalami proses persalinan.

Teknik kompres hangat ini efektif dalam menurunkan intensitas nyeri persalinan karena terkait dengan mekanisme panas yang diberikan dapat merangsang lepasnya hormone endorphin ibu, sehingga hal ini dapat membuat ibu merasa lebih nyaman dan dapat mengurangi rasa nyeri selama proses persalinan ini. Selain itu, kompres hangat ini dapat memvasodilatasi pembuluh darah serta mampu meningkatkan aliran darah pada tubuh, hal inilah yang membuat sirkulasi oksigenasi ini menjadi lebih lancar yang dapat mencegah terjadinya kaku otot/spasme otot, otot menjadi lebih rileks dan dampaknya dapat menurunkan rasa nyeri. Efek dari rasa hangat yang diberikan juga dapat merangsang serat saraf menutup sehingga impuls nyeri yang menjalar ke medulla spinalis dan otak menjadi terhambat.

Kompres hangat yang diberikan pada ibu bersalin ini dapat mempertahankan komponen pembuluh darah dalam kondisi vasodilatasi yang membuat sirkulasi darah ke otot panggul ini menjadi homeostatis sehingga terjadi penurunan rasa nyeri pada ibu.

Dalam teori lain menyebutkan bahwa warm shower hydrotheraoy yang diberikan pada ibu bersalin dapat menurunkan intensitas nyeri yang sifatnya

panas sehingga hal ini dapat melebarkan pembuluh darah terutama ke area nyeri. Selain itu, efek lainnya yakni dapat meredakan iskemik dengan cara menurunkan kontraksi uterus yang terjadi pada ibu bersalin serta dapat membantu melancarkan pembuluh darah, sehingga dapat menimbulkan rasa rileks sekaligus dapat meredakan vasokongestipelvis.



Gambar 5.5 Teknik Kompres Hangat

5. Terapi Massage

Terapi massage / Pijat adalah terapi yang sering kali dilakukan dimasyarakat. Terapi massage bisa dilakukan oleh pendamping persalinan dengan memberikan sentuhan fisik secara lembut di bagian punggung ibu. Pijat yang dilakukan akan memberikan rangsangan tubuh ibu untuk melepaskan endorphen, yang merupakan bahan penghilang rasa sakit alami dan merangsang produksi adanya hormon oksitosin, menurunkan hormon stress, dan rangsangan neurologis.

Terapi pijat akan mempengaruhi permukaan kulit, jaringan lunak, otot, tendon, ligamen, dan fascia secara manual. Pelepasan endorphen akan mengendalikan nerve gate dan menstimulasi saraf simpatis, sehingga dapat menimbulkan perasaan tenang pada ibu, dapat memberikan efek mengenai pengurangan intensitas nyeri, dan membuat relaksasi otot.

6. Akupresur

Akupresur merupakan teknik terapi komplementer yang dilakukan dengan memberikan tekanan pada titik-titik tertentu di tubuh. Stimulasi ini dipercaya dapat memengaruhi sistem saraf dan meningkatkan aliran energi, sehingga menurunkan persepsi nyeri (Dian Pratiwi, Selasih putri, dkk, 2021). Akupresur relatif aman dan dapat digunakan sebagai pendamping teknik nonfarmakologis lainnya selama persalinan. (Siti Nurkhasanah, SST., M.Keb, CH, 2023)

a. Prinsip Dasar Akupresur adalah:

- 1) Tekanan dilakukan menggunakan ibu jari atau telunjuk
- 2) Tekanan kuat namun nyaman, tidak sampai menimbulkan nyeri berlebihan.
- 3) Dilakukan saat kontraksi mulai terasa.
- 4) Ibu dianjurkan mengatur napas selama penekanan.
- 5) Bisa dilakukan oleh pendamping (suami/bidan).
- 6) Selalu komunikasi dengan ibu dan perhatian respon tubuh.

b. Waktu Pelaksanaan Akupresur adalah:

- 1) Kala I fase Aktif
- 2) Saat kontraksi terasa kuat
- 3) Dapat diulang setiap kontraksi sesuai dengan kenyamanan ibu bersalin

Terapi non-farmakologi dinilai lebih aman dan praktis digunakan oleh masyarakat untuk mengurangi rasa nyeri. Cara untuk mengurangi nyeri secara non-farmakologi yakni dengan Teknik Relaksasi, Teknik Nafas Dalam, Terapi Bola-Bola Persalinan atau Bhirthing Ball, Teknik Kompres Hangat dan Terapi Massase. (Dian Pratiwi, Selasih putri, dkk, 2021)

G. Simpulan

Nyeri persalinan adalah pengalaman sensorik–emosional yang kompleks dan sangat subjektif, dipengaruhi oleh faktor fisiologis (kontraksi uterus, dilatasi serviks, peregangan jaringan), psikologis (cemas, takut), sosial–budaya, serta dukungan yang diterima ibu. Nyeri yang tidak tertangani dapat memicu ketegangan dan respons stres yang berpotensi mengganggu kenyamanan ibu serta proses persalinan.

Manajemen nyeri persalinan menjadi bagian penting dari asuhan kebidanan modern karena berkontribusi pada keselamatan, kenyamanan, dan pengalaman persalinan yang positif. Pendekatan holistik dan woman-centered care menekankan pemberdayaan ibu sebagai subjek aktif, melalui lingkungan yang aman–nyaman, dukungan emosional, komunikasi, serta edukasi prenatal untuk membangun kesiapan mental dan strategi coping.

Teknik nonfarmakologis semakin direkomendasikan karena aman, minim efek samping, mudah diterapkan, dan dapat menjadi pelengkap tindakan farmakologis. Secara teori, efektivitasnya didukung oleh konsep gate control dan peran endorfin yang dapat menurunkan persepsi nyeri melalui stimulasi non-nyeri dan relaksasi. Berbagai teknik seperti pernapasan dalam, relaksasi, birthing ball, kompres hangat, pijat, serta akupresur dapat membantu menurunkan ketegangan otot, mengurangi kecemasan, memperbaiki oksigenasi, dan meningkatkan rasa kontrol ibu terhadap proses persalinan. Bukti penelitian juga menunjukkan intervensi tertentu efektif

pada fase berbeda, misalnya akupresur lebih optimal pada pembukaan 4 cm dan TENS lebih optimal pada pembukaan 8 cm.

Namun, keberhasilan metode nonfarmakologis sangat dipengaruhi motivasi ibu, keterampilan pelaksana, serta dukungan tenaga kesehatan dan keluarga. Karena itu, bidan berperan krusial dalam mengkaji kebutuhan individu, memberikan edukasi, memilih teknik yang sesuai tahap persalinan, serta mengombinasikan strategi farmakologis–nonfarmakologis secara tepat agar asuhan persalinan tetap aman, nyaman, dan bermakna bagi ibu.

H. Referensi

- Dian Pratiwi, Selasih putri, dkk. (2021). *Asuhan Kebidanan Komplementer dalam mengatasi nyeri persalinan*. Pustaka Aksara: Surabaya.
- Karlina, N. E. (2016). *Asuhan Kebidanan. Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal*. Bogor: IN MEDIA.
- Kusfaningrum, A., Rejeki, S., & Astuti, R. (2024). Systematic review: The Effect of Non-pharmacological Interventions on Reducing Pain During the First Stage of Labor. *Indonesian Journal of Global Health Research*, 7(5), 455–466. <https://doi.org/10.37287/ijghr.v6i4.6021>
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, K. R. (2020). *Maternity and women's health care* (12th ed). Elsevier.
- Nur Hidayah, S., & Prasodjo, I. (2024). *Penatalaksanaan nyeri nonfarmakologis pada ibu bersalin*. Tahta Media.
- Prabandari, F., Sofiana, J., & Rosmawati. (2023). Non-pharmacological pain management during labor. *Indonesian Journal of Midwifery*, 6(2), 152–160. <https://doi.org/10.35473/ijm.v6i2.2703>
- Prawira, R., & Ismuntania, dkk, Dr. I. (2025). *Dasar-dasar Keperawatan*. Yaysan Bina Lentera Insan.
- Rachmawati, F., & Nurliyani. (2024). *Manajemen Persalinan Non Farmakologi*. Tahta Media Group.
- Simkin, P., & Bolding, A. (2018). Nonpharmacologic approaches to relieve labor pain. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 63(2), 180–191. <https://doi.org/10.1016/j.jmwh.2004.07.007>

Siti Nurkhasanah, SST.,M.Keb, CH. (2023). *Terapi Komplementer dalam Praktik Kebidanan*. CV Budi Utama: Sleman.

Sri Astuti dkk. (2022). Effectiveness of Birth Ball and Counterpressure on Labor Pain in The Siti Juliaha Midwife Practice, Pekanbaru City. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 10(2). <https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/download/585/330/>

Sri, Dr. Ns. R. (2020). *Buku Ajar: Manajemen Nyeri Dalam Proses Persalinan (Non Farmaka)* (II). Unimus Press.

World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. *WHO Press*.

Yulianti, N. T., & Devitasari, dkk, I. (2025). *Buku Referensi Peran Bidan dalam Persalinan Normal yang Aman*. Optimal untuk negri.

I. Glosarium

Adneksa (Adnexa): Struktur pendukung rahim seperti tuba falopi dan ovarium yang dapat ikut terlibat dalam sumber nyeri saat kontraksi.

Akupresur: Teknik terapi komplementer dengan memberi tekanan pada titik-titik tertentu tubuh untuk membantu menurunkan persepsi nyeri dan meningkatkan relaksasi.

Birthing Ball (Bola persalinan): Bola fisioterapi yang digunakan untuk membantu posisi tegak, gerak panggul, relaksasi, dan mengurangi nyeri (terutama nyeri punggung).

Budaya: Nilai/kebiasaan masyarakat yang memengaruhi cara ibu memaknai, mengekspresikan, dan mengatasi nyeri persalinan.

Chi-square: Uji statistik untuk menilai hubungan/perbedaan proporsi antar kelompok dalam penelitian.

Distorsi mekanik: Gangguan/ketidaksesuaian mekanik (misalnya posisi janin abnormal) yang dapat meningkatkan nyeri dan menghambat kemajuan persalinan.

Edukasi prenatal: Pendidikan/konseling sebelum persalinan untuk menyiapkan ibu memahami proses persalinan, pilihan manajemen nyeri, serta latihan relaksasi.

CHAPTER 6

ASUHAN IBU NIFAS: PERAWATAN LUKA, LAKTASI, DAN EDUKASI KELUARGA

Heni Elmiani Sari, S.ST., M.PH.

A. Pendahuluan/Prolog

Masa nifas berlangsung sejak satu jam pertama setelah persalinan hingga sekitar 6-8 minggu, saat organ reproduksi dan system hormonal ibu kembali seperti sebelum hamil. Periode ini merupakan fase kritis karena sekitar 60% kematian ibu terjadi pada masa nifas dan hamper setengahnya dalam 24 jam pertama, sehingga kualitas asuhan kebidanan menjadi sangat menentukan keselamatan ibu dan bayi (Rismawati & Nurvita, 2023). Infeksi, perdarahan, gangguan involusi uteri, dan masalah menyusui merupakan komplikasi yang sering muncul bila perawatan masa nifas tidak dilakukan dengan benar (Bukhari et al., 2021).

Perawatan luka, khususnya luka jahitan perineum, menjadi salah satu fokus utama asuhan karena daerah genital yang lembap, terpapar lokia dan tidak melakukan vulva hygiene yang benar sangat mendukung pertumbuhan bakteri dan menunda penyembuhan luka (Hidayat, 2024) (Amalia et al., 2023) (Yusrotul et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa perawatan luka perineum dengan menjaga kebersihan genetalia (mencuci dengan sabun dan air mengalir dari depan ke belakang, mengeringkan, dan menggunakan antiseptic bila diindikasikan) efektif mempercepat penyembuhan dan mencegah infeksi, sekaligus meningkatkan kenyamanan ibu nifas (Hidayat, 2024). Pengetahuan ibu tentang perawatan luka perineum berhubungan signifikan dengan cepat atau lambatnya penyembuhan luka, sehingga edukasi menjadi komponen esensial dalam asuhan nifas (Amalia et al., 2023).

Di sisi lain, manajemen laktasi memegang peranan sentral bagi pemenuhan nutrisi bayi dan pemulihan kesehatan ibu. ASI merupakan makanan paling sempurna bagi bayi 0-6 bulan, mengandung zat gizi ideal dan kolostrum yang berfungsi meningkatkan antibody serta menurunkan morbiditas dan mortalitas infeksi (Sachan et al., 2019). WHO dan UNICEF (2021) merekomendasikan pemberian ASI Eksklusif sejak 30 menit-1 jam pertama setelah lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain. Namun, cakupan ASI eksklusif di berbagai daerah Indonesia masih belum optimal karena rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga, kurangnya konseling laktasi, factor social budaya, dan kuatnya promosi susu formula

(Ulfah et al., 2025). Berbagai program Pendidikan kesehatan terbukti mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik ibu terkait manajemen laktasi, Teknik menyusui, perawatan payudara dan putting, serta cara memerah dan menyimpan ASI (Naim & Mutmaina, 2024).

Keterlibatan keluarga merupakan pilar penting keberhasilan asuhan nifas. Dukungan keluarga, baik emosional, praktis maupun informasional, telah terbukti mendorong ibu untuk menyusui segera setelah persalinan, mempertahankan ASI Eksklusif, membantu ibu mengurangi kelelahan, serta mencegah pemberian makanan atau minuman lain sebelum usia 6 bulan (Sianturi & Siregar, 2025). Edukasi yang ditujukan bukan hanya kepada ibu tetapi juga kepada suami dan anggota keluarga lain meningkatkan pemahaman tentang manfaat ASI, pentingnya nutrisi adekuat bagi penyembuhan luka perineum, dan bahaya praktik pantang makan yang dapat memperlambat pemulihan dan mengurangi produksi ASI.

Dengan demikian, asuhan ibu nifas yang komprehensif harus mengintegrasikan tiga komponen utama: perawatan luka (terutama perineum) yang tepat dan higienis, manajemen laktasi dan menyusui berbasis evidence, serta edukasi keluarga yang berkelanjutan. Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu menurunkan risiko infeksi dan perdarahan, meningkatkan keberhasilan ASI Eksklusif dan mendukung adaptasi peran ibu secara fisik maupun psikologis pada masa nifas (Rismawati & Nurvita, 2023) (Amalia et al., 2023).

B. Perawatan Luka

1. Konsep Dasar Perawatan Luka pada Ibu Nifas

Masa Nifas (0-42 Hari) sangat rentan infeksi, terutama pada luka perineum/episiotomi bila kebersihan buruk dan perawatan tidak tepat, Luka perineum umumnya sembuh dalam 7-10 hari bila dirawat baik (Hidayat, 2024), (Amalia et al., 2023).

2. Tujuan Perawatan Luka

- a. Mencegah infeksi dan bau tidak sedap
- b. Mempercepat penyembuhan luka dan mengurangi nyeri
- c. Menjaga kenyamanan dan memudahkan aktivitas serta menyusui

3. Pengertian Perineum dan Luka Perineum

- a. Perineum adalah daerah otot, kulit, dan jaringan ikat antara introitus vagina dan anus, termasuk diafragma urogenital dan otot levator ani (Girsang & Elfira, 2023)
- b. Luka/ Trauma Perineum adalah setiap kerusakan jaringan perineum akibat persalinan pervaginam, baik berupa robekan spontan maupun luka sayatan episiotomy (Glo, 2025), (Schmidt & Fenner, 2024)

- c. Luka perineum dapat menjadi media tumbuh kuman karena lokasinya lembap dan dekat anus serta uretra, sehingga berisiko menyebabkan infeksi nifas (Saad & Painter, 2023), (Girsang & Elfira, 2023)

4. Etiologi dan Mekanisme Terjadinya Luka

- a. Robekan Spontan (Ruptur)

Terjadi ketika perineum tidak kuat menahan regangan kepala/bahu bayi, misalnya karena perineum kaku, mengejan tidak terkontrol, atau kala II terlalu cepat.

- b. Episiotomi

Tindakan membuat sayatan terkontrol pada perineum untuk memperlebar jalan lahir. Saat ini dianjurkan tidak dilakukan secara rutin, hanya apabila ada indikasi (distress janin, bahu sulit lahir). Karena tidak terbukti memberi manfaat jangka Panjang dibanding robekan spontan dan dapat meningkatkan morbiditas fisik maupun psikologis (Glo, 2025) (Schmidt & Fenner, 2024).

5. Klasifikasi Derajat Robekan Perineum

Klasifikasi internasional membagi trauma perineum menjadi derajat I-IV (Schmidt & Fenner, 2024)

- a. Derajat I

Robekan hanya mengenai mukosa vagina dan/atau kulit perineum. Biasanya kecil, dapat sembuh sendiri dan perdarahan sangat minimal

- b. Derajat II

Robekan mengenai mukosa vagina, kulit perineum, dan otot perineum, tetapi tidak mengenai sfingter ani. Mayoritas robekan persalinan berada pada derajat II.

- c. Derajat III

Robekan meluas hingga sfingter ani eksternus dan kadang internus

- d. Derajat IB

Robekan total sampai mukosa rectum, memotong sfingter ani dan dinding anterior rectum

Derajat III-IV sering disebut ***Obstetric Anal Sphincter Injuries (OASIS)*** dan membutuhkan penanganan bedah khusus (Schmidt & Fenner, 2024)

6. Epidemiologi

- a. Trauma perineum terjadi pada 75-90% persalinan pervaginam, termasuk robekan derajat ringan maupun episiotomy (Glo, 2025)
- b. Sekitar 75-85% wanita mengalami robekan perineum pada persalinan spontan; 1-3% mengalami OASIS (Schmidt & Fenner, 2024)
- c. Studi di Badan Pusat Statistik Yogyakarta sekitar 75,3% persalinan pervaginam mengalami robekan perineum, 1,9% diantaranya derajat III (Pangastuti, 2016)

7. Faktor Risiko

- a. Maternal: pada ibu Primipara, Usia terlalu muda <20 tahun, dan terlalu tua >35 Tahun, perineum kaku (tidak dilakukan pijat perineum), IMT yang berlebih
- b. Janin: Berat Badan Bayi Besar >4000 gram, Posisi Oksiput Posterior, Distosia Bahu
- c. Persalinan: Kala II lama, ekspulsi kepala sangat cepat, penggunaan vakum/forsep, episiotomy mediolateral yang terlalu dalam/Panjang

8. Proses Penyembuhan Luka Perineum

Secara umum mengikuti fase penyembuhan luka (Redjeki & Bunda, 2023)

a. Fase Inflamasi

Terjadi 1-3 hari. Dimana luka mengalami Hemostasis, Vasodilatasi, Infiltrasi Leukosit, Tampak Kemerahan, bengkak, nyeri

b. Fase Proliferasi

Terjadi 3-7 hari. Pembentukan jaringan granulasi, angiogenesis, kontraksi luka

c. Fase Pematangan/ Remodeling

Terjadi pada minggu ke 3. Penguatan kolagen, penataan ulang jaringan, berlangsung berbulan-bulan.

Dalam kondisi normal, luka perineum derajat ringan, sedang akan kering dan menyatu dalam 6-7 hari, sedangkan berbagai faktor dapat membuat penyembuhan > 8 hari (Redjeki & Bunda, 2023).

Faktor yang mempengaruhi (Girsang & Elfira, 2023) (Redjeki & Bunda, 2023)

- 1) Perawatan perineum dan vulva hygiene
- 2) Nutrisi (terutama protein, zinc)
- 3) Teknik dan material jahitan
- 4) Derajat luka dan adanya infeksi
- 5) Mobilisasi, personal hygiene, budaya pantang, status gizi, komorbid

9. Dampak dan Komplikasi Luka Perineum

- a. Jangka pendek: terjadi nyeri hebat, gangguan mobilisasi, kesulitan BAK/BAB, gangguan menyusui, infeksi luka, dehisensi (jahitan lepas) (Girsang & Elfira, 2023) (Schmidt & Fenner, 2024)

- b. Jangka menengah-panjang:

- 1) Dispareunia (nyeri saat hubungan seksual)
- 2) Gangguan kontinensia urin/feses, terutama pada OASIS
- 3) Gangguan fungsi dasar panggul, prolapse, dan penurunan kualitas hidup serta masalah psikologis (cemas, depresi, citra tubuh negative)

Infeksi luka perineum dapat menyebar ke jalan lahir dan saluran kemih, memperlambat penyembuhan dan meningkatkan risiko morbiditas nifas (Girsang & Elfira, 2023) dan (Schmidt & Fenner, 2024).

10. Langkah Perawatan Luka Perineum

a. Kebersihan Daerah Genital

- 1) Cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh daerah luka
- 2) Bersihkan vulva dari arah depan ke belakang setiap habis BAK dan BAB dan minimal 2-3 kali sehari
- 3) Gunakan air bersih; di fasilitas kesehatan dapat menggunakan NaCL 0,9% karena isotonis, tidak iritan, menjaga kelembapan dan mempercepat proses penyembuhan.
- 4) Keringkan dengan tisu/ handuk bersih dengan cara ditepuk lembut, buka digosok
- 5) Ganti pembalut secara teratur; amati tanda infeksi (kemerahan meluas, bengkak, nyeri bertambah, discharge berbau, demam) (Man et al., 2026)

b. Evaluasi dan Tindak Lanjut

- 1) Kunjungan/pemeriksaan luka dianjurkan di minggu-minggu awal nifas untuk mendeteksi infeksi, *dehiscence* (terbuka) dan *Granulation tissue*
- 2) Bila ada komplikasi: tata laksana analgesia yang adekuat, antibiotic bila indikasi, dan rencana perbaikan sekunder bila perlu

C. Laktasi

Laktasi adalah proses fisiologis produksi dan pengeluaran ASI oleh kelenjar mammae yang menjadi bagian penting dari reproduksi dan kesehatan ibu dan bayi

1. Anatomi Payudara terkait Laktasi

- a. Payudara tersusun atas lobus lobulus yang berisi alveoli (unit penghasil susu) dan system ductus yang bermuara ke puting (Truchet & Honvo-houéto, 2017) (Sriraman, 2017)(Geddes et al., 2021) (L. Anderson et al., 2019) (S. M. Anderson et al., 2015)
- b. Alveoli dilapisi sel epitel skretorik (penghasil susu) dan dikelilingi sel mioepitel yang berkontraksi untuk mengeluarkan susu (milk ejection) (Jena MK et al., 2023)
- c. Ligament cooper, jaringan lemak dan vaskularisasi intensif mendukung suplai nutrient dan hormone ke jaringan laktasi (Geddes et al., 2021)

2. Tahap-tahap Laktasi

Istilah yang sering dipakai: mammogenesis, lactogenesis I-II, Galaktopoiesis, Galaktokinesis, Involusi (Truchet & Honvo-houéto, 2017), (Sadovnikova et al., 2020)

- a. Mammogenesis (Perkembangan Payudara)

Dimulai sejak janin perempuan, berlanjut di pubertas, dan mencapai diferensiasi penuh saat kehamilan melalui pengaruh estrogen, progesterone, prolactin, dan hormone plasenta (Neville et al., 2023)

b. Lactogenesis I (Kehamilan Akhir)

- 1) Diferensiasi sel epitel menjadi sel sekretorik aktif
- 2) Payudara mulai menghasilkan kolostrum, tetapi produksi besar susu terhambat oleh kadar progesterone tinggi (Sadovnikova et al., 2020)

c. Lactogenesis II (Sekresi Susu "datang")

- 1) Terjadi 30-72 jam pasca persalinan, dipicu turunnya progesterone setelah plasenta lahir, sementara prolactin dan kortisol tetap tinggi (S. M. Anderson et al., 2015)
- 2) Penundaan aktivitas sekretorik (delayed lactogenesis II) sering terkait dengan seksio sesarea, diabetes, obesitas, perdarahan post-partum, dan stress (Spatz et al., 2024)

d. Galaktopoiesis (Pemeliharaan Produksi)

Ditentukan oleh frekuensi dan efektivitas pengosongan payudara, semakin sering dan tuntas semakin tinggi produksi (autocrine control) (Geddes et al., 2021)

e. Galaktokinesis (Pengeluaran Susu)

Reflek let-down yang dikendalikan oleh oksitosin yang menyebabkan kontraksi sel mioepitel dan pendorongan ASI melalui ductus ke puting (Neville et al., 2023)

f. Involusi

Saat menyusui dihentikan, berkurangnya prolactin dan peningkatan sitokin local memicu apoptosis sel sekretorik dan kelenjar kembali mendekati keadaan pra kehamilan (Sadovnikova et al., 2020)

3. Regulasi Hormon Laktasi

a. Hormon Utama

1) Prolaktin (PRL)

- a) Disekresikan hipofisis anterior; kunci untuk semua fase laktasi (lactogenesis, galaktopoiesis)
- b) Diatur oleh sumbu hipotalamus dan hipofisis:
 - Dopamin yaitu untuk menghambat sekresi Prolaktin
 - Jalur oksitosinergik hipotalamus yaitu dapat menstimulasi Prolaktin
- c) Kadar Prolaktin naik tajam saat isapan bayi, dan kadar prolactin meningkat pada malam hari (Neville et al., 2023) (Truchet & Honvo-houéto, 2017)

2) Oksitosin

- a) Diproduksi di hipotalamus dan dilepas oleh hipofisis posterior saat puting distimulasi
- b) Menyebabkan kontraksi sel mioepitel yang merangsang reflex pengeluaran ASI, juga memodulasi ikatan ibu dan bayi dan system reward di otak (Neville et al., 2023)

3) Estrogen dan progesterone

- a) Estrogen mengatur perkembangan ductus dan proliferasi sel epitel; progesterone mendukung dalam pembentukan alveoli
- b) Kadar tinggi saat hamil menghambat sekresi susu penuh, penurunan progesterone pasca persalinan memicu lactogenesis II

4) Growth Hormone (GH) & Insulin Like Growth Factor 1 (IGF-1)

Mengatur metabolisme dan distribusi nutrisi menuju payudara; Growth Hormone merangsang produksi di hati yang berkaitan dengan reseptor di sel epitel mammae dan mendukung laktasi (Truchet & Honvo-houéto, 2017)

b. Hormon lainnya

- 1) Kortikosteroid/Glukokortikoid: bersamaan dengan Prolaktin dan Insulin diperlukan untuk sintesis laktosa dan protein susu
- 2) Parathyroid hormone-related peptide (PTHrP): Hormon ini disekresi payudara untuk memobilisasi kalsium maternal ke ASI (S. M. Anderson et al., 2015)

4. Mekanisme Seluler dan Molekuler Sekresi ASI

ASI diproduksi oleh sel epitel alveolus melalui beberapa jalur khusus (Geddes et al., 2021) (Jena et al., 2023):

- a. Ekositosis: merupakan pengeluaran protein susu (kasein, whey), laktosa dan ion divalent
- b. Sekresi lemak unik: droplet trigliserida dibungkus membran sel sehingga menghasilkan *milk fat globule*
- c. Transpor membran:
 - 1) Glukosa, Asam Amino, Ion $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{Cl}^-$ menggunakan transporter spesifik
 - 2) Transporter khusus untuk Zn dan Ca sudah cukup dipahami; sedangkan untuk glukosa, asam amino, Cu, dan Trace metal lainnya masih kurang diteliti.
- d. Transistosis merupakan Immunoglobulin (terutama IgA sekretorik), hormone, dan faktor bioaktif lain melewati sel epitel dari darah ke lumen alveolus
- e. *Tight junctions* merupakan sambungan rapat dipuncak sel epitel terbuka pada akhir kehamilan dan menutup ketat saat laktasi penuh, mencegah "bocornya" komponen plasma ke ASI

5. Komposisi dan Fungsi ASI

- a. ASI adalah Nutrisi fisiologis standar untuk bayi dengan Komposisi yang dinamis, berubah antara waktu, antara pemberian dan sepanjang laktasi (Sriraman, 2017)
- b. Komponen Utama ASI:
 - 1) Makronutrien yang terdiri dari laktosa, lemak kompleks, protein khusus (lactalbumin, lactoglobulin, kasein)
 - 2) Mikronutrien dan Mineral yang terdiri dari Kalsium, fosfor, Zinc, trace elements melalui transporter spesifik
 - 3) Faktor Imun yang terdiri dari IgA, Laktoferin, Lisozim, Sel Imun, Sitokin: membentuk imunitas pasif bagi bayi
 - 4) Hormone dan Faktor Bioaktif yang terdiri dari Leptin, adiponectin, insulin, PTHrP yang mempengaruhi pertumbuhan, metabolisme dan perkembangan bayi
- c. Manfaat pada bayi memberikan gizi optimal, perlindungan terhadap infeksi, *Sudden Infant Death Syndrome* (SIDS), dan penyakit metabolik di kemudian hari (Young et al., 2025) (Activity & Pregnancy, 2020)
- d. Manfaat pada Ibu dapat menurunkan risiko kanker payudara dan ovarium, diabetes tipe 2, hipertensi dan penyakit kardiovaskular (Young et al., 2025)

6. Faktor yang Mempengaruhi Laktasi

- a. Faktor Ibu
 - 1) Penyakit metabolik dan endokrin yaitu obesitas, diabetes gestasional/ diabetes tipe 2, gangguan prolaktin/reseptornya, serta paparan endocrine disrupting chemicals seperti PFAS dapat menyebabkan insufisiensi laktasi (Kachurenko et al., 2023).
 - 2) Kondisi obstetrik yaitu pre eklamsia, perdarahan post-partum, seksio sesarea, intervensi persalinan tertentu dapat menunda lactogenesis II dan mengganggu produksi ASI (Spatz et al., 2024)
 - 3) Anatomi Payudara dan riwayat operasi payudara juga dapat memengaruhi kapasitas produksi ASI (Kachurenko et al., 2023)
- b. Faktor Bayi

Prematuritas, bayi sakit/kecil, kesulitan melekat dan menghisap menyebabkan stimulasi dan pengosongan payudara yang kurang efektif (Spatz et al., 2024)
- c. Faktor Psikososial dan Lingkungan

Dukungan keluarga, budaya, kebijakan kerja, serta tekanan promosi susu formula mempengaruhi inisiasi dan durasi menyusui (Radoff, 2020)

7. Masalah Umum Laktasi dan Dampaknya

- a. Nyeri menyusui adalah masalah paling sering dilaporkan; masalah suplai ASI dan transfer ASI (milk intake) paling kuat terkait distress maternal dan persepsi keparahan
- b. Mastitis, engorgement, dan masalah pelekatan umum terjadi dan bisa megancam keberlanjutan menyusui jika tidak ditangani (Spatz et al., 2024).

8. Dukungan Klinik dan Profesional dalam Laktasi

- a. Peran Tenaga Kesehatan
 - 1) Kurikulum kedokteran, kebidanan dan keperawatan sering belum memenuhi standar kompetensi laktasi; perlu penambahan jam materi teori dan praktik
 - 2) Pelatihan blended learning (teori dan praktik) pada perawat meningkatkan secara bermakna pengetahuan, sikap dan keterampilan manajemen laktasi (posisi, pelekatan, penanganan masalah, payudara) dan bertahan hingga >3 bulan (Joshi et al., 2025)

D. Edukasi Keluarga

Selama masa nifas, penting bagi ibu untuk merawat dirinya sendiri dan mendapatkan dukungan yang cukup dari pasangan, keluarga, dan tim medis sebab jika tidak, ibu akan mengalami stress sehingga akan menimbulkan efek negatif, bukan hanya terhadap sang ibu, tetapi juga bagi anaknya. Kecemasan yang dialami oleh wanita yang akan melahirkan dapat diminimalkan melalui adanya dukungan keluarga (Sasanti et al., 2024). Ini adalah periode penting dalam perjalanan seorang wanita menuju pemulihan fisik dan emosional setelah melahirkan.

Salah satu faktor utama yang mengambil peran penting dalam pencegahan kasus post-partum adalah suami, keluarga, atau orang-orang terdekat sang ibu karena risiko akan semakin meningkat jika ibu tidak mendapat dukungan dari orang terdekatnya tersebut, beberapa fungsi keluarga adalah terkait dengan fungsi sosialisasi, yaitu proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu, yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosial. Keluarga adalah tempat individu untuk belajar bersosialisasi, Keberhasilan perkembangan individu dan keluarga dicapai melalui interaksi atau hubungan antar anggota keluarga yang diwujudkan dalam sosialisasi. Anggota keluarga belajar disiplin, belajar norma-norma budaya dan perilaku melalui hubungan dan interaksi keluarga. Selanjutnya adalah fungsi reproduksi, yaitu keluarga berfungsi untuk meneruskan keturunan dan menambah sumber daya manusia. Maka dengan ikatan suatu perkawinan yang sah, selain untuk memenuhi kebutuhan biologis pada pasangan tujuan untuk membentuk keluarga adalah untuk meneruskan keturunan.

Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga seperti memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Dan yang terakhir adalah keluarga sebagai perawatan kesehatan, keluarga berperan atau berfungsi untuk melaksanakan praktek asuhan kesehatan, yaitu untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan dan atau merawat anggota keluarga yang sakit, kemampuan keluarga dalam memberi asuhan kesehatan mempengaruhi status kesehatan keluarga. Kesanggupan keluarga melaksanakan pemeliharaan kesehatan dapat dilihat dari tugas kesehatan berarti sanggup menyelesaikan masalah kesehatan sehingga peran terakhir inilah yang menjadi salah satu alasan terkait dengan postpartum ibu, yaitu keluarga atau orang terdekat sangat berperan aktif dalam kesehatan ibu (Sasanti et al., 2024).

1. Kesenjangan Pengetahuan dan Kebutuhan Edukasi Ibu Nifas

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang tua, baik ibu maupun ayah, merasa tidak cukup dipersiapkan menghadapi perubahan dan tantangan pada 6 minggu pertama post-partum. Integrative review di Amerika Serikat yang menelaah 22 studi menemukan bahwa banyak orang tua, terlepas dari paritas, merasa tidak siap menghadapi depresi, kecemasan, pemulihan fisik (nyeri, perdarahan, gangguan tidur), menyusui, serta perawatan bayi. Ibu nifas juga kesulitan membedakan mana gejala yang masih tergolong normal dan mana yang merupakan tanda komplikasi serius. Edukasi saat pulang dari rumah sakit sering dinilai sekaligus terlalu banyak dan terlalu sedikit informasi yang diberikan dalam kondisi ibu Lelah, sehingga terasa terbebani namun tetap tidak menjawab kekhawatiran utama dan sulit diingat ketika di rumah (Runiari & Ruspawan, 2023)

Studi mixed methods di Indonesia menemukan enam kebutuhan edukasi utama menurut ibu nifas: (Runiari & Ruspawan, 2023)

- a. Edukasi tentang perawatan ibu
- b. Edukasi tentang perawatan bayi
- c. Waktu pemberian informasi
- d. Metode pemberian edukasi
- e. Media edukasi
- f. Sumber informasi

Secara spesifik, materi yang paling dibutuhkan oleh ibu terkait perawatan diri adalah:

- a. Menyusui
- b. Perawatan payudara
- c. Kesehatan mental

Pada perawatan pada bayi diantaranya:

- a. Imunisasi

- b. Tanda bahaya bayi baru lahir
- c. Perawatan tali pusat

Penelitian di Iran kebutuhan edukasi ibu nifas terbagi menjadi empat kategori yaitu: (Nazari et al., 2021)

- a. Mempertahankan dan memulihkan kesehatan fisik
- b. Kesehatan seksual
- c. Kesehatan mental
- d. Hambatan edukasi

Dalam aspek fisik ibu nifas, membutuhkan informasi tentang perdarahan normal dan abnormal, nyeri infeksi, nutrisi, aktivitas fisik, dan perawatan luka. Dalam aspek kesehatan mental, ibu nifas memerlukan pemahaman tentang baby blues, depresi, kecemasan, dan kapan serta bagaimana mencari bantuan. Hambatan edukasi yang muncul termasuk keterbatasan waktu tenaga kesehatan, informasi yang terputus-putus, serta rendahnya literasi kesehatan (Adams et al., 2023).

2. Peran keluarga dan pentingnya Pendekatan Family Centered

Dalam konteks post-partum, keluarga terutama suami, orang tua, dan mertua memegang peranan sentral baik sebagai sumber dukungan maupun sebagai pengambil keputusan kesehatan. Dibanyak budaya, keputusan tentang pola makan ibu, pola istirahat, perawatan luka, hingga pilihan memberikan kolostrum atau tidak, ditentukan oleh keluarga besar (Wahyuni, 2024) (Sharma et al., 2025) (Murthy et al., 2023). Jika keluarga memegang keyakinan bahwa ibu nifas adalah “orang sakit” yang harus banyak berbaring, dihindarkan dari berbagai makanan bergizi tertentu, dan dilarang menyusui diawal, maka praktik perawatan yang sehat menjadi sulit diterapkan (Wahyuni, 2024)

Pendekatan *Family Centred Maternity Care* (FCMC) hadir sebagai kerangka yang menempatkan ibu dan keluarga sebagai satu kesatuan system. Dalam pendekatan ini, keluarga bukan sekedar pendamping pasif yang ikut hadir saat kunjungan, tetapi menjadi mitra aktif dalam edukasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan perawatan ibu serta bayi (Wahyuni, 2024) (Indrayani et al., 2024). Edukasi yang diberikan bukan hanya kepada ibu, tetapi juga menjangkau suami dan anggota keluarga yang tinggal serumah, karena merekalah yang sehari-hari memberi nasihat, menyiapkan makanan, membantu perawatan bayi, dan menilai kapan perlu membawa ibu atau bayi ke fasilitas kesehatan (Sharma et al., 2025) (Murthy et al., 2023).

Implementasi FCMC dalam edukasi masa nifas telah menunjukkan dampak nyata. Program pendidikan kesehatan berbasis FCMC di Komunitas, yang memadukan ceramah, diskusi, dan demonstrasi menggunakan booklet nifas,

phantom bayi, serta media audiovisual, dan dilaksanakan melalui kunjungan rumah, berhasil membuat 90% ibu nifas mampu melakukan perawatan nifas dengan melibatkan keluarga (Wahyuni, 2024). Edukasi dilakukan langsung di rumah ibu sehingga pesan dapat disesuaikan dengan konteks budaya dan kondisi lingkungan tempat ibu tinggal. Monitoring dan evaluasi melalui home visit lanjutan menunjukkan adanya peningkatan perilaku perawatan nifas yang lebih mandiri dan partisipatif dari pihak keluarga (Sharma et al., 2025). Banyak ibu bergantung pada advice informal dari anggota keluarga, petugas kesehatan komunitas, dan dokter, yang tidak selalu selaras dengan praktik berbasis bukti. Program yang hanya menasara ibu tanpa menyentuh jaringan dukungan keluarga berisiko tidak efektif karena keputusan sehari-hari terkait perawatan makana, aktivitas, dan perawatan bayi sangat dipengaruhi oleh keluarga besar (Adams et al., 2023).

3. Keluarga sebagai Taret Edukasi

Edukasi keluarga pada ibu nifas menuntut pergeseran paradigma: dari *mother-only education* menjadi *family centered education*. Penelitian di India menunjukkan bahwa walaupun ibu menunjukkan bahwa walaupun ibu menerima cukup banyak dukungan social dan edukasi pada masa kehamilan, pengetahuan dan dukungan mengenai perawatan post-partum, terutama pasca operasi sesar sangat terbatas

Edukasi yang melibatkan suami dan anggota keluarga lainnya terbukti meningkatkan dukungan instrumental dan emosional yang diterima ibu. Ketika suami dan keluarga memahami bahwa ibu membutuhkan waktu istirahat, nutrisi seimbang, dukungan menyusui, serta perhatian terhadap gejala mental maupun fisik, mereka lebih mampu mengambil alih tugas, mengurangi tekanan pada ibu, dan mendorong pemanfaatan layanan kesehatan tepat waktu (Nazari et al., 2021) (Rn et al., 2023).

4. Model Edukasi Keluarga yang Komprehensif

Berdasarkan temuan-temuan penelitian, model edukasi keluarga pada ibu nifas yang komprehensif sebaiknya mencakup:

a. Persiapan sejak kehamilan

Materi tentang nifas perlu dimasukkan secara eksplisit dalam kelas ibu hamil dan program antenatal, tidak hanya membahas proses persalinan. Topik meliputi perubahan fisik dan emosional pascapersalinan, tanda bahaya, dasar menyusui dan perawatan bayi, serta peran keluarga dalam mendukung ibu. Kelas antenatal yang melibatkan pasangan dan keluarga terbukti meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan, mengurangi ketakutan persalinan, serta meningkatkan keberlanjutan menyusui (Nazari et al., 2021)

b. Eduksi terstruktur sebelum pulang dari rumah sakit

Sebelum ibu dan bayi dipulangkan, perlu ada sesi edukasi kelompok yang melibatkan kelaurga. Program seperti *Coaching for Every Partner* mengajarkan perilaku kunci melalui model ceramah singkat, demonstrasi, latihan dan materi cetak dan terbukti menurunkan angka kematian neonatal (Subramanian et al., 2020) (Murthy et al., 2023)

c. Kunjungan rumah dan dukungan komunitas

Home visit oleh bidan atau perawat komunitas memungkinkan penilaian langsung praktik keluarga, diskusi tentang kepercayaan budaya, dan penyesuaian pesan edukasi agar lebih diterima. Studi tentang FCMC melalui home care menunjukkan peningkatan signifikan pada perilaku perawatan nifas ibu dan keterlibatan keluarga (Sharma et al., 2025)

d. Keterlibatan aktif suami dan anggota keluarga

Model khusus bagi suami dan anggota keluarga lain perlu menekankan peran mereka dalam mendukung menyusui, mengurangi beban domestic ibu, memantau gejala bahaya, dan menyediakan dukungan emosional. Riset menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang berorientasi keluarga meningkatkan dukungan social, kepercayaan diri menyusui, kepuasan terhadap layanan, dan kemungkinan *breast-feeding* berkelanjutan (Nazari et al., 2021)

e. Penekanan pada kesehatan mental dan hubungan orang tua bayi

Edukasi harus memasukkan topik kesehatan mental, strategi koping, dan cara mencari bantuan. Program seperti *Circle of Security Parenting* yang diperkenalkan pada periode post-partum membantu orang merefleksikan pola asuh, meningkatkan kehadiran emosional terhadap bayi, dan memperkuat kerjasama orang tua (Rn et al., 2023)

E. Simpulan

masa nifas merupakan periode kritis yang sangat menentukan kesehatan dan keselamatan ibu serta bayi, sehingga membutuhkan asuhan kebidanan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berbasis bukti. Perawatan luka perineum yang tepat, higienis, dan disertai pemantauan rutin terbukti berperan penting dalam mencegah infeksi, mempercepat proses penyembuhan, mengurangi nyeri, serta meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup ibu nifas. Keberhasilan perawatan luka sangat dipengaruhi oleh pengetahuan ibu, praktik vulva hygiene yang benar, status nutrisi, serta dukungan lingkungan dan keluarga.

Manajemen laktasi merupakan komponen esensial dalam asuhan nifas karena ASI memberikan manfaat optimal bagi tumbuh kembang bayi sekaligus mendukung

pemulihan kesehatan ibu. proses laktasi dipengaruhi oleh factor fisiologis, hormonal, psikologis, serta kondisi ibu dan bayi. Dukungan tenaga kesehatan yang kompeten, edukasi menyusui yang adekuat, serta intervensi dini terhadap masalah laktasi sangat menentukan keberhasilan inisiasi dan keberlanjutan ASI eksklusif.

Edukasi keluarga menjadi pilar penting dalam asuhan nifas karena keluarga memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan dan praktik perawatan sehari-hari ibu dan bayi. Pendekatan *Family Centered maternity Care* (FCMC) terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan dukungan keluarga terhadap perawatan ibu nifas, menyusui, serta kesehatan fisik dan mental ibu. Edukasi yang dimulai sejak kehamilan, dilanjutkan sebelum kepulangan dari fasilitas kesehatan, dan diperkuat melalui kunjungan rumah mampu meningkatkan kemandirian ibu serta partisipasi aktif keluarga.

Dengan demikian, integrasi perawatan luka perineum yang optimal, manajemen laktasi berbasis evidence, dan edukasi keluarga dengan pendekatan berpusat pada keluarga merupakan strategi kunci dalam meningkatkan kualitas asuhan ibu nifas. Pendekatan holistic ini diharapkan dapat menurunkan angka komplikasi nifas, meningkatkan keberhasilan ASI Eksklusif, serta mendukung adaptasi fisik, psikologis, dan sosial ibu dalam menjalani masa pascapersalinan.

F. Referensi

- Adams, Y. J., Miller, M. L., Agbenyo, J. S., Ehla, E. E., & Clinton, G. A. (2023). Postpartum care needs assessment: women ' s understanding of postpartum care , practices , barriers , and educational needs. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12884-023-05813-0>
- Amalia, N. R., Rahmawati, I., & Purwanti, R. (2023). Perawatan luka jahitan perineum pada ibu nifas Di PMB Emy Lestari Purworejo. 01.
- Anderson, S. M., Maclean, P. S., Mcmanaman, J. L., & Neville, M. C. (2015). Lactation and its Hormonal Control Methods for Studying Mammary Gland. In Knobil and Neill's Physiology of Reproduction (Fourth Edition). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-397175-3.00046-6>
- Bukhari, A., Hidayanty, H., Astuti, N., Bahar, B., Luh, N., Herli, P., Kebidanan, M., Pascasarjana, S., Hasanuddin, U., Kedokteran, F., Hasanuddin, U., Kesehataan, F., Universitas, M., Kedokteran, F., & Brawijaya, U. (2021). Pengaruh Edukasi Media Whatsapp Tentang Gizi Laktasi , Involusi Uteri , Dan Lochea Terhadap Pengetahuan , Sikap Dan Perilaku Ibu Nifas The Influence of Whatsapp Media Education About Lactation Nutrition , Uterine Involution , and Lochea on

Knowledge , Attitudes and Behavior of Postpartum Mothers Khadijah I Muhammadiyah Makassar , dilakukan karena 50 % kematian ibu. 8(1), 20–33.

Di, P., Ulfah, T., Bagoang, K. P., Gandayasa, D. S., Kec, R. W., & Kab, C. (2025). Tahun 2025 202 5. 4009–4017.

Geddes, D. T., Gridneva, Z., Perrella, S. L., Mitoulas, L. R., Kent, J. C., Stinson, L. F., Lai, C. T., Sakalidis, V., Twigger, A., & Hartmann, P. E. (2021). 25 Years of Research in Human Lactation: From Discovery to Translation.

Girsang, B. M., & Elfira, E. (2023). A Literature Review on Postpartum Perineal Care: Epidemiology, Impact, and Future Interventions. 11, 73–80.

Głó, P. (2025). Perspective on Perinatal Birth Canal Injuries: An Analysis of Risk Factors, Injury Mechanisms, Treatment Methods, and Patients ' Quality of Life : A Literature Review. 1–18.

Guidance, I., Women, C., & Practices, I. B. (n.d.). IMPLEMENTATION GUIDANCE ON COUNSELLING WOMEN TO IMPROVE.

Hidayat, S. (2024). Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas Dengan Perawatan Luka Perineum Di Klinik Pratama Medical Center Kota Batam. 3(1).

Indrayani, E., Julianti, I. F., & Indriyastuti, H. I. (2024). THE IMPELMANTATION OF FAMILY CENTERED MATERNITY CARE EDUCATION TO POSTPARTUM MOTHERS AT PMB SITI ISTI' ANATUL AMRIYAH. 3(1), 184–189.

Jena, M. K., Khan, F. B., Ali, S. A., Sharma, A. K., Yadav, V., Kancharla, S., Kolli, P., Mandadapu, G., Sahoo, A. K., Kumar, P., Taneera, J., Kumar, S., Mohanty, A. K., Wen, K., Ming, L. C., & Ardianto, C. (2023). Molecular complexity of mammary glands development: a review of lactogenic differentiation in epithelial cells. *Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology*, 51(1), 491–508. <https://doi.org/10.1080/21691401.2023.2252872>

Joshi, P., Pal, R., R, J. R., Mukhopadhyay, A., & Mishra, N. R. (2025). Improving nurse' s knowledge, attitudes, and skills in lactation and breastfeeding management using a blended learning approach: a quasi - experimental study. *BMC Medical Education*, 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12909-025-07341-1>

Kachurenko, A., Levadna, L., & Horobets, A. (2023). Modern baby breastfeeding trends. 18(8), 565–571. <https://doi.org/10.22141/2224-0551.18.8.2023.1656>

Lassi, Z. S., Rind, F., Irfan, O., Hadi, R., & Das, J. K. (n.d.). Countries: Systematic Review.

Man, R., Morris, R. K., Magill, L., Hughes, T., Perry, R., Tohill, S., Henry, N., Kadir, B., Macarthur, C., & Hodgetts, V. (2026). Complications After Childbirth- Related

- Perineal Trauma up to Six- Weeks Postpartum: A Prospective Cohort Study. 274–282. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.18356>
- Murthy, S., Du, S., Id, Y., Alam, S., Id, A. K., Rangarajan, A., Mishra, A., Elliott, E., Delaney, M. M., & Semrau, K. E. A. (2023). PLOS GLOBAL PUBLIC HEALTH Improving neonatal health with family- centered, early postnatal care : A quasi-experimental study in India. 1–11. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001240>
- Naim, R., & Mutmaina, R. (2024). Poltekita: Jurnal Pengabdian Masyarakat. 5, 55–61. <https://doi.org/10.33860/pjpm.v5i1.2727>
- Nazari, S., Hajian, S., Abbasi, Z., & Majd, H. A. (2021). Postpartum care promotion based on maternal education needs: A mixed study. 1–8. <https://doi.org/10.4103/jehp.jehp>
- Neville, M. C., Demerath, E. W., Hahn-holbrook, J., Hovey, R. C., Martin-carli, J., Mcguire, M. A., Newton, E. R., Rasmussen, K. M., Rudolph, M. C., & Raiten, D. J. (2023). Parental factors that impact the ecology of human mammary development, milk secretion, and milk composition — a report from “ Breastmilk Ecology : Genesis of Infant Nutrition (BEGIN) ” Working Group 1. The American Journal of Clinical Nutrition, 117(June 2022), S11–S27. <https://doi.org/10.1016/j.ajcnut.2022.11.026>
- Practice, O. (2018). Optimizing Support for Breastfeeding as Part of Obstetric Practice. 132(756), 187–196.
- Radoff, K. (2020). Lactation Education for Resident Obstetricians: Promoting Breastfeeding Advocates for the Future. 1–9. <https://doi.org/10.1111/jmwh.13037>
- Rismawati, S., & Nurvita, N. (2023). Poster untuk Perawatan Masa Nifas di Era New Normal Sebagai Media Edukasi Kepada Ibu Nifas Posters to Care the Puerperium in the New Normal as a Media Education Mother Parturition. 5(1), 33–38.
- Rn, K. G., Rn, B. S., Marie, K., & Rn, S. (2023). Introducing Norwegian parents to the Circle of Security Parenting program during the postpartum period: A qualitative. September 2022, 428–438. <https://doi.org/10.1111/phn.13180>
- Runiari, N., & Ruspawan, D. M. (2023). Analysis Need Education for Postpartum Mothers. 8(2), 63–79.
- Saad, Jaber; Painter, Caitlynb. Management of postpartum perineal wound complications. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology 35(6):p 505-509, December 2023. | DOI: 10.1097/GCO.0000000000000906

- Sachan, R., Thomas, S., Varghese, B., & Singh, A. (2019). Encouraging the Use of Mother's Own Milk as First Feed for Preterm and Very Low Birth Weight Neonate Admitted to the Neonatal Intensive Care Unit: A Quality Improvement Initiative. 110–115. <https://doi.org/10.4103/jcn.JCN>
- Sadovnikova, A., Wysolmerski, J. J., & Hovey, R. C. (2020). The Onset and Maintenance of Human Lactation and its Endocrine Regulation. In *Maternal-Fetal and Neonatal Endocrinology*. Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814823-5.00014-3>
- Sasanti, D. A., Elmiani, H., Tiara, A., Sarif, E. P., & R, F. F. (2024). Optimalisasi peran keluarga dalam perawatan masa nifas.
- Schmidt, P. C., & Fenner, D. E. (2024). Expert Review Repair of episiotomy and obstetrical perineal lacerations (first e fourth). *The American Journal of Obstetrics & Gynecology*, 230(3), S1005–S1013. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.07.005>
- Sharma, P., Bagga, R., Khan, M., Duggal, M., Basavarajappa, D. H., Ahuja, A., Kankaria, A., Smith, N. D., Kumar, V., Kashyap, M., Singh, P., Kaur, J., & Ayadi, A. M. El. (2025). Maternal health education and social support needs across the perinatal continuum of care: a thematic analysis of interviews with postpartum women in Punjab, India. 8.
- Sianturi, E., & Siregar, M. (2025). Edukasi Perawatan Payudara Dalam Upaya Meningkatkan Efikasi Diri Menyusui pada Ibu Hamil Trimester Akhir. 9(3), 284–294.
- Spatz, D. L., Rodríguez, S. Á., Benjilany, S., Finderle, B., Gartzen, A. Von, & Yates, A. (2024). *Journal of Midwifery & Women's Health* Innovations from the Field Proactive Management of Lactation in the Birth Hospital to Ensure Long-Term Milk Production and Sustainable Breastfeeding. 343–349. <https://doi.org/10.1111/jmwh.13726>
- Sriraman, N. K. (2017). Anatomy and Physiology of Lactation. *Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care*, 47(12), 305–310. <https://doi.org/10.1016/j.cppeds.2017.10.001>
- Subramanian, L., Murthy, S., Bogam, P., Yan, S. D., Delaney, M. M., Goodwin, C. D. G., Bobanski, L., Rangarajan, A. S., Bhowmik, A., Kashyap, S., Ramnarayan, N., Hawrusik, R., Bell, G., Kaur, B., Rajkumar, N., Mishra, A., Alam, S. S., & Semrau, K. E. A. (2020). Just- in- time postnatal education programmes to improve newborn care practices: needs and opportunities in low- resource settings. 1–7. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-002660>

- Truchet, S., & Honvo-houéto, E. (2017). Physiology of Milk Secretion. *Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism*. <https://doi.org/10.1016/j.beem.2017.10.008>
- Wahyuni, C. (2024). Efforts to Improve Postpartum Maternal Behavior through Family-Centered Maternity Care (FCMC) about Postpartum Care Education. *7*(2), 238–243.
- Young, N., Branford, K., Engle, D. L., Dotters-katz, S. K., & Dotson, A. (2025). Breast Pain in a Lactating Person: An Objective Structured Clinical Examination for Clerkship Students. 1–7.
- Yusrotul, Y., Yulia, A., Early, R., & Saputri, W. A. (2022). The Relationship Between Knowledge of Postpartum Mothers About Perineal Wound Treatment With Perineal Wound Healing. *1*(1), 7–12. <https://doi.org/10.58344/ihj.v1i1.9>

G. Glosarium

WHO	: World Health Organization
UNICEF	: United Nations Children's Fund
ASI	: Air Susu Ibu
OASIS	: Obstetric Anal Sphincter Injuries
IMT	: Indeks Massa Tubuh
BAK	: Buang Air Kecil
BAB	: Buang Air Besar
NaCL	: Natrium Klorida
PRL	: Prolaktin
GH	: Growth Hormone
IGF-1	: Insulin Like Growth Factor
PTHrP	: Parathyroid hormone-related peptide
SIDS	: Suddenly Infant Death Syndrome
FCMC	: Family Centred Maternity Care

CHAPTER 7

KOMUNIKASI EFEKTIF BIDAN DENGAN PASIEN DAN KELUARGA

Bdn. Riska Afriani, S.Tr.Keb., M.Kes.

A. Pendahuluan / Prolog

Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang berfokus pada kesehatan perempuan sepanjang siklus reproduksi, mulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga perawatan bayi baru lahir. Dalam menjalankan peran tersebut, bidan tidak hanya dituntut memiliki kompetensi klinis yang mumpuni, tetapi juga keterampilan komunikasi yang efektif. Keberhasilan asuhan kebidanan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bidan membangun hubungan yang harmonis dengan pasien dan keluarganya.

Komunikasi dalam praktik kebidanan bukan sekadar proses penyampaian informasi medis. Lebih dari itu, komunikasi adalah sarana membangun kepercayaan, memberikan dukungan emosional, menurunkan kecemasan, serta membantu pasien dan keluarga dalam memahami kondisi kesehatan dan mengambil keputusan yang tepat. Pada situasi tertentu seperti persalinan, komplikasi kehamilan, atau kondisi gawat darurat cara bidan berkomunikasi dapat memengaruhi stabilitas psikologis pasien sekaligus menentukan kelancaran tindakan medis yang diberikan.

Dalam konteks pelayanan yang berpusat pada pasien (patient-centered care), komunikasi menjadi fondasi utama terciptanya hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan klien. Pendekatan ini menekankan pentingnya empati, penghargaan terhadap nilai budaya, keterlibatan keluarga, serta pemberian informasi yang jelas dan mudah dipahami. Bidan sebagai tenaga kesehatan terdepan di masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan tidak hanya informatif, tetapi juga suportif dan membangun rasa aman.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa hambatan komunikasi masih sering terjadi. Perbedaan latar belakang pendidikan, budaya, tingkat kecemasan, hingga keterbatasan waktu pelayanan dapat mengurangi efektivitas komunikasi. Selain itu, penggunaan istilah medis yang kurang dipahami pasien juga kerap menimbulkan salah persepsi. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi tidak dapat dianggap sebagai kemampuan bawaan semata, melainkan harus dipelajari, dilatih, dan dikembangkan secara berkelanjutan.

B. Hakikat Komunikasi dalam Praktik Kebidanan

Komunikasi merupakan fondasi utama dalam pelayanan kebidanan. Dalam praktik profesional, bidan berperan sebagai pemberi asuhan, pendidik kesehatan, konselor, advokat perempuan, serta fasilitator pengambilan keputusan. Seluruh peran tersebut tidak dapat dijalankan secara optimal tanpa kemampuan komunikasi yang efektif.

Secara konseptual, komunikasi adalah proses pertukaran pesan antara komunikator dan komunikan melalui saluran tertentu yang menghasilkan pemahaman bersama. Dalam kebidanan, komunikasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga terapeutik dan relasional. Artinya, komunikasi bertujuan membangun hubungan saling percaya yang berdampak pada kepatuhan pasien, kenyamanan emosional, dan keberhasilan tindakan klinis.

Teori komunikasi interpersonal menekankan pentingnya persepsi, empati, bahasa nonverbal, dan umpan balik. Dalam konteks kebidanan, persepsi ibu terhadap sikap bidan dapat memengaruhi tingkat kecemasan dan kesiapan menghadapi proses persalinan. Oleh karena itu, kualitas komunikasi sering kali menjadi indikator mutu pelayanan kesehatan.

C. Prinsip dan Unsur Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan berlandaskan pada beberapa prinsip utama:

1. Kejelasan (clarity) – Informasi disampaikan dengan bahasa sederhana.
2. Empati – Memahami perasaan pasien tanpa menghakimi.
3. Keterbukaan (openness) – Memberi ruang bertanya.
4. Respek – Menghormati nilai budaya dan keyakinan pasien.
5. Umpan balik (feedback) – Memastikan pesan dipahami.

Unsur komunikasi meliputi komunikator (bidan), pesan (informasi kesehatan), media (verbal/nonverbal), komunikan (pasien/keluarga), dan konteks (situasi klinis).

Komunikasi nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, sentuhan terapeutik, dan intonasi suara sering kali lebih bermakna dibanding kata-kata. Dalam praktik kebidanan, bahasa tubuh yang tenang dapat menurunkan kecemasan ibu bersalin.

D. Komunikasi Terapeutik dalam Pelayanan Kebidanan

Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dirancang untuk membantu proses penyembuhan. Tahapannya meliputi:

1. **Pra-interaksi** – Persiapan diri bidan.
2. **Orientasi** – Membangun kepercayaan.
3. **Kerja** – Eksplorasi masalah dan edukasi.
4. **Terminasi** – Evaluasi dan penutup.

Teknik komunikasi terapeutik mencakup:

- Mendengarkan aktif
- Refleksi perasaan
- Klarifikasi
- Parafrase
- Pertanyaan terbuka
- Pendekatan ini meningkatkan kepuasan pasien serta memperkuat hubungan profesional.

E. Komunikasi pada Ibu Hamil

Persalinan adalah momen kritis yang membutuhkan komunikasi singkat, jelas, dan suportif.

Teknik yang efektif:

1. Instruksi sederhana
2. Dukungan verbal positif
3. Kontak mata
4. Sentuhan suportif

Komunikasi yang buruk dapat meningkatkan ketegangan dan menghambat kemajuan persalinan.

F. Komunikasi pada Masa Nifas dan Menyusui

Pada masa nifas, ibu rentan mengalami baby blues atau depresi postpartum. Komunikasi empatik sangat diperlukan.

Edukasi meliputi:

1. Perawatan luka
2. Tanda bahaya nifas
3. Teknik menyusui yang benar
4. Perawatan bayi baru lahir

Bidan harus mendorong ibu untuk mengungkapkan perasaan tanpa rasa malu.

G. Komunikasi dalam Situasi Sulit dan Gawat Darurat

Situasi komplikasi memerlukan komunikasi asertif dan terkontrol.

Prinsip utama:

1. Tetap tenang
2. Jujur dan transparan
3. Hindari istilah teknis berlebihan
4. Fokus pada solusi

Dalam kondisi krisis, komunikasi memengaruhi stabilitas psikologis keluarga.

H. Komunikasi dengan Keluarga Pasien

Keluarga berperan penting dalam pengambilan keputusan, terutama dalam budaya kolektif.

Bidan perlu:

1. Menghormati struktur keluarga
2. Menghindari konflik
3. Memberikan penjelasan kolektif
4. Menjaga kerahasiaan pasien

Kolaborasi meningkatkan keberhasilan asuhan.

I. Hambatan Komunikasi dan Cara Mengatasinya

Hambatan dapat berupa:

1. Bahasa
2. Emosi
3. Lingkungan
4. Perbedaan persepsi

Solusi:

1. Gunakan interpreter bila perlu
2. Latih keterampilan interpersonal
3. Sediakan ruang privat
4. Gunakan alat bantu visual

J. Dokumentasi dan Evaluasi Komunikasi

Dokumentasi mencakup:

1. Materi edukasi
2. Respons pasien
3. Rencana tindak lanjut

Evaluasi dilakukan melalui observasi pemahaman pasien dan kepatuhan terapi.

K. Kesimpulan

komunikasi merupakan elemen kunci yang menentukan mutu dan keberhasilan pelayanan kebidanan. Bidan tidak hanya menyampaikan informasi medis, tetapi juga membangun hubungan terapeutik yang dilandasi kejelasan pesan, empati, keterbukaan, respek terhadap nilai budaya, serta umpan balik untuk memastikan pemahaman pasien dan keluarga. Komunikasi yang efektif baik verbal maupun nonverbal mampu meningkatkan kepercayaan, menurunkan kecemasan, memperkuat kepatuhan, dan mendukung kelancaran tindakan klinis.

Penerapan komunikasi terapeutik melalui tahapan pra-interaksi, orientasi, kerja, dan terminasi membantu bidan memberikan asuhan yang lebih terarah dan berpusat pada pasien. Pada setiap fase pelayanan (kehamilan, persalinan, nifas, dan menyusui), bidan perlu menyesuaikan pendekatan komunikasi sesuai kebutuhan psikologis dan kondisi klinis klien. Dalam situasi sulit atau gawat darurat, komunikasi yang tenang, jujur, singkat, dan fokus pada solusi sangat penting untuk menjaga stabilitas psikologis pasien dan keluarga serta mendukung pengambilan keputusan cepat.

Keluarga juga menjadi mitra penting dalam asuhan, sehingga bidan perlu mengelola komunikasi kolektif secara bijak sambil tetap menjaga kerahasiaan pasien. Meski hambatan komunikasi kerap muncul akibat perbedaan bahasa, emosi, lingkungan, atau persepsi, kendala tersebut dapat diatasi melalui peningkatan keterampilan interpersonal, penggunaan bahasa sederhana, penyediaan ruang yang nyaman, serta bantuan visual atau interpreter bila diperlukan. Terakhir, dokumentasi dan evaluasi komunikasi menjadi bagian penting untuk memastikan edukasi tersampaikan dengan baik, respons pasien tercatat, dan tindak lanjut asuhan berjalan efektif.

L. Referensi

- Arnold, E. C., & Boggs, K. U. (2020). *Interpersonal Relationships: Professional Communication Skills for Nurses*. Elsevier.
- DeVito, J. A. (2019). *The Interpersonal Communication Book*. Pearson.
- Hargie, O. (2017). *Skilled Interpersonal Communication: Research, Theory and Practice*. Routledge.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Standar Profesi Bidan Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kozier, B., Erb, G., Berman, A., & Snyder, S. (2018). *Fundamentals of Nursing*. Pearson.

Potter, P. A., Perry, A. G. (2017). *Fundamentals of Nursing*. Elsevier.

World Health Organization. (2018). *WHO Recommendations: Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience*. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2022). *WHO Recommendations on Maternal and Newborn Care*. Geneva: WHO.

M. Glosarium

Advokat Perempuan: Peran bidan untuk membela dan memperjuangkan hak, kebutuhan, serta keselamatan perempuan dalam pelayanan kesehatan.

Asuhan Kebidanan: Pelayanan profesional bidan kepada perempuan dan bayi, mencakup kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir.

Budaya Kolektif: Budaya yang menekankan kebersamaan dan keputusan sering melibatkan keluarga/kelompok.

Clarity (Kejelasan): Prinsip komunikasi dengan penyampaian informasi secara sederhana, runtut, dan mudah dipahami.

Depresi Postpartum: Gangguan suasana hati yang lebih berat setelah melahirkan, ditandai sedih mendalam, hilang minat, dan dapat mengganggu fungsi harian.

Feedback (Umpan Balik): Respons dari pasien/keluarga untuk memastikan pesan diterima dan dipahami dengan benar.

Gawat Darurat: Kondisi kritis yang memerlukan penanganan cepat untuk mencegah risiko serius pada ibu atau bayi.

Hambatan Komunikasi: Faktor yang mengganggu komunikasi, misalnya perbedaan bahasa, emosi, lingkungan, atau persepsi.

Refleksi Diri: Tulisan reflektif mengenai pengalaman belajar dan penerapannya.

CHAPTER 8

PERAN BIDAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING PADA 1000 HPK

Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.

A. Pendahuluan

Stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan linier pada anak yang ditandai dengan tinggi badan menurut usia berada di bawah standar deviasi yang ditetapkan WHO. Keadaan ini mencerminkan masalah gizi kronis yang berlangsung dalam waktu lama serta berkaitan dengan kondisi sosioekonomi keluarga, kesehatan ibu, dan pola asuh anak (WHO, 2023). Stunting tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang, sehingga berpengaruh terhadap pembangunan bangsa (UNICEF, 2021; Victora et al., 2021).

Upaya pencegahan stunting menekankan pentingnya intervensi pada periode kritis, terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Intervensi gizi spesifik terbukti mampu menurunkan prevalensi stunting melalui suplementasi zat gizi, fortifikasi makanan, pemberian ASI eksklusif, edukasi pola makan, tata laksana infeksi, serta pemantauan tumbuh kembang (Black et al., 2023).

Dalam konteks pelayanan kebidanan, bidan memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan remaja putri, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan balita. Peran bidan mencakup skrining faktor risiko, pendidikan kesehatan, konseling gizi, pemantauan kehamilan, dukungan laktasi, serta deteksi dini masalah gizi dan penyakit infeksi. Melalui peran komprehensif tersebut, bidan berkontribusi langsung dalam pencegahan stunting sejak masa prakonsepsi hingga balita (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

B. Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK)

Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yang sering disebut sebagai periode emas (golden period), merupakan tahap krusial yang dimulai dari pembuahan hingga anak mencapai usia dua tahun. Periode ini mencakup sekitar 270 hari selama masa kehamilan dan 730 hari pertama setelah kelahiran bayi. Dalam kerangka ini, salah satu inisiatif utama untuk mencegah stunting melibatkan intervensi gizi yang ditargetkan pada ibu hamil, ibu yang sedang menyusui, serta

anak berusia 0 hingga 23 bulan (Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting, 2019). Bidan memainkan peran sentral dalam gerakan ini, karena mereka berada di garis depan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di tingkat desa dan puskesmas, untuk memastikan intervensi berjalan efektif dan berkelanjutan.

Gerakan 1000 HPK menekankan pentingnya periode awal kehidupan sejak janin di dalam kandungan hingga usia dua tahun, di mana gangguan gizi dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan yang permanen. Menurut data terkini, stunting di Indonesia masih menjadi masalah utama, dengan prevalensi mencapai sekitar 21,6% pada anak di bawah lima tahun berdasarkan survei tahun 2022, dan pencegahan harus difokuskan pada tahap ini untuk menghindari dampak jangka panjang seperti penurunan kecerdasan dan produktivitas (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Bidan bertanggung jawab untuk mendeteksi dini risiko stunting melalui pemantauan rutin, edukasi kepada keluarga, dan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya, sehingga memperkuat upaya nasional dalam mengurangi angka stunting hingga target 14% pada tahun 2024.

Gerakan ini terdiri dari dua jenis intervensi utama: intervensi gizi spesifik yang dikelola oleh sektor kesehatan dengan target ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-23 bulan, serta intervensi gizi sensitif yang melibatkan sektor non-kesehatan seperti pendidikan, pertanian, dan sanitasi (Aisyah & Suparni, 2022). Bidan, sebagai tenaga kesehatan utama di tingkat primer, mengintegrasikan kedua jenis intervensi ini melalui pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Posyandu. Penelitian menunjukkan bahwa peran kolaboratif bidan, termasuk edukasi nutrisi dan pemantauan pertumbuhan, dapat meningkatkan cakupan intervensi hingga 70-80% jika didukung oleh pengetahuan terkini dan standar profesional seperti Bidan Delima (Kumanireng et al., 2022).

Intervensi gizi spesifik yang dipimpin oleh Kementerian Kesehatan melalui Puskesmas dan Posyandu mencakup berbagai program yang difasilitasi oleh bidan. Untuk ibu hamil, bidan memberikan makanan tambahan bagi yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK), suplementasi zat besi dan asam folat untuk mencegah anemia, fortifikasi yodium, pengobatan cacingan, serta perlindungan dari malaria. Selama masa menyusui dan untuk anak usia 0-6 bulan, bidan mendorong Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dengan pemberian kolostrum, serta edukasi untuk menyusui eksklusif. Bagi anak usia 7-23 bulan, bidan mempromosikan pemberian ASI lanjutan hingga 23 bulan disertai makanan pendamping ASI (MP-ASI), distribusi obat cacing, suplementasi seng, fortifikasi zat besi pada makanan, imunisasi lengkap, pencegahan malaria, serta pengelolaan diare (Sormin, 2023). Peran bidan diperluas dengan pendekatan *continuity of care*, di mana mereka mendampingi keluarga secara berkelanjutan dari pra-kehamilan hingga pasca-melahirkan,

termasuk pemantauan antropometri bulanan dan intervensi berbasis komunitas untuk mendeteksi dini stunting (Suryaningsih et al., 2024).

Untuk memperkuat pencegahan, bidan juga terlibat dalam intervensi gizi sensitif, seperti promosi akses air bersih, sanitasi yang layak, dan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja putri serta wanita usia subur. Kolaborasi dengan kader Posyandu dan tim percepatan penurunan stunting di tingkat desa memungkinkan bidan untuk melakukan audit kasus stunting, pemberian bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), serta kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Studi terkini menunjukkan bahwa faktor seperti fasilitas, motivasi, dan pengetahuan bidan secara signifikan memengaruhi efektivitas peran mereka, dengan pelatihan rutin yang dianjurkan untuk adaptasi terhadap era pasca-pandemi (Aisyah & Suparni, 2022; Kumanireng et al., 2022). Selain itu, bidan memanfaatkan makanan lokal bergizi seperti daun kelor, ikan, dan ubi untuk fortifikasi nutrisi, yang telah terbukti meningkatkan asupan mikronutrien pada keluarga berisiko (Momongan, 2022).

Dalam konteks nasional, peran bidan didukung oleh kebijakan seperti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menekankan konvergensi lintas sektor. Bidan diharapkan untuk terus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, seperti program Optimalisasi Peran Bidan dalam 1000 HPK dari Kementerian Kesehatan, guna mencapai target penurunan stunting secara berkelanjutan (Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting, 2019; Sormin, 2023). Dengan demikian, bidan bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai agen perubahan komunitas yang memastikan setiap anak Indonesia tumbuh optimal tanpa hambatan stunting.

C. Intervensi Gizi Spesifik dalam Pencegahan Stunting pada 1000

Intervensi gizi spesifik merujuk pada serangkaian tindakan langsung yang ditargetkan kepada kelompok rentan, termasuk remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui, bayi baru lahir, serta anak di bawah usia dua tahun (baduta), untuk mengatasi akar penyebab stunting seperti defisiensi nutrisi dan infeksi berulang. Pendekatan ini berkontribusi hingga 30% dalam mengurangi prevalensi stunting secara nasional, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi mikro dan makro selama periode kritis 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Di Indonesia, intervensi ini dikoordinasikan melalui Kementerian Kesehatan dan dilaksanakan di tingkat primer seperti Puskesmas dan Posyandu, di mana bidan berperan sebagai koordinator utama untuk memastikan aksesibilitas dan kepatuhan masyarakat terhadap program tersebut (Lasmadasari et al., 2023). Bidan tidak hanya mendistribusikan suplementasi, tetapi juga melakukan skrining dini, edukasi

keluarga, dan pemantauan berkelanjutan untuk mendeteksi risiko stunting sejak dini, sehingga memperkuat efektivitas intervensi secara keseluruhan.

Bidan memegang tanggung jawab utama dalam menerapkan intervensi ini, dimulai dari tahap pra-kehamilan hingga pasca-melahirkan. Bagi remaja putri dan calon pengantin, bidan memberikan skrining anemia dan distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) untuk mencegah kekurangan zat besi yang dapat berlanjut ke generasi berikutnya. Pada ibu hamil, bidan melakukan pemeriksaan antenatal care (ANC) minimal enam kali, termasuk pengukuran lingkaran lengan atas (LILA) dan kadar hemoglobin (Hb) untuk mengidentifikasi Kurang Energi Kronik (KEK). Intervensi mencakup pemberian TTD minimal 90 tablet, makanan tambahan pemulihan (PMT) berbasis bahan lokal yang difortifikasi dengan zat besi, yodium, dan vitamin A, serta edukasi tentang pencegahan malaria di wilayah endemik dan konsumsi garam beryodium. Selama masa nifas dan menyusui, bidan memfasilitasi Inisiasi Menyusui Dini (IMD), promosi ASI eksklusif hingga enam bulan, serta pemberian ASI lanjutan hingga 23 bulan disertai Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang memperhatikan ketepatan waktu, frekuensi, variasi jenis makanan, porsi yang sesuai, dan metode pengolahan higienis (Sormin, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa peran bidan sebagai agen perubahan, termasuk dalam pelatihan gizi seimbang dan konseling menyusui sesuai pedoman WHO, dapat meningkatkan pengetahuan ibu hingga 20-30% dan menurunkan prevalensi stunting secara signifikan melalui pendampingan intensif (Pudjirahaju et al., 2025).

Untuk anak usia 0-23 bulan, bidan mengawasi pemantauan pertumbuhan rutin di Posyandu, distribusi suplementasi vitamin A, imunisasi lengkap, pengobatan kecacingan, dan manajemen diare dengan zinc. Bidan juga menangani kasus gizi buruk melalui rujukan ke Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan mempromosikan penggunaan sprinkle (serbuk multi-mikronutrien) untuk fortifikasi makanan rumah tangga. Di daerah endemik, bidan mendistribusikan kelambu berinsektisida dan melakukan sosialisasi tentang Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendukung akses nutrisi. Tantangan seperti kepatuhan rendah pada TTD dan akses geografis dapat diatasi melalui kolaborasi bidan dengan kader Posyandu dan lintas sektor, seperti pendidikan dan pertanian, untuk mengintegrasikan intervensi gizi sensitif (Laikingis, 2025). Selain itu, bidan melakukan evaluasi efektivitas MP-ASI lokal, penelitian KAP (Knowledge, Attitude, Practice) tentang pola makan, dan sosialisasi peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, yang telah diperbarui dalam kebijakan nasional terkini untuk adaptasi pasca-pandemi.

Perluasan intervensi ini mencakup penggunaan teknologi seperti dashboard Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) untuk tracking real-time dan audit kasus

stunting, di mana bidan berperan sebagai fasilitator komunitas. Studi literatur menekankan bahwa intervensi gizi spesifik efektif bila didukung oleh peningkatan kapasitas bidan melalui pelatihan rutin, yang dapat meningkatkan cakupan hingga 80-90% dan mengurangi prevalensi stunting hingga 27% di tingkat lokal (Akhfar et al., 2023). Bidan juga mendorong pengembangan MP-ASI berbasis bahan lokal seperti ikan, telur, dan sayuran hijau untuk memastikan keterjangkauan dan keberlanjutan, serta mengintegrasikan edukasi tentang paparan asap rokok pasif dan konseling KB untuk pencegahan kehamilan berisiko

Tabel 6.1 Kegiatan Utama dalam Intervensi Gizi Spesifik

NO	KEGIATAN
1	Skrining anemia dan distribusi TTD pada remaja putri serta calon pengantin
2	Pemeriksaan ANC terintegrasi minimal 6 kali dengan pengukuran LILA dan Hb
3	Pemberian TTD ≥ 90 tablet dan PMT untuk ibu hamil KEK menggunakan bahan difortifikasi (zat besi, yodium, vitamin A)
4	Edukasi intensif (KIE) tentang gizi seimbang dan pentingnya suplementasi
5	Promosi garam beryodium dan pemberantasan malaria di daerah endemik
6	IMD dan promosi ASI eksklusif 0-6 bulan dengan konseling menyusui
7	ASI lanjutan hingga 23 bulan disertai MP-ASI kaya nutrisi hewani
8	Pemantauan pertumbuhan bulanan dan intervensi dini growth faltering
9	Imunisasi lengkap, suplementasi vitamin A, dan pengobatan kecacingan
10	Manajemen diare dengan zinc dan penanganan gizi buruk via MTBS
11	Evaluasi MP-ASI lokal dan penelitian KAP untuk adaptasi komunitas
12	Sosialisasi peraturan daerah tentang fortifikasi makanan dan PKH
13	Pendampingan agen perubahan (bidan dan kader) untuk peningkatan IQ dan perkembangan anak

Tabel 6.2 Indikator untuk Menilai Pencapaian Intervensi Gizi Spesifik

KEGIATAN	INDIKATOR
Remaja Putri	% cakupan skrining anemia dan konsumsi TTD; % remaja dengan pengetahuan gizi meningkat
Ibu Hamil	% cakupan ANC ≥ 6 kali; % konsumsi TTD ≥ 90 tablet; % ibu KEK mendapat PMT; % terlindung dari anemia, malaria, dan kekurangan iodium; % konsumsi energi $\geq 70\%$ AKG; % terpapar asap rokok pasif
Ibu Menyusui & Bayi 0-6 Bulan	% IMD dan ASI eksklusif; % cakupan konseling menyusui dan KB
Anak 0-23 Bulan	% pemantauan pertumbuhan rutin; % pemberian MP-ASI tepat pada >6 bulan; % akses garam beryodium; % manajemen zinc pada diare; % penanganan gizi buruk; % suplementasi vitamin A dan sprinkle; % pengobatan

	kecacangan dan penurunan prevalensi; % cakupan PKH; % distribusi kelambu insektisida; % imunisasi dasar lengkap; % peningkatan IQ dan perkembangan anak
--	---

Dengan dukungan kebijakan seperti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan pembentukan Badan Gizi Nasional pada 2024, peran bidan dalam intervensi gizi spesifik semakin vital untuk mencapai target penurunan stunting nasional menjadi 14% pada 2024 dan 12% pada 2029. Bidan diharapkan terus berinovasi melalui pendekatan berbasis bukti, kolaborasi komunitas, dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk memastikan setiap anak Indonesia bebas dari stunting.

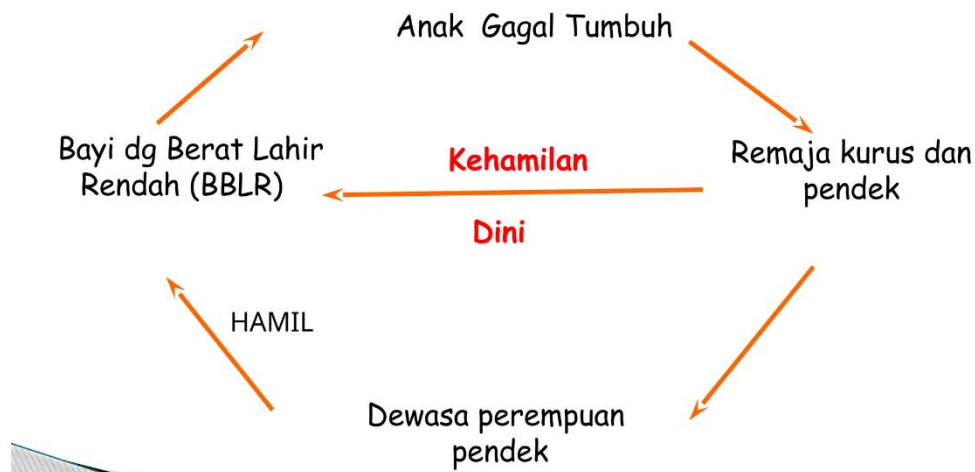
D. Hambatan dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan

Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) merupakan tahap yang sangat sensitif karena gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada masa ini bersifat permanen dan sulit diperbaiki di kemudian hari. Bukti ilmiah terkini menunjukkan bahwa stunting, atau tubuh pendek pada anak, terutama disebabkan oleh faktor lingkungan selama masa konsepsi hingga usia dua tahun, bukan semata-mata faktor genetik. Faktor lingkungan ini dapat dicegah melalui intervensi yang tepat waktu, terutama intervensi gizi spesifik yang terbukti cost-effective dalam mengurangi prevalensi stunting (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025). Bidan memainkan peran vital sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dini risiko stunting melalui pemeriksaan antenatal, pemantauan pertumbuhan janin, dan pendampingan pasca-persalinan, sehingga dapat mencegah dampak permanen pada generasi mendatang.

Prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan tren penurunan positif, dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8% pada 2024 berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, meskipun masih di atas target nasional 18,8% untuk 2025. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan intervensi pada 1000 HPK, namun tantangan tetap ada di provinsi dengan angka tinggi seperti Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, 2025). Bidan, melalui continuity of care, berkontribusi signifikan dengan melakukan skrining status gizi ibu hamil, promosi ASI eksklusif, dan edukasi pola asuh untuk memutus rantai stunting.

Masalah gizi kronis sering dimulai dari retardasi pertumbuhan janin atau Intra Uterine Growth Restriction (IUGR), yang dipicu oleh status gizi ibu pra-kehamilan yang buruk, seperti berat badan tidak ideal relatif terhadap tinggi badan serta penambahan berat badan yang kurang selama kehamilan. Ibu dengan riwayat stunting cenderung melahirkan bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) atau IUGR, yang kemudian berisiko mengalami stunting saat balita. Pola ini berulang antargenerasi jika tidak diintervensi, menciptakan siklus intergenerasi stunting yang

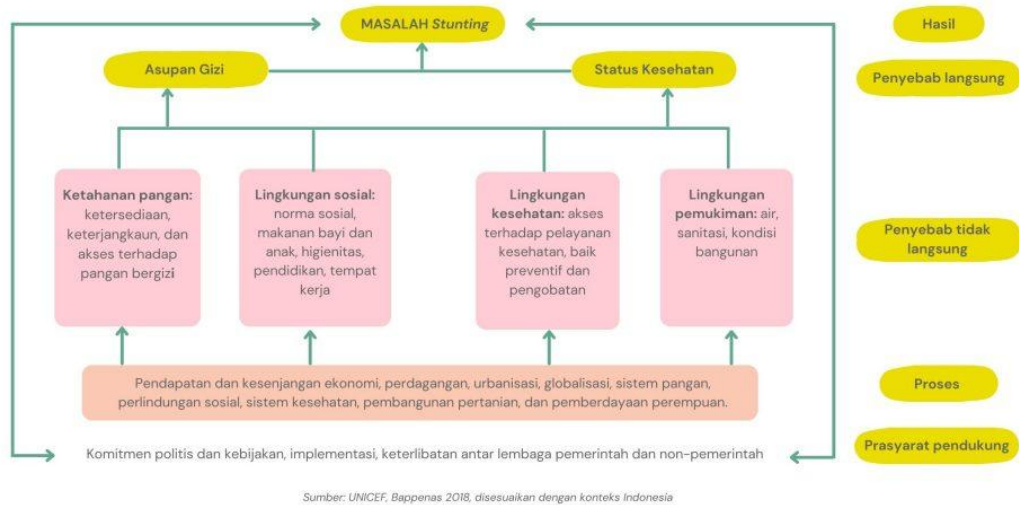
memperburuk kualitas sumber daya manusia secara nasional (Nirmalasari, 2020; Lestari et al., 2024). Bidan dapat memutus siklus ini dengan pendampingan pra-nikah, suplementasi gizi pada remaja putri, dan pemantauan kehamilan berisiko tinggi.



Gambar 7.1 Siklus Gangguan Pertumbuhan Intergenerasi

Penyebab stunting dapat dikategorikan menjadi faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung meliputi asupan makanan yang tidak mencukupi zat gizi seimbang (misalnya, kurangnya ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan) serta infeksi berulang yang terkait dengan cakupan imunisasi rendah. Faktor tidak langsung mencakup ketersediaan pangan bergizi di rumah tangga, pola asuh anak yang kurang optimal, akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan, serta sanitasi dan higiene yang buruk. Semua ini dipengaruhi oleh faktor mendasar seperti status sosial ekonomi, pendidikan orang tua, dan lingkungan pemukiman (UNICEF, 2020; Anggraini et al., 2024). Bidan berperan dalam mengatasi faktor ini melalui edukasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) gizi, kolaborasi dengan kader Posyandu, dan rujukan kasus berisiko ke fasilitas kesehatan lebih tinggi.

PENYEBAB MASALAH STUNTING



Gambar 7.2 Kerangka Konseptual Penyebab Stunting (Adaptasi dari UNICEF Framework)

Dalam konteks terkini, bidan diintegrasikan dalam tim percepatan penurunan stunting di tingkat desa, termasuk audit kasus stunting dan pendampingan keluarga berisiko melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian menunjukkan bahwa intervensi berfokus pada 1000 HPK, seperti pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja dan ibu hamil, dapat menurunkan risiko stunting hingga 30-40% jika dilakukan secara konvergen (Renyonet et al., 2023). Dengan demikian, gerakan 1000 HPK bukan hanya periode emas untuk pertumbuhan optimal, tetapi juga peluang strategis bagi bidan untuk berkontribusi dalam mencapai target prevalensi stunting nasional di bawah 14% pada 2029.

E. Simpulan

Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) merupakan masa emas yang sangat krusial untuk mencegah stunting, karena gangguan gizi dan pertumbuhan pada tahap ini bersifat permanen serta dapat memicu siklus intergenerasi yang merugikan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Stunting terutama disebabkan oleh faktor lingkungan, seperti asupan gizi tidak adekuat, infeksi berulang, pola asuh kurang optimal, serta akses layanan kesehatan dan sanitasi yang terbatas.

Intervensi gizi spesifik yang menargetkan remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-23 bulan terbukti efektif dan hemat biaya dalam memutus rantai stunting. Bidan memainkan peran sentral sebagai tenaga kesehatan garis depan di Puskesmas dan Posyandu, melalui skrining dini risiko stunting, pemberian suplementasi (TTD, PMT, vitamin A), promosi IMD dan ASI eksklusif,

pemantauan pertumbuhan rutin, edukasi gizi berbasis bahan lokal, pengelolaan infeksi, serta kolaborasi lintas sektor.

Data SSGI 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%, mencerminkan kemajuan intervensi pada 1000 HPK. Optimalisasi peran bidan melalui continuity of care, pelatihan berkelanjutan, dan sinergi dengan kader serta tim percepatan penurunan stunting menjadi kunci untuk mencapai target nasional di bawah 14% pada 2029, mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan bebas stunting menuju Indonesia Emas 2045

F. Referensi

- Aisyah, K. R. D., & Suparni, S. (2022). Peran kolaboratif bidan dalam pencegahan stunting di era adaptasi baru. *Window of Health: Jurnal Kesehatan*, 5(3), 642–652. <https://doi.org/10.33096/woh.v5i3.84>
- Akhfar, K., Erniawati, E., Kanang, B., Khatimah, H., & Jusni, J. (2023). Peran intervensi gizi spesifik dalam penanggulangan masalah gizi pada balita di Kabupaten Bulukumba. *Journal of Educational Innovation and Public Health*, 1(3), 139–148. <https://doi.org/10.55606/innovation.v1i3.1517>
- Anggraini, S., Muthmainnah, M., Septiani, N., & Suganda, T. (2024). Strategi intervensi penanganan stunting di Indonesia: Studi literatur. *SEHATI: Jurnal Kesehatan*.
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. (2025). Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dalam angka. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bappenas RI. (2021). Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., et al. (2023). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Pedoman asupan dan asuhan 1000 hari pertama kehidupan. Direktorat Gizi Masyarakat.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Pedoman Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). Laporan diseminasi SSGI 2024 dan strategi percepatan penurunan stunting. Direktorat Gizi Masyarakat.
- Kumanireng, M. Y. B., Siauta, J. A., & Rukmaini. (2022). Analisis peran bidan dalam upaya pencegahan stunting di praktik mandiri bidan (PMB) DKI Jakarta. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(9), 3734–3741. <http://jiip.stkipyapisdompupu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/924>
- Laikingis, E. A. (2025). Kajian pelaksanaan intervensi gizi spesifik di Desa Naitae Kecamatan Fatuleu Barat Tahun 2023. *Antigen: Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Gizi*, 3(2), 174–185. <https://doi.org/10.57213/antigen.v3i2.658>
- Lasmadasari, N., Puspitasari, N., Nilawati, I., & Herlinda, H. (2023). Monitoring program percepatan penurunan stunting: Intervensi gizi spesifik terhadap pengetahuan dan perilaku ibu dalam pemenuhan gizi bayi dan balita. *Jurnal Riset Media Keperawatan*, 6(1), 61–68. <https://doi.org/10.51851/jrmk.v6i1.404>

- Lestari, E., Siregar, A., Hidayat, A. K., & Yusuf, A. A. (2024). Stunting and its association with education and cognitive outcomes in adulthood: A longitudinal study in Indonesia. *Journal of Nutrition*.
- Momongan, N. R. (Ed.). (2022). *Stunting: Solusi dan pencegahannya*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Nirmalasari, N. O. (2020). Stunting pada anak: Penyebab dan faktor risiko stunting di Indonesia. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(1), 19-28.
- Pudjirahaju, A., Soelistyorini, D., Mustafa, A., & Kristianto, Y. (2025). Transforming Childhood: Nutrition Interventions in the First 1000 Days of Life to Prevent Stunting and Enhance IQ Children in Trenggalek: Intervensi Gizi Spesifik pada 1000 Hari Pertama Kehidupan oleh Agen Perubahan untuk Mencegah Stunting, Meningkatkan Perkembangan dan IQ Anak di Kabupaten Trenggalek. *Amerta Nutrition*, 9(1), 101-108. <https://doi.org/10.20473/amnt.v9i1.2025.101-108>
- Renyoet, B. S., Dary, D., & Nugroho, C. V. (2023). Literatur review: Intervensi pada remaja perempuan 8000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai upaya pencegahan stunting pada generasi di masa depan. *Amerta Nutrition*.
- Sormin, R. E. M. (2023). Peran bidan desa dalam pencegahan stunting pada puskesmas di Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Administrasi dan Demokrasi*, 2(1), 69-75. <https://doi.org/10.26418/jad.v2i1.11884>
- Sormin, R. E. M. (2023). Peran bidan desa dalam pencegahan stunting pada puskesmas di Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Administrasi dan Demokrasi*, 2(1), 69-75.
- Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting. (2019). Strategi nasional percepatan pencegahan anak kerdil (stunting) periode 2018-2024 (Edisi Kedua). Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Suryaningsih, C., et al. (Eds.). (2024). *Stunting, solusi dan pencegahannya*. PT Media Pustaka Indo.
- UNICEF. (2020). *Improving child nutrition: The achievable imperative for global progress*. United Nations Children's Fund.
- UNICEF. (2021). *Improving child nutrition: The achievable imperative for global progress*.

Victora, C. G., Christian, P., Vdaletti, L. P., et al. (2021). Revisiting maternal and child undernutrition in low-income and middle-income countries: Variable progress towards an unfinished agenda. *The Lancet*.

World Health Organization. (2023). Childhood stunting: Policy brief.

G. Glosarium

1000 HPK: 1000 Hari Pertama Kehidupan, periode krusial dari masa kehamilan (270 hari) hingga anak berusia dua tahun (730 hari), sering disebut sebagai periode emas untuk pencegahan stunting.

ANC: Antenatal Care, pemeriksaan kehamilan rutin minimal enam kali untuk memantau kesehatan ibu dan janin.

ASI Eksklusif: Pemberian Air Susu Ibu saja tanpa makanan atau minuman lain kepada bayi hingga usia enam bulan.

BBLR: Berat Badan Lahir Rendah, bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram, berisiko tinggi mengalami stunting.

IMD: Inisiasi Menyusui Dini, proses menyusui bayi segera dalam satu jam pertama setelah lahir untuk memberikan kolostrum.

IUGR: Intra Uterine Growth Restriction, retardasi atau keterlambatan pertumbuhan janin di dalam rahim akibat kekurangan gizi ibu.

KEK: Kurang Energi Kronik, kondisi kekurangan energi dan protein kronis pada ibu hamil (diukur dengan LILA <23,5 cm), meningkatkan risiko BBLR dan stunting.

KIE: Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, pendekatan edukasi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang gizi.

LILA: Lingkar Lengan Atas, pengukuran status gizi ibu hamil; nilai <23,5 cm menandakan risiko KEK.

MP-ASI: Makanan Pendamping ASI, makanan tambahan bergizi yang diberikan kepada bayi setelah usia enam bulan disertai ASI lanjutan hingga 23 bulan.

MTBS: Manajemen Terpadu Balita Sakit, pendekatan penanganan terintegrasi untuk balita sakit, termasuk kasus gizi buruk.

PHBS: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, pola perilaku untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, termasuk sanitasi dan higiene untuk pencegahan infeksi.

PKH: Program Keluarga Harapan, bantuan tunai bersyarat untuk keluarga berisiko stunting guna mendukung akses nutrisi dan kesehatan.

PMT: Pemberian Makanan Tambahan, makanan pemulihan bergizi untuk ibu hamil KEK atau balita gizi kurang.

Posyandu: Pos Pelayanan Terpadu, fasilitas kesehatan masyarakat tingkat desa untuk pemantauan pertumbuhan, imunisasi, dan edukasi gizi.

Puskesmas: Pusat Kesehatan Masyarakat, unit pelayanan kesehatan primer yang menyelenggarakan intervensi gizi dan kebidanan.

Stunting: Kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, ditandai dengan tinggi badan di bawah -2 standar deviasi (SD) menurut standar WHO.

TTD: Tablet Tambah Darah, suplementasi zat besi dan asam folat minimal 90 tablet selama kehamilan untuk mencegah anemia.

WUS: Wanita Usia Subur, wanita usia 15-49 tahun yang menjadi sasaran intervensi pra-kehamilan untuk pencegahan stunting.

PROFIL PENULIS



Sulikah, S.ST., M.Kes. Penulis Lahir di Madiun 23 Juni 1968. Penulis adalah Dosen Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Pendidikan kesehatan dimulai dari Sekolah Perawat Kesehatan Magetan lulus Tahun 1987, Program Pendidikan Bidan A lulus Tahun 1989, AKPER Soetopo lulus Tahun 1995, D4 Perawat Pendidik UNAIR lulus Tahun 2000, D3 Kebidanan Soetomo Poltekkes Kemenkes Surabaya lulus Tahun 2005, Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro lulus Tahun 2011.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ikahsulikah3@gmail.com.

Buku yang pernah ditulis antara lain: Modul Ajar Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Modul Praktikum Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Buku Ajar Asuhan Persalinan Berbasis *Evidence Based*, Bunga Rampai Hypnoterapi pada Asuhan Kebidanan, Bunga Rampai Deteksi Dini dan Pencegahan Komplikasi dalam Siklus Reproduksi Perempuan.

Penulis memiliki ketertarikan di bidang kebidanan dan aktif sebagai peneliti dan menulis artikel jurnal ilmiah bidang kesehatan. Penulis sebagai Anggota IBI Kabupaten Magetan. Penulis berkeinginan mengembangkan Ilmu Kebidanan melalui beberapa buku yang ditulis. Semoga bermanfaat bagi pembaca baik mahasiswa maupun Dosen Kebidanan serta masyarakat umum.



Bdn. Jumriani, S.ST., M.Keb. lahir di Ambon pada tanggal 26 April 1991 dari pasangan orang tua bernama Hi. Royo Hamdan yang berasal dari Makassar dan Hj. Sukmawati., Jum panggilan kecil penulis terlahir sebagai anak Pertama dari dua bersaudara. Penulis menempuh pendidikan SD di SD 14 Berau (lulus tahun 2002), SMP di SMP Negeri 14 Ambon (lulus tahun 2005) dan SMA di SMA Negeri 1 Tobelo (lulus tahun 2008). Pendidikan DIII Kebidanan diselesaikan di Akademi Kebidanan Nusantara Jaya, lulus tahun 2012. Pendidikan DIV diselesaikan di Makassar pada STIKES Mega Rezky Makassar, jurusan DIV Bidan Pendidik, lulus tahun 2014. Pendidikan Magister (S2) di

Fakultas Kedokteran jurusan Kebidanan (2016-2018) kemudian melanjutkan pendidikan Profesi bidan pada universitas megarezky Makassar Tahun 2022, Dan pada tahun 2023 melanjutkan pendidikan doctoral pada universitas hasanuddin Makassar program studi Ilmu Kedokteran. Saat ini Bekerja sebagai Dosen tetap program studi diploma III Kebidanan di Politeknik Muhammad Dahlan Kota Bima. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rjum83247@gmail.com



PROFIL PENULIS



Dwi Ardani Rochmaniah, SST., M.Keb. Lahir di Madiun, 30 Maret 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada program studi D3 Kebidanan, Stikes Muhammadiyah Klaten tahun 2009. S1 pada Program Studi D4 Kebidanan Klinik, Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Kebidanan, Universitas Aisyiyah Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2019. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bhakti Hasta Mulia Madiun, mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan, Askeb Kehamilan, Obstetri. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Pengabdian masyarakat, Penelitian, dll. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dwiardani.rochmaniah@gmail.com
Motto: **"From Zero to Hero"**



Sendy Pratiwi Rahmadhani, S.ST., Bdn., M.Keb., Lahir di Padang tanggal 30 Maret 1992. Saat ini aktif sebagai Dosen pada Program Studi Strata-1 Kebidanan Fakultas Kebidanan dan Keperawatan Universitas Kader Bangsa Palembang. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Diploma-3 Kebidanan STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang (tahun 2013), Diploma-4 Bidan Pendidik STIKes Fort de Kock Bukittinggi (tahun 2014), Magister Ilmu Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (tahun 2019) dan pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kebidanan dan Keperawatan Universitas Kader Bangsa (tahun 2022). Penulis dapat dihubungi melalui email: rahmadhanisendypratiwi@gmail.com. Motto: **"be like water, not luxurious but valuable for life"**



PROFIL PENULIS



Veryudha Eka Prameswari, SST., M.Kes. Lahir di Banyuwangi, 4 Juli 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Kebidanan, Stikes Husada Jombang pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan D4 Kebidanan pada Stikes Husada Jombang dan lulus tahun pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan kembali pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret dan lulus tahun pada tahun 2012. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2007 - 2013 di Stikes Dian Husada Mojokerto. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto sejak 2014 hingga sekarang. mengampu mata kuliah Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan, Asuhan Kebidanan Persalinan, Komplementer dasar, Komplementer ibu, Etikolegal dan Pelayanan Kebidanan, Promosi Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pada organisasi IBI penulis sebagai pengurus dibidang SIE Pendidikan dan Pelatihan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: veryudhaekap@gmail.com



Heni Elmiani Sari, SST., M.PH Lahir di Yogyakarta, 13 Oktober 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Bidan Pendidik di Universitas Respati Yogyakarta lulus Tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Negeri Surakarta (UNS) dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 di Akbid Kutai Husada Tenggarong sebagai dosen tetap, dan bekerja sebagai bidan pelaksana di PMB Hj. Lidia Endang. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Borneo Medistra Balikpapan dari Tahun 2017 hingga saat ini dan mengampu mata kuliah Askeb Nifas, Askeb Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, penulis juga sebagai bidan Tim Pendamping keluarga di Kota Balikpapan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: heni@poltekborneomedistra.ac.id

Motto: "Menulis Bukan Sekedar Mengajar, Tetapi Menyalakan Rasa Ingin Tahu"



PROFIL PENULIS



Bdn. Riska Afriani, S.Tr.Keb., M.Kes,CH,CHE, Lahir di Lubuk Pakam, 24 April 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Kebidanan Di STIKes Medistra Lubuk Pakam Tahun 2014, Kemudian Melanjutkan Pendidikan D4 di Institut Helvetia Medan dan Lulus Tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Di Universitas Respati Indonesia Pada Tahun 2019. Tahun 2015 Bekerja di Balai Pengobatan Swasta. Saat ini penulis bekerja di STIKes Pekanbaru Medical Center sebagai dosen tetap dan mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan KB dan Kebijakan dalam pelayanan kebidanan. Penulis Aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan

Tinggi yaitu sebagai penulis Buku, Publikasi, Seminar, Pelatihan Peluang Usaha Dan Membuka outlet SPA serta sebagai terapis. Penulis dapat dihubungi melalui email: Ikaafriani2493@gmail.com. Motto: "Ilmu Pengetahuan Ibarat Padang Pasir dan Bintang di Malam yang Gelap, Untuk Itu Kejarlah Ilmu Sekuat Daya dan Upaya"



Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes. Lahir di Grobogan, 05 Maret 1970. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Kebidanan Poltekkes Tasikmalaya dan lulus tahun 2005, kemudian melanjutkan ke jenjang D4 Program Studi Sarjana Sains Terapan Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta dan lulus tahun 2007. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Respati Indonesia pada tahun 2013.

Riwayat pekerjaan penulis dimulai setelah lulus D3 sebagai bidan praktik di berbagai fasilitas kesehatan dasar, kemudian bergabung sebagai tenaga pengajar di institusi pendidikan kesehatan. Saat ini penulis menjabat sebagai Rektor sekaligus dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, mengampu mata kuliah Kesehatan Reproduksi & Keluarga Berencana (Kespro & KB), Kesehatan Dasar Pada Kehamilan (KDPK), serta Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengamalan Al-Islam Kemuhammadiyah. Penulis telah menghasilkan berbagai penelitian di bidang kesehatan reproduksi remaja dan anemia gizi besi, serta aktif melakukan pengabdian masyarakat melalui edukasi kesehatan di sekolah-sekolah dan komunitas. Selain itu, penulis rutin mempublikasikan karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi, serta menulis buku dan modul pembelajaran untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: srimusfiroh052@gmail.com

Motto: "Menjadi manusia yang berguna untuk orang lain"

Sinopsis

Buku "Bunga Rampai Asuhan Kebidanan Dasar: Panduan Praktis untuk Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir" hadir sebagai rujukan yang memadukan konsep dasar dan langkah-langkah praktik kebidanan secara sistematis, ringkas, dan mudah dipahami. Disusun dalam bentuk bunga rampai, buku ini menyajikan pembahasan yang beragam namun tetap terarah, sehingga membantu pembaca memahami asuhan kebidanan sebagai layanan yang berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga perawatan bayi baru lahir.

Pada bagian kehamilan, buku ini mengulas prinsip pengkajian ibu hamil, pemantauan kondisi maternal, edukasi kesehatan, serta deteksi dini tanda bahaya untuk mencegah komplikasi. Memasuki fase persalinan, pembaca dibimbing memahami dukungan fisik dan psikologis, komunikasi efektif, pemantauan kemajuan persalinan, serta tindakan dasar yang menunjang keselamatan ibu dan bayi. Selanjutnya, pada masa nifas dan menyusui, buku ini menekankan pentingnya pemulihan ibu, perawatan luka, pencegahan infeksi, pemantauan kondisi psikologis, serta pendampingan menyusui yang benar. Pada bagian perawatan bayi baru lahir, dibahas kebutuhan dasar neonatus, pemantauan adaptasi awal kehidupan, perawatan harian, dan pengenalan tanda bahaya yang perlu penanganan segera.

Lebih dari sekadar panduan teknis, buku ini juga menggarisbawahi nilai-nilai profesionalisme bidan, komunikasi terapeutik, keterlibatan keluarga, serta pendekatan pelayanan yang berpusat pada pasien. Dengan bahasa yang jelas dan orientasi pada praktik, buku ini cocok digunakan sebagai pegangan belajar bagi mahasiswa kebidanan, referensi pengajaran bagi dosen, serta panduan penyegaran bagi praktisi bidan dan tenaga kesehatan di layanan maternal-neonatal. Buku ini diharapkan mampu mendukung peningkatan mutu pelayanan kebidanan dan berkontribusi pada upaya menjaga keselamatan serta kesejahteraan ibu dan bayi.

Buku “Bunga Rampai Asuhan Kebidanan Dasar: Panduan Praktis untuk Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir” hadir sebagai rujukan yang memadukan konsep dasar dan langkah-langkah praktik kebidanan secara sistematis, ringkas, dan mudah dipahami. Disusun dalam bentuk bunga rampai, buku ini menyajikan pembahasan yang beragam namun tetap terarah, sehingga membantu pembaca memahami asuhan kebidanan sebagai layanan yang berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga perawatan bayi baru lahir.

Pada bagian kehamilan, buku ini mengulas prinsip pengkajian ibu hamil, pemantauan kondisi maternal, edukasi kesehatan, serta deteksi dini tanda bahaya untuk mencegah komplikasi. Memasuki fase persalinan, pembaca dibimbing memahami dukungan fisik dan psikologis, komunikasi efektif, pemantauan kemajuan persalinan, serta tindakan dasar yang menunjang keselamatan ibu dan bayi. Selanjutnya, pada masa nifas dan menyusui, buku ini menekankan pentingnya pemulihan ibu, perawatan luka, pencegahan infeksi, pemantauan kondisi psikologis, serta pendampingan menyusui yang benar. Pada bagian perawatan bayi baru lahir, dibahas kebutuhan dasar neonatus, pemantauan adaptasi awal kehidupan, perawatan harian, dan pengenalan tanda bahaya yang perlu penanganan segera.

Lebih dari sekadar panduan teknis, buku ini juga menggarisbawahi nilai-nilai profesionalisme bidan, komunikasi terapeutik, keterlibatan keluarga, serta pendekatan pelayanan yang berpusat pada pasien. Dengan bahasa yang jelas dan orientasi pada praktik, buku ini cocok digunakan sebagai pegangan belajar bagi mahasiswa kebidanan, referensi pengajaran bagi dosen, serta panduan penyegaran bagi praktisi bidan dan tenaga kesehatan di layanan maternal-neonatal. Buku ini diharapkan mampu mendukung peningkatan mutu pelayanan kebidanan dan berkontribusi pada upaya menjaga keselamatan serta kesejahteraan ibu dan bayi.

ISBN 978-634-7556-54-7



Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

